

AIR Question Set

ภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน และโรคข้อรูมาติก — ข้อสอบสร้างใหม่ 50 ข้อ พร้อม
คลังข้อสอบเก่า

ชุดข้อสอบ	MCQ 50 ข้อ · MEQ 4 ชุด · OSCE / SAQ 6 สถานี
คลังข้อสอบเก่า	50 ข้อ สกัดจาก MED28 – MED35
แยกตาม	Lecture ของ MED421/422 กลุ่มที่ 3 (C+D) รพ.ราชวิถี
รูปแบบข้อ	โจทย์ภาษาอังกฤษ 5 ตัวเลือก · เฉลยและคำอธิบายภาษาไทย
หลักการออกข้อ	ทุกตัวเลือกมีเหตุผลรองรับ แต่ถูกเพียงข้อเดียว
ระบบนี้	3 คาบบรรยาย · Allergy/Immunology/Rheumatology — แพ้ยา anaphylaxis · gout/CPPD/septic arthritis · SLE RA vasculitis myositis

สารบัญ ส่วนที่ 1 ข้อสอบใหม่ (โจทย์) · ส่วนที่ 2 เฉลยและคำอธิบาย · ส่วนที่ 3 คลังข้อสอบเก่าแยกตาม lecture

คำเฉลยในโพยเก่าบางข้อไม่ตรงกับแนวทางเวชปฏิบัติปัจจุบัน จุดที่ต่างถูกทำเครื่องหมายไว้ในคำอธิบาย เอกสารนี้ใช้ทบทวน
ประกอบตำราและแนวทางเวชปฏิบัติ ไม่ใช่เอกสารทางการของหลักสูตร

ส่วนที่ 1 • ข้อสอบ

ทำโดยยังไม่ดูเฉลย — เฉลยอยู่ในส่วนที่ 2

Part 1 • MCQ — เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ (50 ข้อ)

1. AIR-MCQ-01 • Lec 08 • Allergy and clinical immunology

Anaphylaxis — first-line treatment

A 24-year-old woman develops generalized urticaria, lip swelling, hoarseness and wheezing 10 minutes after eating shrimp. PE: T 37.0 C, PR 124/min, RR 28/min, BP 82/50 mmHg, SpO2 93% room air, diffuse wheezing and angioedema of the lips. Which of the following is the most appropriate immediate treatment?

- A. Intramuscular adrenaline 0.3–0.5 mg (1:1,000) into the anterolateral thigh
- B. Nebulized salbutamol 2.5 mg
- C. Intravenous chlorpheniramine 10 mg
- D. Subcutaneous adrenaline 0.3 mg into the upper arm
- E. Intravenous dexamethasone 5 mg

2. AIR-MCQ-02 • Lec 08 • Allergy and clinical immunology

Anaphylaxis — discharge plan

A 19-year-old man is observed for 6 hours after a severe anaphylactic reaction to peanuts that responded to intramuscular adrenaline. He is now asymptomatic with normal vital signs and is ready for discharge. Which of the following is the most appropriate discharge plan?

- A. Prescribe an adrenaline auto-injector with training, a written action plan and allergist referral
- B. Prescribe a 2-week tapering course of oral prednisolone
- C. Prescribe a daily second-generation antihistamine indefinitely
- D. Arrange immediate peanut oral challenge in the outpatient clinic to confirm the allergen
- E. Advise that no specific medication is needed because the reaction has fully resolved

3. AIR-MCQ-03 • Lec 08 • Allergy and clinical immunology

Hypersensitivity classification

A 27-year-old woman develops itchy wheals over the trunk within 20 minutes of taking a first dose of amoxicillin. The lesions are transient, each lasting less than 24 hours, and resolve completely without scarring. Which immunologic mechanism best explains this reaction?

- A. Type IVa — T helper 1 cell and macrophage activation
- B. Type IVc — cytotoxic T cell mediated keratinocyte death
- C. Type III — immune complex deposition with complement activation
- D. Type I — IgE-mediated mast cell degranulation
- E. Type II — IgG antibody directed against cell-surface antigen

Chronic spontaneous urticaria

A 32-year-old woman has had daily itchy wheals for 8 months. Individual lesions last less than 24 hours and leave no bruising. She has no fever, arthralgia or weight loss, and no identifiable trigger. A standard dose of a second-generation antihistamine gives only partial relief. Which of the following is the most appropriate next step?

- A. Switch to a first-generation sedating antihistamine at bedtime only
- B. Order an extensive allergy panel including food-specific IgE for 40 foods
- C. Increase the second-generation antihistamine up to fourfold the standard dose
- D. Perform skin biopsy in every patient before escalating treatment
- E. Start long-term daily prednisolone 10 mg

ACE inhibitor angioedema

A 58-year-old man with hypertension treated with enalapril for 2 years presents with painless swelling of the lips and tongue for 6 hours. There is no urticaria and no itching. He denies new foods or drugs. PE: T 37.0 C, PR 88/min, BP 150/90 mmHg, no wheeze, no rash, tongue swollen without airway compromise at present. Which of the following is the most appropriate management?

- A. Perform skin prick testing to enalapril to confirm the diagnosis
- B. Stop enalapril permanently, monitor the airway closely and switch to a different antihypertensive class
- C. Switch enalapril to losartan and continue long-term antihistamine
- D. Continue enalapril and add a second-generation antihistamine
- E. Give high-dose intravenous hydrocortisone, which reliably reverses the swelling

Allopurinol hypersensitivity and HLA screening

A 55-year-old Thai man with gout and stage 3 chronic kidney disease is about to start urate-lowering therapy with allopurinol. Which of the following tests should be performed before starting the drug to reduce the risk of severe cutaneous adverse reaction?

- A. HLA-B*58:01 genotyping
- B. HLA-B*57:01 genotyping
- C. HLA-B*15:02 genotyping
- D. Serum tryptase level
- E. Allopurinol skin prick test

Stevens-Johnson syndrome / TEN

A 46-year-old woman develops fever and a painful rash 3 weeks after starting phenytoin. PE: T 38.8 C, dusky targetoid macules coalescing over the trunk with epidermal detachment of about 12% of body surface area, positive Nikolsky sign, erosions of the lips, oral mucosa and conjunctivae. Which of the following is the most important immediate management?

- A. Apply potent topical corticosteroid to the detached areas and discharge with follow-up
- B. Stop phenytoin immediately and transfer for intensive supportive care with fluid, wound and eye care
- C. Start high-dose intravenous immunoglobulin as the definitive treatment before stopping the drug
- D. Continue phenytoin because the seizure risk outweighs the skin reaction
- E. Start empirical intravenous antibiotics prophylactically in all patients

DRESS syndrome

A 40-year-old man develops fever and a diffuse maculopapular rash 5 weeks after starting allopurinol. PE: T 39.0 C, generalized morbilliform rash with facial edema and cervical lymphadenopathy. Lab: WBC 14,800/mm³ with eosinophils 18%, atypical lymphocytes present, AST/ALT 320/410 U/L, creatinine 1.6 mg/dL (baseline 1.0). Which of the following is the most likely diagnosis?

- A. Simple morbilliform drug eruption
- B. Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS)
- C. Adult-onset Still disease
- D. Stevens-Johnson syndrome
- E. Acute generalized exanthematous pustulosis

Penicillin allergy de-labeling

A 30-year-old woman needs treatment for acute pyelonephritis. Her record says 'penicillin allergy' because she had a non-pruritic maculopapular rash at age 5 while taking amoxicillin for pharyngitis, with no swelling, no breathing difficulty and no hospitalization. Which of the following statements is most accurate?

- A. Desensitization is required before any beta-lactam can be used in this patient
- B. She should receive prophylactic corticosteroid and antihistamine before any beta-lactam
- C. She must avoid all beta-lactam antibiotics for life, including cephalosporins and carbapenems
- D. A childhood benign maculopapular rash is a low-risk history, and she can receive a cephalosporin or be evaluated for penicillin de-labeling
- E. The risk of anaphylaxis from cephalosporin in this patient exceeds 10 percent

Acute hemolytic transfusion reaction

A 62-year-old woman receiving packed red cells develops fever 39.0 C, chills, flank pain and dark red urine 15 minutes after the transfusion starts. BP 88/54 mmHg, PR 124/min. Which of the following is the most appropriate immediate action?

- A. Stop the transfusion and give intramuscular adrenaline as the first drug
- B. Stop the transfusion immediately, keep the intravenous line open with normal saline and send blood and the unit for investigation
- C. Change to leukocyte-poor red cells and restart immediately
- D. Slow the transfusion rate and give intravenous paracetamol and chlorpheniramine
- E. Continue the transfusion and give furosemide to protect the kidney

Allergic transfusion reaction

A 28-year-old man with thalassemia develops itchy urticarial wheals over the chest 15 minutes into a packed red cell transfusion. He has no fever, no dyspnea, normal blood pressure and normal urine colour. Which of the following is the most appropriate management?

- A. Continue the transfusion at the same rate and give paracetamol
- B. Give intravenous furosemide for suspected circulatory overload
- C. Stop the transfusion permanently and report acute hemolytic transfusion reaction
- D. Give intramuscular adrenaline and admit to intensive care
- E. Pause the transfusion, give an antihistamine, and resume slowly if the wheals resolve and no other symptom appears

Vaccination in the immunosuppressed

A 45-year-old woman with systemic lupus erythematosus takes prednisolone 30 mg daily and azathioprine. She asks about vaccination before the rainy season. Which of the following is most appropriate?

- A. Give varicella vaccine now to prevent zoster during immunosuppression
- B. Give live attenuated influenza vaccine because it gives better mucosal immunity
- C. Withhold all vaccines until prednisolone is completely stopped
- D. Give measles-mumps-rubella vaccine now because she was never vaccinated as a child
- E. Give inactivated influenza vaccine now and defer live attenuated vaccines while she is immunosuppressed

Primary immunodeficiency clue in an adult

A 24-year-old man has had four episodes of bacterial pneumonia and two episodes of bacterial sinusitis in the past 2 years, plus chronic diarrhea from giardiasis. He is HIV-negative. CBC shows normal white cell count and differential. Which of the following is the most appropriate next investigation?

- A. Total hemolytic complement (CH50) as the single first-line test
- B. Nitroblue tetrazolium or dihydrorhodamine test for neutrophil oxidative burst
- C. Bone marrow aspiration and biopsy
- D. Repeat HIV testing every month for 6 months
- E. Serum immunoglobulin levels (IgG, IgA, IgM)

Acute monoarthritis — first investigation

A 58-year-old man presents with a hot, swollen, exquisitely tender right knee for 2 days and fever 38.5 C. He has had three similar self-limited episodes in the past 2 years. He cannot bear weight. Which of the following is the most appropriate initial investigation?

- A. Arthrocentesis for synovial fluid cell count, crystal examination and Gram stain with culture
- B. Blood culture alone before any joint procedure
- C. Serum uric acid level
- D. Magnetic resonance imaging of the right knee
- E. Plain radiograph of both knees

Synovial fluid crystal identification — gout

Synovial fluid from an acutely inflamed first metatarsophalangeal joint shows 28,000 WBC/mm³ with 85% neutrophils, and polarized light microscopy reveals needle-shaped crystals that are strongly negatively birefringent (yellow when parallel to the compensator axis). Which of the following is the most likely diagnosis?

- A. Septic arthritis
- B. Acute gouty arthritis
- C. Rheumatoid arthritis
- D. Calcium pyrophosphate deposition disease (pseudogout)
- E. Reactive arthritis

Pseudogout — CPPD

A 74-year-old woman has acute pain and swelling of the right knee. Synovial fluid shows 18,000 WBC/mm³ and rhomboid-shaped crystals that are weakly positively birefringent. Plain radiograph shows linear calcification of the meniscal cartilage. Which of the following is the most likely diagnosis and the associated metabolic condition to screen for?

- A. Osteoarthritis with effusion; screen for obesity and previous joint injury
- B. Calcium pyrophosphate deposition disease; screen for hyperparathyroidism, hemochromatosis and hypomagnesemia
- C. Gout; screen for chronic kidney disease and diuretic use
- D. Septic arthritis; screen for diabetes mellitus and intravenous drug use
- E. Basic calcium phosphate (hydroxyapatite) disease; screen for hyperphosphatemia in dialysis patients

Acute gout — first-line treatment

A 52-year-old man with an acute gout flare of the left ankle for 18 hours has stage 2 chronic kidney disease (eGFR 68 mL/min/1.73 m²), well-controlled hypertension and peptic ulcer disease treated 6 months ago. He takes no urate-lowering therapy. Which of the following is the most appropriate treatment for this flare?

- A. Intravenous colchicine 2 mg
- B. Oral colchicine or a short course of oral prednisolone
- C. Start allopurinol 300 mg daily alone to lower the serum urate quickly
- D. High-dose indomethacin for 10 days
- E. Aspirin 300 mg three times daily

Urate-lowering therapy — indication and target

A 49-year-old man has had four gout flares in the past year and a tophus over the right elbow. Serum urate is 9.2 mg/dL, creatinine 1.1 mg/dL. His last flare resolved 3 weeks ago. Which of the following is the most appropriate management?

- A. Start probenecid as first-line therapy regardless of urinary urate excretion
- B. Treat flares as they occur and avoid urate-lowering therapy because his renal function is normal
- C. Start allopurinol 300 mg daily immediately without prophylaxis and stop when urate normalizes
- D. Start allopurinol at a low dose with anti-inflammatory prophylaxis and titrate to a serum urate below 6 mg/dL
- E. Restrict purine-rich food alone, which reliably lowers serum urate below 6 mg/dL

Drug-induced hyperuricemia

A 45-year-old man on the intensive phase of anti-tuberculous treatment develops an acutely painful, swollen right first metatarsophalangeal joint at week 6. Serum uric acid is 11 mg/dL. Which drug in his regimen is most responsible for this problem?

- A. Streptomycin
- B. Rifampicin
- C. Pyrazinamide
- D. Levofloxacin
- E. Isoniazid

Septic arthritis — organism and initial therapy

A 63-year-old man with diabetes has a hot swollen left knee and fever for 2 days. Synovial fluid shows 78,000 WBC/mm³ with 93% neutrophils, no crystals, and Gram stain shows gram-positive cocci in clusters. Which of the following is the most appropriate initial management?

- A. Oral dicloxacillin as an outpatient with follow-up in 1 week
- B. Joint drainage plus intravenous cloxacillin
- C. Colchicine plus intravenous fluids while awaiting culture
- D. Intra-articular corticosteroid injection plus oral NSAID
- E. Intravenous ceftriaxone alone without drainage

Beta-lactam induced neutropenia

The same patient improves clinically on intravenous cloxacillin. On day 12 of therapy he is afebrile with a normal-looking knee, but routine CBC shows WBC 2,800/mm³ with absolute neutrophil count 900/mm³ (previously normal). There is no new fever or mucosal ulcer. Which of the following is the most appropriate management?

- A. Recognize drug-induced neutropenia, change to an alternative antibiotic class and monitor the blood count
- B. Stop all antibiotics immediately and observe off therapy
- C. Start granulocyte colony-stimulating factor and continue cloxacillin
- D. Perform bone marrow biopsy before making any change to therapy
- E. Continue the same dose of cloxacillin and repeat the CBC in 1 month

Osteoarthritis of the knee — first-line management

A 64-year-old woman with BMI 31 kg/m² has bilateral knee pain worse with walking and improving with rest, with morning stiffness of 10 minutes and crepitus. There is no warmth or effusion. Radiographs show joint space narrowing and osteophytes. Which of the following is the most appropriate first-line management?

- A. Long-term oral corticosteroid
- B. Intra-articular hyaluronic acid injection as first-line therapy
- C. Long-term opioid analgesia
- D. Early referral for total knee arthroplasty
- E. Structured exercise, quadriceps strengthening and weight reduction, with topical NSAID for pain

Osteoarthritis versus rheumatoid arthritis

A 55-year-old woman has painful hands. Which of the following findings best distinguishes rheumatoid arthritis from osteoarthritis?

- A. Joint space narrowing on radiograph
- B. Pain that worsens with use and improves with rest
- C. Bony enlargement of the distal interphalangeal joints
- D. Symmetric swelling of the metacarpophalangeal and proximal interphalangeal joints with morning stiffness lasting more than 1 hour
- E. Crepitus on joint movement

Soft-tissue rheumatism

A 42-year-old woman who cares for her newborn grandchild has pain over the radial side of the right wrist. Pain is reproduced when she flexes the thumb into the palm and deviates the wrist to the ulnar side (Finkelstein test). There is no joint swelling and no morning stiffness. Which of the following is the most likely diagnosis?

- A. De Quervain tenosynovitis
- B. Gouty arthritis of the wrist
- C. Rheumatoid arthritis of the wrist
- D. First carpometacarpal joint osteoarthritis
- E. Carpal tunnel syndrome

Reactive arthritis

A 26-year-old man develops asymmetric pain and swelling of the right knee and left ankle 3 weeks after an episode of bloody diarrhea. He also has conjunctivitis and dysuria without urethral discharge. Synovial fluid shows 15,000 WBC/mm³, no crystals, and sterile culture. Which of the following is the most likely diagnosis?

- A. Rheumatoid arthritis
- B. Acute gouty arthritis
- C. Septic arthritis from Salmonella
- D. Reactive arthritis
- E. Systemic lupus erythematosus

Asymptomatic hyperuricemia

A 46-year-old man has a serum uric acid of 8.4 mg/dL found on a health check-up. He has never had joint pain, tophi or kidney stones. Renal function is normal. Which of the following is the most appropriate management?

- A. Start allopurinol to prevent future gout in all patients with uric acid above 8 mg/dL
- B. Start colchicine prophylaxis indefinitely
- C. Lifestyle advice and periodic follow-up without urate-lowering drug therapy
- D. Perform joint ultrasound of every large joint annually
- E. Start probenecid and increase fluid intake

Chronic tophaceous gout

A 68-year-old man with untreated gout for 15 years has firm, chalky white nodules over the olecranon and the helix of the ear, and deformed fingers. Radiograph of the hand shows well-defined 'punched-out' erosions with sclerotic margins and overhanging edges, with preserved joint space until late. Which of the following best explains these radiographic findings?

- A. Pannus formation from proliferating synovium causing marginal erosion with early joint space loss
- B. Deposition of monosodium urate aggregates in and around bone that erode cortex while cartilage is relatively spared
- C. Direct bacterial destruction of subchondral bone
- D. Periarticular osteopenia from local inflammatory cytokines
- E. Subchondral bone sclerosis and osteophyte formation from mechanical overload

Polyarticular gout in the elderly

A 76-year-old woman on hydrochlorothiazide for hypertension has a 6-month history of pain and swelling of multiple small joints of both hands, including some distal interphalangeal joints, with firm nodules over the finger pads. RF and anti-CCP are negative. Aspiration of a nodular joint shows negatively birefringent needle-shaped crystals. Which of the following is the most likely diagnosis?

- A. Seronegative rheumatoid arthritis
- B. Polyarticular tophaceous gout mimicking rheumatoid arthritis
- C. Calcium pyrophosphate deposition disease
- D. Psoriatic arthritis
- E. Erosive osteoarthritis of the hands

Gout with chronic kidney disease

A 60-year-old man with gout and stage 4 chronic kidney disease (eGFR 24 mL/min/1.73 m²) needs urate-lowering therapy. HLA-B*58:01 is negative. Which of the following is the most appropriate approach?

- A. Give repeated courses of high-dose NSAID instead of urate-lowering therapy
- B. Start allopurinol 300 mg daily, the standard dose regardless of renal function
- C. Start probenecid as the preferred agent in chronic kidney disease
- D. Avoid all urate-lowering therapy because of the renal impairment
- E. Start allopurinol at 50 mg daily and titrate slowly with monitoring, aiming for urate below 6 mg/dL

Osteoporosis after fragility fracture

A 68-year-old woman sustains a wrist fracture after falling from standing height. She has taken prednisolone 7.5 mg daily for 3 years for rheumatoid arthritis. Bone mineral density T-score at the femoral neck is -2.7. Serum calcium, phosphate and creatinine are normal. Which of the following is the most appropriate management?

- A. Start calcitonin nasal spray as first-line therapy
- B. Start an oral bisphosphonate with calcium and vitamin D, and review the need for continued corticosteroid
- C. Start calcium and vitamin D supplements alone
- D. Start denosumab only after two further fragility fractures
- E. Repeat bone mineral density in 2 years before starting any drug

Diagnosis of systemic lupus erythematosus

A 24-year-old woman has 3 months of fatigue, malar rash sparing the nasolabial folds, painless oral ulcers, and symmetric arthritis of the hands without erosion. Lab: WBC 3,100/mm³, lymphocyte 800/mm³, platelet 130,000/mm³, urinalysis protein 2+, RBC 15–20/HPF with red cell casts. Which of the following investigations best supports the diagnosis?

- A. Rheumatoid factor and anti-cyclic citrullinated peptide antibody
- B. Antinuclear antibody with anti-double-stranded DNA and complement C3/C4 levels
- C. Serum uric acid and synovial fluid crystal analysis
- D. Antineutrophil cytoplasmic antibody with anti-glomerular basement membrane antibody
- E. Anti-Jo-1 antibody and creatine kinase

Lupus nephritis — indication for renal biopsy

A 26-year-old woman with newly diagnosed SLE has urine protein-to-creatinine ratio 1.8 g/g, active urine sediment with red cell casts, and creatinine 1.3 mg/dL (was 0.8 mg/dL 4 months ago). Which of the following is the most appropriate next step?

- A. Percutaneous renal biopsy to determine the class of lupus nephritis before immunosuppressive therapy
- B. Start pulse methylprednisolone and cyclophosphamide without biopsy in all cases
- C. Repeat anti-double-stranded DNA and treat only if the titre is rising
- D. Start an ACE inhibitor and repeat the urine studies in 6 months
- E. Refer for dialysis planning

Drug-induced lupus

A 62-year-old man treated with hydralazine for 8 months develops fever, arthralgia and pleuritic chest pain. ANA is positive at 1:640 in a homogeneous pattern, anti-histone antibody is positive, anti-double-stranded DNA is negative, and C3/C4 are normal. Renal function and urinalysis are normal. Which of the following is the most appropriate management?

- A. Start cyclophosphamide because pleural involvement indicates severe lupus
- B. Start hydroxychloroquine and continue hydralazine at a lower dose
- C. Start high-dose prednisolone with mycophenolate and continue hydralazine
- D. Stop hydralazine; symptoms usually resolve over weeks, with NSAID or short-course corticosteroid if needed
- E. Perform renal biopsy before any change in therapy

Antiphospholipid syndrome — investigation

A 32-year-old woman has had three unexplained first-trimester miscarriages and one fetal death at 22 weeks. She also had an unprovoked deep vein thrombosis 2 years ago. Which of the following laboratory tests should be ordered to confirm the suspected diagnosis?

- A. Anti-SSA (Ro) and anti-SSB (La) antibodies
- B. Factor V Leiden mutation alone
- C. Antineutrophil cytoplasmic antibody
- D. Lupus anticoagulant, anticardiolipin antibody and anti-beta-2-glycoprotein I, repeated at least 12 weeks apart
- E. Anti-histone antibody and complement levels

Obstetric antiphospholipid syndrome — management

The same patient is now 6 weeks pregnant. Antiphospholipid antibodies were positive on two occasions 12 weeks apart. Which of the following is the most appropriate management during this pregnancy?

- A. No therapy because antiphospholipid antibodies do not affect pregnancy outcome
- B. Warfarin with a target INR of 2 to 3 throughout pregnancy
- C. High-dose prednisolone throughout pregnancy
- D. Low-dose aspirin alone with no anticoagulation
- E. Low-dose aspirin plus prophylactic low-molecular-weight heparin throughout pregnancy and postpartum

Fever in a lupus patient on immunosuppression

A 30-year-old man with lupus nephritis on prednisolone 30 mg daily and mycophenolate presents with 1 week of dry cough, fever and progressive dyspnea. PE: T 38.6 C, RR 28/min, SpO₂ 88% on room air, clear breath sounds. CXR shows bilateral interstitial infiltrates. Lab: WBC 9,000/mm³ with lymphocyte 600/mm³, LDH 520 U/L. Which of the following is the most appropriate initial management?

- A. Perform bronchoscopy first and withhold all treatment until results return
- B. Increase prednisolone to 60 mg daily for a presumed lupus flare and observe
- C. Start intravenous cyclophosphamide for presumed lupus pneumonitis
- D. Start oral amoxicillin for community-acquired pneumonia and review in 1 week
- E. Treat empirically for *Pneumocystis jirovecii* pneumonia with trimethoprim-sulfamethoxazole and corticosteroid while confirming the diagnosis

Hydroxychloroquine retinopathy

A 38-year-old woman with SLE has taken hydroxychloroquine for 6 years. She is asymptomatic. Which of the following is the most appropriate monitoring plan for this drug?

- A. Annual audiometry because ototoxicity is the main concern
- B. No eye screening is required because hydroxychloroquine does not affect the eye
- C. Annual liver function tests only
- D. Baseline eye examination within the first year, then annual screening after 5 years using automated visual fields and optical coherence tomography
- E. Weekly complete blood count for the first year

Systemic sclerosis — autoantibody testing

A 45-year-old woman has 1 year of Raynaud phenomenon, thickening of the skin of the fingers extending to the forearms, and fine inspiratory crackles at both lung bases. ANA by immunofluorescence is reported negative at the screening dilution. Which of the following is the most appropriate next investigation?

- A. Anti-double-stranded DNA antibody
- B. Anti-histone antibody
- C. Rheumatoid factor
- D. Erythrocyte sedimentation rate alone
- E. Anti-topoisomerase I (anti-Scl-70) and anticentromere antibody testing with high-resolution CT of the chest

Scleroderma renal crisis

A 49-year-old woman with diffuse systemic sclerosis for 8 months, recently given prednisolone 20 mg daily for arthralgia, presents with headache and blurred vision. BP 220/130 mmHg, creatinine 3.2 mg/dL (was 0.9 mg/dL), platelet 88,000/mm³, blood smear shows schistocytes, urinalysis shows mild proteinuria without casts. Which of the following is the most appropriate treatment?

- A. Start pulse methylprednisolone and cyclophosphamide
- B. Start plasma exchange for thrombotic thrombocytopenic purpura
- C. Start a short-acting ACE inhibitor such as captopril and titrate rapidly
- D. Start amlodipine and arrange outpatient follow-up in 1 week
- E. Start intravenous nitroprusside and avoid ACE inhibitors because creatinine is rising

Raynaud phenomenon — primary versus secondary

A 20-year-old woman reports that her fingers turn white then blue then red in cold air, symmetrically in both hands, for 4 years. There is no digital ulcer or pitting scar, peripheral pulses are normal, ANA is negative and nailfold capillaroscopy is normal. Which of the following is the most appropriate management?

- A. Immediate treatment with intravenous iloprost
- B. Start warfarin to prevent digital thrombosis
- C. Refer for urgent digital sympathectomy
- D. Reassurance with cold avoidance and smoking avoidance; drug therapy only if symptoms interfere with daily life
- E. Start high-dose corticosteroid to prevent progression to systemic sclerosis

Inflammatory myopathy

A 52-year-old woman has 3 months of progressive difficulty climbing stairs and combing her hair, without pain. PE: symmetric proximal muscle weakness grade 3/5, violaceous rash over the eyelids and scaly erythematous papules over the knuckles. Lab: creatine kinase 4,200 U/L, AST 180 U/L, ALT 120 U/L. Which of the following is the most appropriate next step in addition to starting treatment?

- A. Serum uric acid and joint aspiration
- B. Bone mineral density as the first priority
- C. Age-appropriate malignancy screening, because dermatomyositis is strongly associated with occult cancer
- D. Nerve conduction study to confirm peripheral neuropathy
- E. Liver biopsy to evaluate the raised transaminases

Statin-associated muscle symptoms

A 58-year-old man with dyslipidemia on simvastatin 40 mg daily for 6 months complains of symmetric aching of the thigh and shoulder muscles for 3 weeks, without weakness or dark urine. Which of the following is the most appropriate initial investigation?

- A. Serum myoglobin only
- B. Muscle biopsy
- C. Electromyography
- D. Serum creatine kinase
- E. Anti-HMG-CoA reductase antibody as the first test

Polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis

A 72-year-old woman has 6 weeks of severe aching and morning stiffness of both shoulders and hips lasting 2 hours, with fatigue and low-grade fever. For 5 days she has had a new right temporal headache, scalp tenderness and pain in the jaw while chewing. ESR is 92 mm/hr. Vision is currently normal. Which of the following is the most appropriate immediate management?

- A. Start NSAID and physiotherapy for polymyalgia rheumatica
- B. Arrange temporal artery biopsy first and start corticosteroid only after the result
- C. Start low-dose prednisolone 15 mg daily and review in 2 weeks
- D. Start high-dose corticosteroid immediately and arrange temporal artery biopsy or vascular imaging without delaying treatment
- E. Start methotrexate as the initial treatment

ANCA-associated vasculitis

A 56-year-old man has 2 months of chronic sinusitis with bloody nasal discharge, then develops hemoptysis and acute kidney injury. Lab: creatinine 3.8 mg/dL, urinalysis protein 2+, dysmorphic RBC with red cell casts. CXR shows bilateral nodular infiltrates, some with cavitation. Which of the following is the most likely diagnosis?

- A. Systemic lupus erythematosus with lupus nephritis
- B. Community-acquired pneumonia with acute tubular necrosis
- C. Granulomatosis with polyangiitis (ANCA-associated vasculitis)
- D. Pulmonary tuberculosis with tuberculous glomerulonephritis
- E. Goodpasture disease from anti-glomerular basement membrane antibody

IgA vasculitis (Henoch-Schonlein purpura)

A 19-year-old man develops palpable purpura over both lower legs and buttocks 1 week after an upper respiratory tract infection, together with colicky abdominal pain and pain in both ankles. Lab: platelet 320,000/mm³, normal coagulation, urinalysis shows RBC 20-30/HPF with protein 1+. Which of the following is the most likely diagnosis?

- A. Immune thrombocytopenia
- B. Meningococcemia
- C. Disseminated intravascular coagulation
- D. Acute rheumatic fever
- E. IgA vasculitis (Henoch-Schonlein purpura)

Early rheumatoid arthritis — treatment

A 44-year-old woman has had symmetric swelling of the metacarpophalangeal and wrist joints with 90 minutes of morning stiffness for 10 weeks. RF and anti-CCP are positive, ESR 48 mm/hr, and radiographs show no erosion yet. Which of the following is the most appropriate management?

- A. Start a biologic agent as first-line therapy in all newly diagnosed patients
- B. Start long-term prednisolone 10 mg daily as the sole therapy
- C. Start methotrexate with folic acid promptly, using a short course of corticosteroid as a bridge
- D. Wait for radiographic erosions to appear before starting any disease-modifying therapy
- E. Start NSAID alone and reassess in 6 months before considering a DMARD

Methotrexate toxicity

A 50-year-old woman with rheumatoid arthritis on methotrexate 15 mg weekly for 2 years presents with fever, cough and progressive dyspnea for 2 weeks. CXR shows diffuse interstitial infiltrates. Lab: WBC 3,200/mm³, platelet 98,000/mm³, AST/ALT 95/110 U/L, creatinine 1.0 mg/dL. Which of the following is the most appropriate immediate management?

- A. Give folic acid only and repeat the chest radiograph in 1 month
- B. Start an anti-TNF agent immediately to control the underlying disease
- C. Increase methotrexate because the arthritis is likely flaring
- D. Continue methotrexate and add an inhaled corticosteroid
- E. Stop methotrexate, evaluate for both opportunistic infection and methotrexate pneumonitis, and give folinic acid if cytopenia is significant

Glucocorticoid complications — osteonecrosis

A 34-year-old woman with SLE who has received prednisolone 30–60 mg daily for 2 years develops progressive right groin pain, worse on weight bearing, for 6 weeks. Range of motion of the hip is painful at the extremes but the joint is not hot or swollen. ESR 20 mm/hr. Plain radiograph of the hip is normal. Which of the following is the most appropriate next investigation?

- A. Magnetic resonance imaging of both hips
- B. Hip joint aspiration for culture
- C. Dual-energy X-ray absorptiometry
- D. Bone scan of the whole skeleton as the definitive test
- E. Repeat plain radiograph in 3 months

Axial spondyloarthritis

A 27-year-old man has had low back pain for 18 months. The pain wakes him in the second half of the night, is associated with more than 45 minutes of morning stiffness, improves with exercise and worsens with rest. He had one episode of painful red eye with photophobia last year. Which of the following is the most appropriate initial management after confirming sacroiliitis?

- A. Bed rest for 2 weeks and opioid analgesia
- B. Methotrexate as first-line therapy for axial disease
- C. Systemic corticosteroid as long-term maintenance therapy
- D. Regular exercise and physiotherapy with a full-dose NSAID, escalating to a biologic if the response is inadequate
- E. Lumbar spine surgery

Adult-onset Still disease versus infection

A 28-year-old woman has 3 weeks of daily fever spiking to 39.5 C in the evening, a salmon-coloured evanescent rash appearing with the fever, sore throat, and arthralgia of the wrists and knees. Lab: WBC 19,000/mm³ with 88% neutrophils, ferritin 8,400 ng/mL, ESR 95 mm/hr, ANA and RF negative, blood cultures negative twice, echocardiography normal. Which of the following is the most likely diagnosis?

- A. Adult-onset Still disease
- B. Rheumatoid arthritis with extra-articular features
- C. Infective endocarditis
- D. Acute leukemia
- E. Systemic lupus erythematosus

Part 2 · MEQ — ข้อเขียนเคสต่อเนื่อง (4 ชุด)

MEQ 1. AIR-MEQ-01 · Lec 23 · Approach to arthritis / crystal and infective arthropathy

Acute monoarthritis — gout versus septic arthritis

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 52 ปี อาชีพขับรถบรรทุก มาห้องฉุกเฉินด้วยปวดเข้าขวามากจนเดินไม่ได้ 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล
PI: เมื่อคืนก่อนมามีงานเลี้ยง ดื่มเบียร์ประมาณ 6 ขวด ตื่นเช้ามาปวดเข้าขวามองแดงร้อน ปวดมากจนแตะไม่ได้ มีไข้ต่ำ ๆ เคยมีอาการแบบนี้ที่โคนนิ้วโป้งเท้าขวา 3 ครั้งใน 2 ปี แต่ละครั้งหายเองใน 5-7 วัน ไม่เคยตรวจรักษารึจริงจัง
U/D: ความดันโลหิตสูง กิน hydrochlorothiazide (25) 1x1 เข้า มา 3 ปี, ไขมันในเลือดสูง
ประวัติอื่น: ดื่มเบียร์ประจำ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีประวัติเพศสัมพันธ์นอกสมรส ไม่มีแผลหรือฝีที่ผิวหนัง ไม่มีประวัติฉีดยาเข้าเส้น
PE: GA: ผู้ป่วยชายรูปร่างท้วม ดูเจ็บปวดมาก BW 88 kg Ht 170 cm
V/S: BT 37.9 C, PR 96/min, RR 20/min, BP 148/92 mmHg, SpO2 98% room air
Extremities: เข้าขวามองแดงเป็นมัน ร้อน กดเจ็บมาก มี ballottement of patella บวม ขยับได้ช่วงแคบมากเพราะเจ็บ, ข้ออื่นปกติ, ไม่พบ tophus ชัดเจน แต่คลำได้ก้อนแข็งเล็ก ๆ ที่นิ้วหัวขแม
Lab แรกรับ: Hb 14.2 g/dL, WBC 13,800 /uL (N 78%, L 16%), Plt 265,000 /uL, BUN 16 mg/dL, Cr 1.2 mg/dL (eGFR 66), uric acid 6.8 mg/dL, CRP 62 mg/L

1. จงให้การวินิจฉัยแยกโรคที่เป็นไปได้มากที่สุด 4 โรค พร้อมเหตุผลสั้น ๆ

2. ท่านจะทำหัตถการใดเป็นอันดับแรก และจะส่งตรวจน้ำไขข้ออะไรบ้าง

3. ผลน้ำไขข้อ: ขุ่น สีเหลือง ความหนืดลดลง WBC 32,000 /uL (PMN 88%) Gram stain ไม่พบเชื้อ และพบผลึกรูปเข็ม **negatively birefringent** อยู่ในเซลล์ จงแปลผลให้ครบและให้การวินิจฉัยที่แน่นอน

4. จงวางแผนการรักษาระยะเฉียบพลันในผู้ป่วยรายนี้ พร้อมเหตุผลของการเลือกยา

5. หลังอาการสงบ 3 สัปดาห์ ผู้ป่วยกลับมาตรวจ จงวางแผนการรักษาระยะยาวและคำแนะนำ

Systemic lupus erythematosus with lupus nephritis

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 24 ปี นักศึกษา มาโรงพยาบาลด้วยบวมหน้าและขาสองข้าง 2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล
PI: 3 เดือนก่อนมีผื่นแดงที่โหนกแก้มสองข้างเป็นมากขึ้นเมื่อออกแดด ผمร่วง ปวดข้อนิ้วมือและข้อมือสองข้างตอนเช้าประมาณ 1 ชั่วโมง มีแผลในปากไม่เจ็บเป็น ๆ หาย ๆ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด 4 กิโลกรัม 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มบวมรอบตาตอนเช้าและบวมขาสองข้าง ปัสสาวะเป็นฟองมากขึ้น ไม่มีไข้สูง ไม่มีเจ็บหน้าอก ไม่เหนื่อย
U/D: ปฏิเสธโรคประจำตัว ไม่เคยตั้งครรภ์ ประจำเดือนปกติ
ยาที่ใช้: ยาแก้ปวดพาราเซตามอลเป็นครั้งคราว ไม่ได้ใช้สมุนไพร
PE: GA: หญิงสาว ดูอ่อนเพลีย ไม่ซีดมาก
V/S: BT 37.4 C, PR 92/min, RR 20/min, BP 152/96 mmHg, BW 54 kg (เพิ่มจาก 51 kg ใน 2 สัปดาห์)
Skin: malar rash เว้นร่อง nasolabial, ไม่มี discoid lesion, ผมหาง
Oral: aphthous ulcer ที่เพดานแข็ง 2 แผล ไม่เจ็บ
Lung: clear both lungs; Heart: normal S1 S2 no murmur no rub
Abdomen: soft, no hepatosplenomegaly, shifting dullness negative
Extremities: pitting edema 2+ ทั้งสองข้าง, ข้อ MCP และ PIP บวมกดเจ็บเล็กน้อย ไม่มี deformity
Lab: Hb 9.6 g/dL (MCV 88), WBC 3,200 /uL (N 68%, L 22%), Plt 118,000 /uL, reticulocyte 1.2%
BUN 24 mg/dL, Cr 1.4 mg/dL (eGFR 48), albumin 2.6 g/dL, cholesterol 288 mg/dL
UA: protein 3+, RBC 20-30/HPF (dysmorphic), WBC 5-10/HPF, **RBC cast 2-3/LPF**
Urine protein-creatinine ratio 3.8 g/g

1. จงให้การวินิจฉัยที่น่าจะเป็นมากที่สุด พร้อมข้อมูลสนับสนุนจากประวัติ ตรวจร่างกาย และแล็บ

2. จงส่งการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรง พร้อมเหตุผล อย่างน้อย 5 อย่าง

3. ผล **ANA 1:1280 speckled, anti-dsDNA** บวกสูง, **C3 46 mg/dL (ต่ำ)**, **C4 8 mg/dL (ต่ำ)** — ผล **renal biopsy: diffuse proliferative glomerulonephritis (class IV) with activity index** สูง จงวางแผนการรักษา

4. หลังได้สเตียรอยด์ขนาดสูงและ **MMF 6 สัปดาห์** ผู้ป่วยกลับมาด้วยไข้ **38.5 C** ไอแห้ง เหนื่อย **SpO2 89% room air**, **CXR** มีฝ้า **interstitial** สองข้าง จงให้การวินิจฉัยแยกโรคและการจัดการเบื้องต้น

5. ผู้ป่วยถามว่าจะตั้งครรภ์ได้หรือไม่ ท่านจะให้คำแนะนำอย่างไร

Anaphylaxis and drug allergy evaluation

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 35 ปี ถูกนำส่งห้องฉุกเฉินด้วยผื่นทั้งตัวและหายใจลำบาก 20 นาทีก่อนมาโรงพยาบาล

PI: 30 นาทีก่อนมาโรงพยาบาล รับประทานยา 'แก้ปวดข้อ' ที่ซื้อจากร้านขายยา (ทราบภายหลังว่าเป็น diclofenac) หลังจากนั้นประมาณ 10 นาที เริ่มคันตามตัว มีผื่นนูนแดงขึ้นทั่วตัว ตาบวม ปากบวม แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก เสียงแหบ วิงเวียนคล้ายจะเป็นลม อาเจียน 1 ครั้ง

U/D: ปฏิเสธโรคประจำตัว เคยมีผื่นลมพิษหลังกินยาแก้ปวดชนิดหนึ่งเมื่อ 2 ปีก่อน แต่หายเองไม่ได้ไปพบแพทย์ และจำชื่อยาไม่ได้

PE: GA: กระสับกระส่าย พูดเป็นคำ ๆ

V/S: BT 36.8 C, PR 128/min, RR 30/min, BP 80/48 mmHg, SpO2 91% room air

Skin: generalized urticaria, angioedema ที่ริมฝีปากและเปลือกตา

HEENT: เสียงแหบ ไม่มี stridor ชัดเจนขณะนี้

Lung: expiratory wheeze ทั้งสองข้าง

Heart: tachycardia, regular, no murmur

Extremities: ปลายมือเย็น capillary refill 3 วินาที

1. จงให้การวินิจฉัยและระบุเกณฑ์ที่ใช้

2. จงเรียงลำดับการรักษาที่ต้องทำทันที 5 ขั้นตอนแรก

3. ผู้ป่วยอาการดีขึ้นใน 1 ชั่วโมง ญาติขอกลับบ้านทันที ท่านจะอธิบายอย่างไร และจะสังเกตอาการนานเท่าใด

4. จงวางแผนการดูแลก่อนจำหน่ายและการส่งต่อ

Polyarthritis — approach and early rheumatoid arthritis

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 46 ปี แม่ค้า มาโรงพยาบาลด้วยปวดข้อมือและข้อนิ้วมือสองข้าง 3 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล
PI: เริ่มปวดและบวมที่ข้อนิ้วมือสองข้างพร้อม ๆ กัน ต่อมาลามมาที่ข้อมือและข้อเท้า ข้อฝืดตอนตื่นนอนนานประมาณ 1 ชั่วโมง
ครึ่ง ต้องแช่น้ำอุ่นจึงขยับได้ อาการดีขึ้นเมื่อได้ขยับใช้งาน แต่แยลงเมื่ออยู่นิ่ง กำมือไม่ถนัด หยิบของหลุด อ่อนเพลีย ไม่มีไข้สูง
ไม่มีผื่น ไม่มีแผลในปาก ไม่มีตาแดง ไม่มีปัสสาวะผิดปกติ ไม่มีท้องเสียหรือการติดเชื้อนำมาก่อน
U/D: ปฏิเสธโรคประจำตัว
ประวัติอื่น: สูบบุหรี่ 10 มวน/วัน 20 ปี ไม่ดื่มสุรา มารดาเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
PE: V/S: BT 37.2 C, PR 84/min, RR 18/min, BP 126/78 mmHg
Hand: บวมกดเจ็บที่ MCP ที่ 2-4 และ PIP ทั้งสองข้างสมมาตร, ข้อมือบวมทั้งสองข้าง, squeeze test บวก, ไม่พบการอักเสบที่
DIP, ยังไม่มี deformity
Skin: ไม่มีผื่น ไม่มี subcutaneous nodule
Lung/Heart/Abdomen: ปกติ
Lab: Hb 10.8 g/dL (MCV 86), WBC 8,600 /uL, Plt 452,000 /uL, ESR 62 mm/hr, CRP 38 mg/L, Cr 0.8 mg/dL,
AST/ALT 22/26 U/L, uric acid 4.2 mg/dL

1. จงอธิบายลักษณะของข้ออักเสบรายนี้ (จำนวนข้อ ความสมมาตร ชนิดของอาการ) และให้การวินิจฉัยแยกโรค 4 โรค

2. จงส่งตรวจเพิ่มเติมพร้อมเหตุผล

3. ผล anti-CCP บวกสูง RF บวก ANA ลบ ภาพรังสีพบ periarticular osteopenia ที่ MCP ยังไม่มี erosion จงวางแผนการรักษาและอธิบายแนวคิด treat-to-target

4. ผู้ป่วยกลับมาหลังใช้ methotrexate 8 สัปดาห์ ด้วยแผลในปากหลายแผล คลื่นไส้ และ WBC 2,900 /uL จงอธิบายกลไกและการจัดการ

Part 3 · OSCE / SAQ — สถานีละ 5 นาที (6 สถานี)

สถานีที่ 1. AIR-OSCE-01 · Lec 23 · Approach to arthritis / crystal and infective arthropathy

SAQ - Synovial fluid crystal under polarized light

SAQ (เขียนตอบ) 5 นาที

ชายไทยอายุ 50 ปี มาด้วยปวดบวมแดงร้อนที่โคนนิ้วหัวแม่มือซ้ายอย่างเฉียบพลัน 1 วัน แพทย์เจาะน้ำไขข้อส่งตรวจ ได้ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แบบ polarized light ดังรูป (ผลึกรูปเข็มยาว อยู่ทั้งในและนอกเซลล์เม็ดเลือดขาว เรืองสีเหลืองเมื่อวางขนานกับแกนของ compensator)

- 2.1 จงบรรยายลักษณะผลึกที่เห็นในสไลด์ (2 คะแนน)
- 2.2 ผลึกนี้คือสารใด และการวินิจฉัยคืออะไร (2 คะแนน)
- 2.3 ถ้าผลึกเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและเรืองสีน้ำเงินเมื่อขนานกับแกน compensator จะเป็นสารใดและโรคใด (2 คะแนน)
- 2.4 จงบอกค่าน้ำไขข้อ (ลักษณะ จำนวนเม็ดเลือดขาว สัดส่วน PMN) ที่ทำให้ท่านต้องคิดถึง septic arthritis (2 คะแนน)
- 2.5 ผู้ป่วยรายนี้มีโรคใดเรื้อรังระยะ 3 และเคยมีแผลในกระเพาะอาหาร ท่านจะเลือกยารักษาอาการเฉียบพลันตัวใด (2 คะแนน)

สถานีที่ 2. AIR-OSCE-02 · Lec 33 · Connective tissue diseases and vasculitis

SAQ - Palpable purpura

SAQ (เขียนตอบ) 5 นาที

ชายไทยอายุ 19 ปี มาด้วยผื่นที่ขาสองข้าง 3 วัน ร่วมกับปวดท้องบิดเป็นพัก ๆ และปวดข้อเท้าสองข้าง 1 สัปดาห์ก่อนหน้านี้เป็นไข้หวัด

ให้ภาพถ่ายผื่น: ผื่นจุดเลือดออกสีแดงคล้ำ ขนาด 2-5 มิลลิเมตร กระจายที่หน้าแข้งและกันทั้งสองข้าง คลำได้นูน กดไม่จาง
ผลตรวจ: Plt 320,000 /uL, PT/aPTT ปกติ, UA: protein 1+, RBC 20-30/HPF

- 3.1 จงบรรยายลักษณะผื่นที่เห็นด้วยศัพท์ทางการแพทย์ (2 คะแนน)
- 3.2 การที่ผื่น 'คลำได้นูน' ร่วมกับเกล็ดเลือดปกติ บอกกลไกอะไร (2 คะแนน)
- 3.3 จงให้การวินิจฉัยที่น่าจะเป็นมากที่สุด พร้อมเหตุผล (2 คะแนน)
- 3.4 จงบอกการตรวจที่ต้องติดตามและภาวะแทรกซ้อนที่กำหนดพยากรณ์โรค (2 คะแนน)
- 3.5 จงให้การวินิจฉัยแยกโรคของ palpable purpura มาอีก 3 โรค (2 คะแนน)

SAQ - Hand radiograph: rheumatoid arthritis versus osteoarthritis

SAQ (เขียนตอบ) 5 นาที

หญิงไทยอายุ 48 ปี ปวดข้อมือและข้อนิ้วมือสองข้าง 6 เดือน ฝึดตอนเช้า 1 ชั่วโมง
ให้ภาพรังสีมือสองข้าง: พบ **soft tissue swelling** รอบ **MCP, periarticular osteopenia**, ช่องข้อ **MCP** และข้อมือ
แคบลงอย่างสม่ำเสมอ และมี **marginal erosion** ที่ **MCP** ที่ 2 และ 3 ไม่พบ osteophyte

- 4.1 จงบรรยายภาพรังสีที่เห็นเป็นข้อ ๆ (2 คะแนน)
- 4.2 จงให้การวินิจฉัยและบอกลักษณะที่ใช้แยกจาก osteoarthritis (3 คะแนน)
- 4.3 จงบอกการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ช่วยยืนยันการวินิจฉัย 2 อย่าง (2 คะแนน)
- 4.4 ก่อนเริ่มยากลุ่ม biologic ต้องคัดกรองอะไรบ้าง และเพราะเหตุใด (3 คะแนน)

OSCE - History taking in suspected drug allergy

สถานที่ซักประวัติผู้ป่วยจำลอง 8 นาที

ผู้ป่วยหญิงอายุ 40 ปี มาที่แผนกผู้ป่วยนอกด้วยเรื่อง 'แพ้ยา' ต้องการมาขอบัตรแพ้ยา
คำสั่ง: จงซักประวัติเพื่อประเมินว่าผู้ป่วยแพ้ยาจริงหรือไม่ ชนิดของปฏิกิริยาคืออะไร และสรุปคำแนะนำให้ผู้ป่วยฟังในช่วงท้าย
(ไม่ต้องตรวจร่างกาย)

หมายเหตุสำหรับผู้ป่วยจำลอง: 2 เดือนก่อน ได้ยา cotrimoxazole รักษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ วันที่ 8 ของยามีไข้ 38.5 C
ผื่นแดงทั้งตัว ตาแดง มีแผลในปากจนกินไม่ได้ ผิวหนังลอกเป็นแผ่นที่หน้าอกประมาณฝ่ามือ 2-3 ฝ่ามือ ต้องนอนโรงพยาบาล 10
วัน

SAQ - Transfusion reaction

SAQ (เขียนตอบ) 5 นาที

หญิงอายุ 62 ปี ได้รับ packed red cell เนื่องจากซีด หลังเริ่มให้เลือดได้ 15 นาที มีไข้ 39.0 C หนาวสั่น ปวดเอวสองข้าง ความดันโลหิต 88/54 mmHg ซีฟจอร์ 124 ครั้ง/นาที และปัสสาวะสีแดงเข้ม

- 5.1 จงให้การวินิจฉัยและกลไกการเกิด (3 คะแนน)
- 5.2 จงเรียงลำดับสิ่งที่ต้องทำทันที 4 ข้อ (4 คะแนน)
- 5.3 จงบอกสิ่งส่งตรวจที่ต้องส่งกลับธนาคารเลือดและการตรวจที่ต้องส่งจากผู้ป่วย (3 คะแนน)
- 5.4 ถ้าผู้ป่วยมีเพียงผื่นลมพิษ ไม่มีไข้ ไม่มีอาการอื่น จะจัดการต่างจากเดิมอย่างไร (2 คะแนน)

SAQ - Proximal muscle weakness with raised enzymes

SAQ (เขียนตอบ) 5 นาที

หญิงอายุ 52 ปี มาด้วยลุกจากเก้าอี้และหิ้วมัลลามากขึ้น 3 เดือน ไม่ปวดกล้ามเนื้อมาก ไม่ชา
PE: กล้ามเนื้อต้นแขนต้นขาแรง 3/5 ทั้งสองข้าง ปลายมือปลายเท้าแรง 5/5 reflex ปกติ ไม่มี sensory loss
มีผื่นสีม่วงที่เปลือกตาบนสองข้าง และผื่นแดงเป็นขุยที่ข้อนิ้วมือด้านหลัง
Lab: CK 4,200 U/L, AST 180 U/L, ALT 120 U/L, ALP 90 U/L, GGT 22 U/L, TSH ปกติ

- 6.1 จงบรรยายผื่นทั้งสองตำแหน่งด้วยศัพท์เฉพาะ (2 คะแนน)
- 6.2 จงให้การวินิจฉัยที่น่าจะเป็นมากที่สุด (2 คะแนน)
- 6.3 ผู้ป่วยถูกส่งไปเจาะตับเพราะ AST/ALT สูง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด (2 คะแนน)
- 6.4 จงบอกการตรวจเพิ่มเติมที่จำเป็น 4 อย่าง พร้อมเหตุผล (4 คะแนน)

ส่วนที่ 2 • เฉลยและคำอธิบาย

อธิบายกลไกเป็นแกน พร้อมเหตุผลการตัดตัวเลือกที่เหลือทิ้ง

Part 1 • MCQ — เฉลย

ข้อ	รหัส	ตอบ	หัวข้อ
1	AIR-MCQ-01	A	Anaphylaxis — first-line treatment
2	AIR-MCQ-02	A	Anaphylaxis — discharge plan
3	AIR-MCQ-03	D	Hypersensitivity classification
4	AIR-MCQ-04	C	Chronic spontaneous urticaria
5	AIR-MCQ-05	B	ACE inhibitor angioedema
6	AIR-MCQ-06	A	Allopurinol hypersensitivity and HLA screening
7	AIR-MCQ-07	B	Stevens-Johnson syndrome / TEN
8	AIR-MCQ-08	B	DRESS syndrome
9	AIR-MCQ-09	D	Penicillin allergy de-labeling
10	AIR-MCQ-10	B	Acute hemolytic transfusion reaction
11	AIR-MCQ-11	E	Allergic transfusion reaction
12	AIR-MCQ-12	E	Vaccination in the immunosuppressed
13	AIR-MCQ-13	E	Primary immunodeficiency clue in an adult
14	AIR-MCQ-14	A	Acute monoarthritis — first investigation
15	AIR-MCQ-15	B	Synovial fluid crystal identification — gout
16	AIR-MCQ-16	B	Pseudogout — CPPD
17	AIR-MCQ-17	B	Acute gout — first-line treatment
18	AIR-MCQ-18	D	Urate-lowering therapy — indication and target
19	AIR-MCQ-19	C	Drug-induced hyperuricemia
20	AIR-MCQ-20	B	Septic arthritis — organism and initial therapy
21	AIR-MCQ-21	A	Beta-lactam induced neutropenia
22	AIR-MCQ-22	E	Osteoarthritis of the knee — first-line management
23	AIR-MCQ-23	D	Osteoarthritis versus rheumatoid arthritis
24	AIR-MCQ-24	A	Soft-tissue rheumatism
25	AIR-MCQ-25	D	Reactive arthritis
26	AIR-MCQ-26	C	Asymptomatic hyperuricemia
27	AIR-MCQ-27	B	Chronic tophaceous gout
28	AIR-MCQ-28	B	Polyarticular gout in the elderly
29	AIR-MCQ-29	E	Gout with chronic kidney disease
30	AIR-MCQ-30	B	Osteoporosis after fragility fracture
31	AIR-MCQ-31	B	Diagnosis of systemic lupus erythematosus
32	AIR-MCQ-32	A	Lupus nephritis — indication for renal biopsy

ข้อ	รหัส	ตอบ	หัวข้อ
33	AIR-MCQ-33	D	Drug-induced lupus
34	AIR-MCQ-34	D	Antiphospholipid syndrome — investigation
35	AIR-MCQ-35	E	Obstetric antiphospholipid syndrome — management
36	AIR-MCQ-36	E	Fever in a lupus patient on immunosuppression
37	AIR-MCQ-37	D	Hydroxychloroquine retinopathy
38	AIR-MCQ-38	E	Systemic sclerosis — autoantibody testing
39	AIR-MCQ-39	C	Scleroderma renal crisis
40	AIR-MCQ-40	D	Raynaud phenomenon — primary versus secondary
41	AIR-MCQ-41	C	Inflammatory myopathy
42	AIR-MCQ-42	D	Statin-associated muscle symptoms
43	AIR-MCQ-43	D	Polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis
44	AIR-MCQ-44	C	ANCA-associated vasculitis
45	AIR-MCQ-45	E	IgA vasculitis (Henoch-Schonlein purpura)
46	AIR-MCQ-46	C	Early rheumatoid arthritis — treatment
47	AIR-MCQ-47	E	Methotrexate toxicity
48	AIR-MCQ-48	A	Glucocorticoid complications — osteonecrosis
49	AIR-MCQ-49	D	Axial spondyloarthritis
50	AIR-MCQ-50	A	Adult-onset Still disease versus infection

1. ตอบ A Anaphylaxis — first-line treatment AIR-MCQ-01 · Lec 08

Anaphylaxis = ปฏิกิริยา **IgE-mediated (type I)** ที่ทำให้ **mast cell/basophil** ปล่อย **histamine, tryptase, leukotriene** พร้อมกันทั้งตัว → vasodilatation + capillary leak (ความดันตก), bronchoconstriction (หอบ), laryngeal edema (เสียงแหบ = สัญญาณอันตราย)

Adrenaline คือยาเดียวที่แก้ทุกกลไกพร้อมกัน

- $\alpha 1$ → vasoconstriction ดึงความดันกลับ และลด mucosal edema
- $\beta 1$ → เพิ่ม cardiac output
- $\beta 2$ → ขยายหลอดลม และยับยั้งการหลั่ง mediator เพิ่ม

ตำแหน่งและทาง — ฉีด **IM ที่ anterolateral thigh (vastus lateralis)** เพราะระดับยาในเลือดขึ้นเร็วและสูงกว่า SC หรือ IM ที่ deltoid ชัดเจน ขนาด 0.01 mg/kg สูงสุด 0.5 mg เข้าได้ทุก 5-15 นาที

ทำไมข้ออื่นผิด

- **Antihistamine** แก้ได้แค่ผื่นและคัน ไม่แก้ความดันตกหรือ laryngeal edema — ใช้เป็นยาเสริมเท่านั้น และห้ามใช้แทน adrenaline
- **Corticosteroid** ออกฤทธิ์ช้าเป็นชั่วโมง หวังผลป้องกัน biphasic reaction (ซึ่งหลักฐานยังไม่ชัด) ไม่ใช่ยาช่วยชีวิต
- **Salbutamol** แก้เฉพาะ bronchospasm ไม่แก้ shock
- **SC route** ดูดซึมช้าและไม่แน่นอนโดยเฉพาะเมื่อ perfusion แย่จาก shock อยู่แล้ว

HIGH-YIELD PEARL

เห็น anaphylaxis ให้ **adrenaline IM** ดันขาด้านนอกทันที — antihistamine/steroid เป็นแค่ตัวประกอบ ความล่าช้าของ adrenaline คือปัจจัยเดียวที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิต

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โปย MCQ ข้อ 'กินข้าว → ผื่นขึ้น → Anaphylaxis → treat โดย Adrenaline IM'
- WAO Anaphylaxis Guidance 2020

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.2.7** Shock: hypovolemic, anaphylactic, septic, cardiogenic — 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน หน้า 60
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56
- **NL B4.2.2(12)** Urticaria (กลุ่มที่ 1-2) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24

2. ตอบ A Anaphylaxis — discharge plan AIR-MCQ-02 · Lec 08

หลังรอด **anaphylaxis** ครั้งหนึ่ง ความเสี่ยงของครั้งต่อไปยังอยู่ตลอดชีวิต เพราะ sensitization ไม่หายไปเอง งานที่ต้องทำก่อนจำหน่ายมี 3 อย่างเสมอ

1. จ่าย **adrenaline auto-injector 2** เข็ม + สอนวิธีใช้จริง (ให้ผู้ป่วยสาธิตซ้ำ)
2. เขียน **anaphylaxis action plan** ระบุอาการที่ต้องฉีดทันทีและให้โทร 1669 ทุกครั้งหลังฉีด
3. ส่งต่อ **allergist** เพื่อยืนยันสารก่อภูมิแพ้ (skin prick / specific IgE) และวางแผนหลีกเลี่ยง

ทำไมข้ออื่นผิด

- **Antihistamine** ทุกวัน ไม่ป้องกัน anaphylaxis เลย และอาจกลบอาการเริ่มต้น (ผื่น/คัน) ทำให้ผู้ป่วยฉีด adrenaline ช้าลง — เป็นตัวลวงที่โง่เง่าจงใจวางไว้
- **Prednisolone** ยาว 2 สัปดาห์ ไม่มีหลักฐานว่าลด biphasic reaction และเพิ่มผลข้างเคียง
- **Oral challenge** กับสารที่เพิ่งทำให้เกิด anaphylaxis เป็นข้อห้ามชัดเจน
- **ไม่ให้ยาอะไรเลย** คือสาเหตุการตายที่พบบ่อยที่สุดของ food anaphylaxis ในวัยรุ่น

HIGH-YIELD PEARL

ออกจาก ER ต้องได้ ปากกา **adrenaline + action plan + นัด allergist** — ไม่ใช่ antihistamine กินทุกวัน

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โปย MCQ ข้อ 45 'Anaphylactic shock d/c แล้วทำไรต่อ > พกปากกา, ฉีด antihistamine ทุกวัน'
- EAACI Anaphylaxis Guideline 2021

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.2.7** Shock: hypovolemic, anaphylactic, septic, cardiogenic — 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน หน้า 60
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

3. ตอบ D Hypersensitivity classification AIR-MCQ-03 · Lec 08

Urticaria ที่เกิดภายในนาที่ถึงชั่วโมง หลังได้ยาครั้งแรกของ **course** และผื่นแต่ละตุ่มอยู่ไม่เกิน **24 ชั่วโมง = type I (immediate, IgE-mediated)**

Type (Gell & Coombs)	กลไก	ตัวอย่างทางคลินิก	เวลาเกิด
I	IgE + mast cell	urticaria, angioedema, anaphylaxis	นาที-1 ชม.
II	IgG ต่อ antigen บนผิวเซลล์	drug-induced hemolytic anemia, ITP	วัน
III	immune complex + complement	serum sickness, vasculitis, SLE	1-3 สัปดาห์
IVa/IVb	Th1 / Th2 + macrophage, eosinophil	contact dermatitis, DRESS	2 วัน-6 สัปดาห์
IVc	cytotoxic T cell	SJS / TEN	4 วัน-4 สัปดาห์

ทำไมข้ออื่นผิด — type II และ III ใช้เวลาหลายวันถึงสัปดาห์และไม่ทำให้เกิด wheal ชั่วคราว, type IV เป็น delayed cell-mediated (ผื่นคงที่หลายวัน มักมี scaling หรือ bullae) ซึ่งไม่ตรงกับผื่นลมพิษที่ย้ายที่และหายภายในวันเดียว

HIGH-YIELD PEARL

ผื่นลมพิษย้ายที่ ตุ่มละไม่เกิน 24 ชม. + เกิดเร็ว = **type I**; ผื่นคงที่นานหลายวันหรือหลุดลอก = **type IV**

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โปย MCQ ข้อ 44 'Urticaria hypersensitivity type 1'
- Middleton's Allergy 9th ed.

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B4.2.2(12)** Urticaria (กลุ่มที่ 1-2) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24
- **NL 2.3.12(12)** Urticaria (กลุ่มที่ 2) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 66
- **NL 2.1.51** คัน (pruritus) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

4. ตอบ C Chronic spontaneous urticaria AIR-MCQ-04 · Lec 08

Chronic spontaneous urticaria (CSU) = ลมพิษเกือบทุกวันนานเกิน 6 สัปดาห์ โดยไม่มีสิ่งกระตุ้นชัดเจน ส่วนใหญ่เป็น autoimmune (autoantibody ต่อ FcεRI หรือ IgE) ไม่ใช่แพ้อาหาร

ขั้นตอนการรักษาตาม **EAACI/WAO**

1. second-generation H1-antihistamine ขนาดมาตรฐาน
2. เพิ่มขนาดได้ถึง 4 เท่า (ขั้นที่ควรทำในข้อนี้)
3. เพิ่ม omalizumab
4. เพิ่ม ciclosporin

ทำไมข้ออื่นผิด

- **Prednisolone** ระยะยาว ห้าม — ผลข้างเคียงสะสม (osteoporosis, DM, Cushing) ใช้ได้แค่ course สั้น ๆ ตอน exacerbation
- **Allergy panel** เหยี่ยงแห ให้ผลบวกลวงสูงและไม่เปลี่ยนการรักษาใน CSU
- **Skin biopsy** ทำเฉพาะเมื่อสงสัย **urticarial vasculitis** คือผื่นแต่ละตุ่มอยู่เกิน 24 ชั่วโมง เจ็บมากกว่าคัน และหายแล้วทิ้งรอยจ้ำ — เคสนี้ไม่มี
- **First-generation antihistamine** ทำให้ง่วงและรบกวน REM sleep โดยไม่ได้ผลดีกว่า จึงไม่ใช่ทางเลือกแรก

HIGH-YIELD PEARL

ลมพิษเรื้อรังคุมไม่อยู่ ให้ เพิ่มขนาด **antihistamine** ได้ถึง 4 เท่า ก่อนคิดถึง steroid; ตุ่มอยู่เกิน 24 ชม. + ทิ้งรอยจ้ำ = urticarial vasculitis ต้อง biopsy

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- EAACI/GA2LEN/EuroGuiDerm Urticaria Guideline 2021
- MED32 โปย MCQ urticaria

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B4.2.2(12)** Urticaria (กลุ่มที่ 1-2) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24
- **NL 2.3.12(12)** Urticaria (กลุ่มที่ 2) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 66
- **NL 2.1.51** คัน (pruritus) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

5. ตอบ B ACE inhibitor angioedema AIR-MCQ-05 • Lec 08

Angioedema ที่ไม่มีลมพิษและไม่คัน = bradykinin-mediated ไม่ใช่ histamine-mediated

ACE inhibitor ยับยั้ง **kininase II** ซึ่งเป็นเอนไซม์เดียวกับ ACE ที่ทำหน้าที่สลาย bradykinin → bradykinin คั่ง → หลอดเลือดรั่ว เฉพาะที่ริมฝีปาก ลิ้น กล้องเสียง เกิดได้ ทุกช่วงเวลา ตั้งแต่วันแรกจนถึงหลายปีหลังเริ่มยา (จึงไม่ใช่ข้อแก้ต่างว่ากินมา 2 ปีแล้วไม่น่าจะแพ้)

การรักษา — หยุดยาถาวร (ห้ามกลับมาใช้ ACEI ตัวใดอีก) เผื่อระวังทางเดินหายใจอย่างใกล้ชิด เตรียม intubation ถ้าลิ้นหรือกล่องเสียงบวมมาก ยาแก้แพ้ สเตียรอยด์ และ adrenaline มักไม่ได้ผล เพราะกลไกไม่ใช่ histamine (ให้ adrenaline ได้เมื่อแยกจาก anaphylaxis ไม่ออก แต่อย่าหวังผล)

ทำไมข้ออื่นผิด

- ใช้ **ACEI** ต่อ = เสี่ยงตายจาก laryngeal edema รอบถัดไป
- เปลี่ยนเป็น **ARB** ยังมีรายงาน cross-reaction ได้ประมาณ 2-10% แม้กลไกต่างกัน จึงไม่ใช่คำตอบที่ปลอดภัยที่สุด และ antihistamine ระยะยาวไม่มีบทบาท
- **Steroid** ไม่ได้ผลใน bradykinin-mediated angioedema
- **Skin prick test** ใช้ทดสอบ IgE-mediated เท่านั้น ไม่มีที่ใช้ในกลไกนี้

HIGH-YIELD PEARL

บวมโดยไม่มีลมพิษ ไม่คัน = **bradykinin** — นึกถึง ACEI และ hereditary angioedema ไว้ก่อน, ยาแก้แพ้กับสเตียรอยด์ไม่ช่วย

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 โปย MCQ angioedema จาก ACEI
- Harrison 21st ed., Urticaria and Angioedema

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B4.2.2(12)** Urticaria (กลุ่มที่ 1-2) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24
- **NL 2.2.7** Shock: hypovolemic, anaphylactic, septic, cardiogenic — 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน หน้า 60
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

6. ตอบ A Allopurinol hypersensitivity and HLA screening AIR-MCQ-06 · Lec 08

*Severe cutaneous adverse reaction (SCAR) จาก allopurinol — SJS/TEN และ DRESS — สัมพันธ์กับ HLA-B*58:01 อย่างชัดเจนในคนไทยและเอเชีย** (odds ratio หลายสิบเท่า) และความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นเมื่อมี CKD เพราะ oxypurinol คั่ง

Allele	ยาที่ต้องระวัง	ปฏิกิริยา
*HLA-B*58:01**	Allopurinol	SJS/TEN, DRESS
HLA-B*15:02	Carbamazepine (และ phenytoin บางส่วน)	SJS/TEN
HLA-B*57:01	Abacavir	hypersensitivity syndrome

คำแนะนำปฏิบัติ — ถ้าตรวจพบ HLA-B*58:01 positive ให้เลี่ยงไปใช้ **febuxostat** หรือ probenecid; ถ้าไม่ได้ตรวจ ให้เริ่ม allopurinol ขนาดต่ำ (50–100 mg/วัน ปรับตาม eGFR) แล้วค่อย ๆ เพิ่ม ซึ่งลดอุบัติการณ์ SCAR ได้

ทำไมข้ออื่นผิด — B*15:02 เป็นของ carbamazepine (โพลีเกาตอบสับสนบ่อยมาก), B*57:01 ของ abacavir, tryptase ใช้ยืนยัน anaphylaxis ย้อนหลัง ไม่ทำนาย SCAR, skin prick test ไม่ใช่กับ delayed T-cell reaction

HIGH-YIELD PEARL

*Allopurinol → B*58:01 · Carbamazepine → B*15:02 · Abacavir → B*57:01** ท่องสามคู่นี้ให้ขึ้นใจ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โพลี Skin ข้อ 2 'คนไข้มาด้วย SJS ก่อนหน้านี้ได้ Allopurinol ไม่ได้ส่งตรวจยีน — A. HLA-B*15:02 B. HLA-B*58:01'
- ACR Gout Guideline 2020

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B4.2.2(13)** Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis (กลุ่มที่ 1-2) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24
- **NL 2.3.12(13)** Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis (กลุ่มที่ 2) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 66
- **NL B5.4(4)** Drugs for treatment of gout and hyperuricemia — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28

7. ตอบ B Stevens-Johnson syndrome / TEN AIR-MCQ-07 · Lec 08

ผื่นเจ็บ + mucosa อย่างน้อย 2 ตำแหน่ง + epidermal detachment + Nikolsky positive หลังได้ยา 1-4 สัปดาห์ = SJS/TEN (type IVc, cytotoxic T cell ทำลาย keratinocyte ผ่าน granulysin)

จำแนกตามพื้นที่ลอก: SJS < 10% · SJS/TEN overlap 10-30% · TEN > 30% (เคสนี้ 12% = overlap)

สิ่งที่กำหนดอัตราตายมากที่สุดคือ 'หยุดยาดันเหตุให้เร็วที่สุด' ทุกวันที่ซ้าออกไปเพิ่มอัตราตาย จากนั้นดูแลแบบผู้ป่วยไฟไหม้: สารน้ำ ควบคุมอุณหภูมิ แผล ตา (ป้องกัน symblepharon ต้องปรึกษาจักษุแพทย์ทันที) ปาก โภชนาการ และประเมินความรุนแรงด้วย SCORTEN

ทำไมข้ออื่นผิด

- ใช้ยาต่อ ไม่มีทางถูก — ต้องเปลี่ยนไปยากันชักที่โครงสร้างต่างกัน (เช่น valproate, levetiracetam) และ ห้ามใช้ **aromatic anticonvulsant** ทุกตัว เพราะ cross-reactivity สูง
- IVIG หลักฐานยังขัดแย้ง และไม่มีทางมาก่อนการหยุดยา
- ยาปฏิชีวนะ **prophylaxis** ไม่แนะนำ ให้เมื่อมีหลักฐานติดเชื้อเท่านั้น (เพาะเชื้อเฝ้าระวังแทน)
- ให้กลับบ้าน ในผู้ป่วยผิวหนังลอก 12% คือความผิดพลาดร้ายแรง

HIGH-YIELD PEARL

SJS/TEN: หยุดยาดันเหตุทันที = การรักษาที่สำคัญที่สุด แล้วดูแลแบบแผลไฟไหม้ + ปรึกษาจักษุวันแรก

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 โปย Skin — SJS จากยากันชัก
- Harrison 21st ed., Cutaneous Drug Reactions

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B4.2.2(13)** Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis (กลุ่มที่ 1-2) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24
- **NL 2.3.12(13)** Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis (กลุ่มที่ 2) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 66
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56
- **NL 2.1.1** ไข้ (fever) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

8. ตอบ B DRESS syndrome AIR-MCQ-08 · Lec 08

DRESS = ผื่นยาที่มาช้า (2-8 สัปดาห์) + ไข้ + หน้าบวม + ต่อม้ำเหลืองโต + eosinophilia + อวัยวะภายในอักเสบ (ตับ บ่อยที่สุด รองมาคือไตและปอด) เกี่ยวข้องกับการ reactivation ของ HHV-6/EBV ยาต้นเหตุคลาสสิกคือ **allopurinol, ยากันชัก **aromatic, sulfonamide, vancomycin, dapsone****

จุดแยกจากโรคอื่น

	เวลา	ผื่น	ลักษณะเด่น
DRESS	2-8 สัปดาห์	morbilliform + หน้าบวม	eosinophilia + ตับอักเสบ + ต่อม้ำเหลืองโต
SJS/TEN	4 วัน-4 สัปดาห์	ผื่นเจ็บ ลอก mucosa	Nikolsky +, ไม่ค่อยมี eosinophilia
AGEP	1-2 วัน	ตุ่มหนองเล็กบน erythema	neutrophilia เด่น หายเร็วหลังหยุดยา
Morbilliform eruption	4-14 วัน	ผื่นราบ ไม่เจ็บ	ไม่มี ไข้สูง ตับอักเสบ หรือ eosinophilia

การรักษา — หยุดยาทันที ให้ systemic corticosteroid (prednisolone 0.5–1 mg/kg/วัน) แล้วค่อย ๆ ลดยาวหลายสัปดาห์ เพราะ DRESS กลับเป็นซ้ำได้ง่าย และต้องติดตามการทำงานของตับ ไต และไตรอยด์ไปอีกหลายเดือน

HIGH-YIELD PEARL

ผื่นยา + **eosinophilia + ตับอักเสบ + หน้าบวม** ที่มาช้าเป็นสัปดาห์ = DRESS; ต้องหยุดยาและให้สเตียรอยด์ลดยาว ไม่ใช่ course สั้น

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 โปษ ผื่นแพ้ยา allopurinol
- RegiSCAR DRESS criteria

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B4.2.2(13)** Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis (กลุ่มที่ 1-2) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56
- **NL 2.1.1** ไข้ (fever) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL 2.3.3(4)** Immune hemolytic anemia (autoimmune, drug-induced) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61

9. ตอบ D Penicillin allergy de-labeling AIR-MCQ-09 · Lec 08

กว่า **90%** ของผู้ที่ถูกติดป้ายว่า 'แพ้ **penicillin**' แท้จริงไม่แพ้ — ส่วนใหญ่เป็นผื่นจากไวรัสตอนเด็กที่บ่งเิกนยาอยู่ หรือ IgE หายไปตามเวลา (ประมาณ 80% ของผู้ที่แพ้จริงจะสูญเสีย IgE ภายใน 10 ปี)

ต้นทุนของป้ายแพ้ยาที่ผิด — ได้ยาทางเลือกที่ด้อยกว่า (vancomycin, fluoroquinolone) → ผลการรักษาแย่ง เชื้อดื้อยา และ C. difficile มากขึ้น

การประเมินความเสี่ยง

- **Low risk** = ผื่นราบล้นตอนเด็ก, อาการที่ไม่ใช่ภูมิแพ้ (คลื่นไส้ ปวดหัว), หรือประวัติคลุ้มเครือเกิน 10 ปี → ให้ cephalosporin ที่ side chain ต่างกันได้เลย หรือทำ direct oral challenge
- **High risk** = anaphylaxis, angioedema, ผื่นลมพิษทันที → ส่ง allergist เพื่อทำ skin test หรือ desensitization
- ห้ามใช้ซ้ำเด็ดขาด = เคยเกิด SJS/TEN หรือ DRESS จากยานั้น (การ desensitize ก็ห้าม)

ทำไมข้ออื่นผิด — cross-reactivity ระหว่าง penicillin กับ cephalosporin รุ่นใหม่จริง ๆ อยู่ที่ ราว **1-2%** ไม่ใช่ 10% และขึ้นกับ **side chain** ไม่ใช่วง beta-lactam; การให้ยาแก้แพ้ล่วงหน้าไม่ป้องกัน IgE-mediated reaction และกลบอาการเตือน

HIGH-YIELD PEARL

ป้าย 'แพ้ penicillin' ต้อง **ซักให้ได้ว่าอาการคืออะไร เมื่อไร** — ผื่นราบตอนเด็ก = low risk ให้ beta-lactam ต่อได้ แต่ SJS/TEN หรือ DRESS = ห้ามตลอดชีวิต

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 โปย MCQ drug allergy history
- IDSA/AAAAI Penicillin Allergy Evaluation 2022

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B4.2.2(13)** Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis (กลุ่มที่ 1-2) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24
- **NL 2.2.7** Shock: hypovolemic, anaphylactic, septic, cardiogenic — 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน หน้า 60

10. ตอบ B Acute hemolytic transfusion reaction AIR-MCQ-10 · Lec 08

ไข้ + ปวดสีข้าง + ปัสสาวะสีแดงเข้ม ภายในนาทีแรก ๆ ของการให้เลือด = **acute hemolytic transfusion reaction (AHTR)** จาก ABO incompatibility — เป็น **type II hypersensitivity**: IgM/IgG ของผู้รับจับ RBC ผู้ให้ → complement activation ครบวง → intravascular hemolysis, hemoglobinuria, DIC และ acute kidney injury

ลำดับการทำทันที

1. หยุดให้เลือดทันที และเปลี่ยนสาย/ให้ NSS ต่อเพื่อรักษาปริมาตรและ urine output
2. ตรวจสอบชื่อผู้ป่วยกับถุงเลือดซ้ำ ส่งถุงเลือด + เลือดผู้ป่วยกลับธนาคารเลือด (repeat cross-match, direct Coombs, plasma free Hb)
3. ประคับประคอง: สารน้ำให้ urine ออกดี ฝ้า DIC และไตวาย

แยกจากปฏิกิริยาอื่น

ปฏิกิริยา	เวลา	อาการเด่น	จัดการ
AHTR	นาที	ไข้ ปวดสีข้าง ปัสสาวะดำ/แดง ความดันตก	หยุดถาวร + ประคับประคอง
Febrile non-hemolytic	1-6 ชม.	ไข้หนาวสั่น ไม่มี ปัสสาวะสีผิดปกติ	หยุด ให้ยาลดไข้ ครั้งหน้าใช้ leukocyte-poor
Allergic/urticarial	นาที-ชม.	ผื่นลมพิษอย่างเดียว	หยุดชั่วคราว ให้ antihistamine แล้วให้ต่อซ้ำ ๆ ได้
TACO	1-6 ชม.	เหนื่อย ความดันสูง JVP สูง	หยุด + furosemide

ทำไมข้ออื่นผิด — การให้ยาลดไข้แล้วให้เลือดต่อเหมาะกับ FNHTR เท่านั้น, furosemide ไม่ใช่หัวใจของการรักษา AHTR และห้ามให้เลือดต่อ, adrenaline สงวนไว้สำหรับ anaphylactic transfusion reaction (หอบ ความดันตก ไม่มี hemolysis)

HIGH-YIELD PEARL

ให้เลือดแล้ว ไข้ + ปวดหลัง + ปัสสาวะดำ = **AHTR** หยุดทันที; ไข้อย่างเดียวไม่มีปัสสาวะผิดปกติ = FNHTR

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โปย Hemato ข้อ 3 'ให้เลือดแล้วมีไข้ ไม่มี dark urine → febrile non-hemolytic'
- AABB Technical Manual 20th ed.

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.2.21** Incompatible blood transfusion — 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน หน้า 60
- **NL 2.3.3(4)** Immune hemolytic anemia (autoimmune, drug-induced) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61
- **NL 2.1.1** ไข้ (fever) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

11. ตอบ E Allergic transfusion reaction AIR-MCQ-11 · Lec 08

ผื่นลมพิษอย่างเดียว ไม่มีไข้ ไม่มีอาการระบบอื่น = **allergic (urticarial) transfusion reaction** เกิดจาก IgE ของผู้รับต่อโปรตีนในพลาสมาผู้ให้ เป็นปฏิกิริยาที่พบบ่อยและไม่รุนแรง

เป็นชนิดเดียวที่อนุญาตให้ 'ให้เลือดต่อ' ได้ — หยุดชั่วคราว ให้ antihistamine รอผื่นยุบ แล้วเริ่มใหม่ช้า ๆ พร้อมเฝ้าอาการ ถ้าเป็นซ้ำบ่อยครั้งหน้าให้พิจารณา washed red cells

ทำไมข้ออื่นผิด

- **AHTR** ต้องมีไข้ ปวดศีรษะ ปัสสาวะสีเข้ม หรือความดันตก — เคสนี้ไม่มี และเวลา 15 นาทีเพียงพออย่างเดียวไม่พอวินิจฉัย (โพยเก่า หลอกด้วยเวลา 15 นาทีเสมอ)
- **Adrenaline/ICU** ใช้เมื่อมี anaphylaxis คือมี bronchospasm, angioedema หรือความดันตกร่วมด้วย
- **ให้ต่อในอัตราเดิม + paracetamol** เหมาะกับ FNHTR ไม่ใช่ผื่นลมพิษ และการไม่หยุดเลยทำให้พลาด anaphylaxis ที่กำลังก่อตัว
- **Furosemide** ใช้ใน TACO ซึ่งจะมีเหนื่อยและความดันสูง

HIGH-YIELD PEARL

ผื่นลมพิษล้วนระหว่างให้เลือด = allergic reaction — ชนิดเดียวที่ให้เลือดต่อได้ หลังผื่นยุบ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โพย MCQ ข้อ 41 'Blood transfusion ทำไป 15 นาทีเกิดผื่นขึ้น (delay, acute, allergy, purpura)'
- AABB Technical Manual 20th ed.

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.2.21** Incompatible blood transfusion — 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน หน้า 60
- **NL B4.2.2(12)** Urticaria (กลุ่มที่ 1-2) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24
- **NL 2.1.51** คัน (pruritus) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

12. ตอบ E Vaccination in the immunosuppressed AIR-MCQ-12 · Lec 08

ผู้ป่วยที่ได้ **prednisolone** ตั้งแต่ **20 mg/วัน (หรือ 2 mg/kg/วันในเด็ก)** นาน **2 สัปดาห์ขึ้นไป** หรือได้ยากดภูมิอื่น ถือว่าอยู่ในภาวะกดภูมิคุ้มกันอย่างมีนัยสำคัญ

- **วัคซีนเชื้อตาย/หน่วยย่อย (inactivated, subunit, mRNA)** — ปลอดภัย ให้ได้เลยและควรให้ เพราะกลุ่มนี้เสี่ยงติดเชื้อรุนแรง: influenza รายปี, pneumococcal, hepatitis B, COVID-19 ภูมิที่ขึ้นอาจต่ำกว่าคนปกติแต่ยังคุ้มค่า
- **วัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (live attenuated)** — MMR, varicella, LAIV, yellow fever, BCG, OPV — ห้าม เพราะอาจกลายเป็นโรคจริง ควรให้ก่อนเริ่มยากดภูมิอย่างน้อย 4 สัปดาห์ หรือรอหลังหยุดสเตียรอยด์ขนาดสูงอย่างน้อย 1 เดือน (ยากดภูมิชนิดอื่นรอ 3 เดือน)

ทำไมข้ออื่นผิด — ข้อ 2, 3, 5 เป็นวัคซีนเชื้อเป็นทั้งหมด, ส่วนการ รอจนหยุดสเตียรอยด์หมดก่อนค่อยฉีดทุกชนิด ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงไข้หวัดใหญ่รุนแรงโดยไม่จำเป็น เพราะวัคซีนเชื้อตายให้ได้ทันที ถ้าจะให้ zoster ในกลุ่มนี้ต้องใช้ **recombinant zoster vaccine** ซึ่งไม่ใช่เชื้อเป็น

HIGH-YIELD PEARL

กดภูมิอยู่: วัคซีนเชื้อตายให้ได้ทันที · วัคซีนเชื้อเป็นห้าม — และควรวางแผนฉีดเชื้อเป็นให้เสร็จก่อนเริ่มยากดภูมิ 4 สัปดาห์

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 โปย MCQ วัคซีนในผู้ป่วยกดภูมิ
- IDSA Vaccination of the Immunocompromised Host 2013; ACR 2022 vaccination guidance

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3-3(5)** Immune deficiency states (neutropenia, asplenia/splenic dysfunction, post-chemotherapy) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61
- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

13. ตอบ E Primary immunodeficiency clue in an adult AIR-MCQ-13 · Lec 08

ผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อแบคทีเรียมีแคปซูลซ้ำ ๆ ที่ทางเดินหายใจ (sinopulmonary) ร่วมกับ giardiasis เรื้อรัง และ HIV negative → นึกถึง **antibody deficiency** โดยเฉพาะ **common variable immunodeficiency (CVID)** ซึ่งเป็น primary immunodeficiency ที่วินิจฉัยในผู้ใหญ่บ่อยที่สุด

การตรวจแรกที่ให้ผลดีที่สุดคือระดับ **immunoglobulin** — ใน CVID จะพบ IgG ต่ำร่วมกับ IgA หรือ IgM ต่ำ และตอบสนองต่อวัคซีนไม่ดี (วัด specific antibody ต่อ tetanus/pneumococcus ต่อได้)

ทำไมข้ออื่นผิด — แต่ละการตรวจผูกกับ 'ลายเซ็นการติดเชื้อ' คนละแบบ

เบาะแสการติดเชื้อ	ส่วนของภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง	ตรวจอะไร
แบคทีเรียมีแคปซูล ติดซ้ำที่ไซนัส/ปอด, giardia	B cell / antibody	Ig levels
ฝีหนองซ้ำ ๆ, catalase-positive (S. aureus, Burkholderia), granuloma	neutrophil oxidative burst	DHR/NBT
Neisseria ซ้ำ ๆ	terminal complement C5-C9	CH50
เชื้อฉวยโอกาส เชื้อรา ไวรัสรุนแรง	T cell	CD4, HIV, lymphocyte subset

Bone marrow ไม่ใช่การตรวจเริ่มต้นเมื่อ CBC ปกติ และการตรวจ HIV ซ้ำทุกเดือนโดยไม่มีความเสี่ยงใหม่ไม่ช่วยอะไร

HIGH-YIELD PEARL

ติดเชื้อ **sinopulmonary** ซ้ำ + **giardia** ในผู้ใหญ่ = สงสัย **CVID** → ส่ง **IgG/IgA/IgM** ก่อน; **Neisseria** ซ้ำ = complement, ฝีหนองซ้ำ = phagocyte

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 โปย MCQ recurrent infection
- Harrison 21st ed., Primary Immune Deficiency Diseases

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3-3(5)** Immune deficiency states (neutropenia, asplenia/splenic dysfunction, post-chemotherapy) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61
- **NL 2.1.1** ไข้ (fever) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

14. ตอบ A Acute monoarthritis — first investigation AIR-MCQ-14 · Lec 23

ข้ออักเสบเฉียบพลันข้อเดียว + ไข้ = ต้องตัด **septic arthritis** ออกก่อนเสมอ เพราะทำลายกระดูกอ่อนภายใน **24-48 ชั่วโมง** และมีอัตราตายสูง การเจาะข้อเป็นการตรวจเดียวที่ตอบได้ทั้งติดเชื้อและผลึก

อ่านน้ำไขข้ออย่างไร

	ปกติ	Non-inflammatory (OA)	Inflammatory (gout, CPPD, RA)	Septic
สี/ความใส	ใส	ใส เหลืองอ่อน	ขุ่น	ขุ่นข้น เป็นหนอง
WBC (/mm ³)	< 200	< 2,000	2,000-50,000	> 50,000 (มักเกิน 100,000)
PMN	< 25%	< 25%	> 50%	> 90%
ความหนืด	สูง	สูง	ต่ำ	ต่ำมาก

ทำไมข้ออื่นผิด

- **Serum uric acid** ตอนกำลังปวดอาจ ปกติหรือต่ำ ได้ถึง 1 ใน 3 (เพราะ urate ตกตะกอนลงข้อ) และค่าที่สูงก็ไม่ตัด septic arthritis ออก — เป็นกับดักคลาสสิก
- **Plain film** ในเก๊าท์ระยะแรกมักปกติ; ที่เห็น punched-out erosion คือระยะเรื้อรัง
- **Blood culture** อย่างเดียว ขึ้นเชื้อเพียงครึ่งหนึ่งของ septic arthritis และไม่ควรถ่ายแทนการเจาะข้อ (ส่งคู่กันได้)
- **MRI** ใช้อยู่ osteomyelitis หรือเมื่อเจาะไม่ได้ ไม่ใช่การตรวจแรก

HIGH-YIELD PEARL

ข้ออักเสบเฉียบพลันข้อเดียว = เจาะข้อก่อน เสมอ; uric acid ปกติไม่ตัดเก๊าท์ และ uric acid สูงก็ไม่ตัดข้อติดเชื้อ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 MEQ 'ผช. ปวดเข่ามากจนเดินไม่ได้ + ไข้ — บอกวิธีการดูน้ำที่เจาะ'
- ACR Gout Guideline 2020

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.1.27** ปวดข้อ ข้อฝืด ข้อติด (joint pain, stiff joint, frozen joint) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL B5.3(3)** Synovial fluid analysis — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL 3.1.7** Body fluid analysis (e.g., CSF, pleural, synovial) — 3.1 ตรวจและแปลผลได้ด้วยตนเอง หน้า 71
- **NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.3.13-3(6)** Infective arthritis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

15. ตอบ B Synovial fluid crystal identification — gout AIR-MCQ-15 · Lec 23

จำลองผลึกให้แม่นยำ — ออกสอบทุกปีทั้ง MCQ และ SAQ

	Monosodium urate (gout)	Calcium pyrophosphate (CPPD)
รูปร่าง	เข็มยาว (needle)	สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (rhomboid)
Birefringence	negative, แรง	positive, อ่อน
สีเมื่อขนานแกน compensator	เหลือง	น้ำเงิน
ข้อที่ชอบเป็น	MTP ที่ 1 (podagra), ข้อเท้า เข่า	เข่า ข้อมือ
ภาพรังสี	punched-out erosion ขอบยื่น (overhanging edge)	chondrocalcinosis (แคลเซียมในกระดูกอ่อน)

ตัวช่วยจำ: "yellow" + "needle" ไปด้วยกันเมื่อ parallel (Yellow-Needle-Parallel = gout)

ทำไมข้ออื่นผิด — CPPD ให้ผลึก rhomboid positive birefringent; septic arthritis WBC มักเกิน 50,000 พร้อม Gram stain หรือ culture บวก (และ พบผลึกร่วมกับติดเชื้อพร้อมกันได้ จึงต้องส่ง culture เสมอแม้เจอผลึก); RA เป็นข้อเล็กหลายข้อสองข้างพร้อมกัน; reactive arthritis เป็น oligoarthritis ขาส่วนล่างหลังติดเชื้อทางเดินอาหารหรือปัสสาวะ 1-4 สัปดาห์

HIGH-YIELD PEARL

Needle + negative + เหลืองเมื่อขนาน = gout; rhomboid + positive = CPPD — และเจอผลึกแล้วก็ต้องส่งเพาะเชื้อ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 OSCE/SAQ ข้อ 7 'ให้ประวัติชายอายุ 50 ปวดข้อ ให้บรรยายภาพสไลด์ uric acid crystal needle shape และวินิจฉัย — ตอบ gout'
- MED33 โปย MEQ acute gouty attack

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL B5.2.5(1)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27
- NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- NL B5.3(3)** Synovial fluid analysis — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- NL 3.1.7** Body fluid analysis (e.g., CSF, pleural, synovial) — 3.1 ตรวจและแปลผลได้ด้วยตนเอง หน้า 71

16. ตอบ B Pseudogout — CPPD AIR-MCQ-16 · Lec 23

ผลึก **rhomboid, weakly positive birefringent + chondrocalcinosis** บนฟิล์ม = **CPPD (pseudogout)** ชื่อเต็มคือ **calcium PYROPHOSPHATE dihydrate** ไม่ใช่ calcium phosphate (โพยเก่าหลายฉบับเขียนผิดเป็น 'calcium phosphate dihydrate' — ให้จำชื่อที่ถูกไว้ใช้ตอบ)

CPPD ในคนอายุน้อยกว่า **55 ปี** หรือเป็นหลายข้อ ต้องหาโรคทางเมตาบอลิกเบื้องหลัง จำด้วย **4 H: Hyperparathyroidism, Hemochromatosis, Hypophosphatasia, Hypomagnesemia** (บวก hypothyroidism)

การรักษา **acute attack** เหมือนเก๊าท์คือ NSAID, colchicine หรือ corticosteroid (ฉีดเข้าข้อได้ผลดีเมื่อเป็นข้อเดียว) แต่ **ไม่มี** ยาละลายผลึก **CPPD** ต่างจากเก๊าท์ที่ลด urate ได้

ทำไมข้ออื่นผิด — gout ให้ผลึกเข็ม negative birefringent; septic arthritis WBC สูงกว่านี้มากและมีเชื้อ; hydroxyapatite ไม่เห็นด้วย polarized light ทั่วไป (ต้องย้อม alizarin red) และมักเป็น periarthritis ที่ไหล่ (Milwaukee shoulder); OA ให้น้ำไขข้อ WBC < 2,000

HIGH-YIELD PEARL

Pseudogout = **calcium PYROPHOSPHATE** + chondrocalcinosis; เป็นในคนอายุน้อยหรือหลายข้อให้หา **hyperparathyroidism / hemochromatosis / hypomagnesemia**

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โพย Joint ข้อ 1 'rhomboid-shaped crystals weakly positively birefringent'
- MED33 โพย MCQ ข้อ 11 'Synovial fluid rhomboid shape'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.5(1)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.3(3)** Synovial fluid analysis — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL B5.3(1)** Plain film of bones and joints — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 27

17. ตอบ B Acute gout — first-line treatment AIR-MCQ-17 · Lec 23

การรักษา flare มี 3 ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพเท่า ๆ กัน — NSAID, colchicine, corticosteroid — เลือกตามโรคร่วม

- **NSAID** เลี่ยงเมื่อมีแผลในกระเพาะ, CKD, หัวใจล้มเหลว, กินยาต้านการแข็งตัวของเลือด → เคสนี้มีประวัติ PUD จึงไม่ควรใช้ indomethacin ขนาดสูง
- **Colchicine** ได้ผลดีที่สุดเมื่อเริ่มภายใน 24 ชั่วโมง ขนาดปัจจุบันคือ **1.2 mg** แล้วตาม **0.6 mg** ใน **1 ชั่วโมง** (ขนาดต่ำ ได้ผลเท่าขนาดสูงแต่ท้องเสียน้อยกว่ามาก) ต้องลดขนาดใน CKD และระวังร่วมกับ clarithromycin, ciclosporin, statin (เสี่ยง myopathy/รุนแรงถึง pancytopenia)
- **Corticosteroid** ทางเลือกที่ดีเมื่อมีทั้ง CKD และ PUD หรือฉีดเข้าข้อเมื่อเป็นข้อเดียวและตัด septic arthritis ออกแล้ว

ทำไมข้ออื่นผิด

- เริ่ม **allopurinol** เดี่ยว ๆ ตอนกำลั้่งอักเสบ ทำให้ urate แกว่งและ flare นานขึ้น — ถ้าจะเริ่มต้องให้ร่วมกับยากันอักเสบ (colchicine prophylaxis) ต่ออีก 3-6 เดือน และห้ามหยุด allopurinol ที่กินอยู่เดิมเมื่อเกิด flare
- **Colchicine** ทางหลอดเลือดดำ ถูกถอนออกจากตลาดเพราะเสียชีวิตจาก bone marrow suppression
- **Aspirin** ขนาดต่ำถึงกลาง ลดการขับ urate ทางไต ทำให้แย่ลง

HIGH-YIELD PEARL

Flare เก้าที่เลือกยาตามโรคร่วม: PUD/CKD → colchicine ขนาดต่ำหรือสเตียรอยด์; ห้ามเริ่ม **allopurinol** เดี่ยว ๆ ตอนอักเสบ แต่ก็ห้ามหยุดตัวที่กินอยู่

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โปย MCQ ข้อ 21 'Gout ให้ colchicine'
- ACR Gout Guideline 2020

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.5(1)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.4(1)** Non-steroidal anti-inflammatory drugs — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28
- **NL B5.4(4)** Drugs for treatment of gout and hyperuricemia — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28

18. ตอบ D Urate-lowering therapy — indication and target AIR-MCQ-18 · Lec 23

ข้อบ่งชี้ของ **urate-lowering therapy (ULT)** — flare ตั้งแต่ 2 ครั้ง/ปี, มี **tophus**, มี กระดูกถูกทำลายจากเก๊าท์, หรือมีนิ่วไตจาก urate (พิจารณาเมื่อ CKD stage 3 ขึ้นไป หรือ urate > 9 mg/dL) — เคสนี้เข้าเกณฑ์หลายข้อ

หลักการให้ที่มีกออกสอบ

1. **Start low, go slow** — allopurinol เริ่ม 100 mg/วัน (50 mg ถ้า CKD) ค่อยเพิ่มทุก 2-5 สัปดาห์ ลดทั้งความเสี่ยง flare และ SCAR
2. ให้ **prophylaxis** ด้วย colchicine ขนาดต่ำ (หรือ NSAID ขนาดต่ำ) ต่ออีก **3-6 เดือน** เพราะช่วงที่ urate ลดเร็วจะกระตุ้น flare
3. **Treat to target** — ลดให้ **< 6 mg/dL** (และ < 5 mg/dL เมื่อมี tophus) แล้ว ใหยาต่อไปตลอด ไม่ใช่หยุดเมื่อค่าปกติ
4. คัดกรอง ***HLA-B*58:01*** ในคนเอเชียก่อนเริ่ม allopurinol

ทำไมข้ออื่นผิด — เริ่มขนาดสูงทันทีโดยไม่มี prophylaxis ทำให้ flare และเสี่ยง hypersensitivity; การไม่ให้ ULT ทั้งที่มี tophus ปลดปล่อยให้ออกทำลาย; probenecid เป็นยาทางเลือกรอง ห้ามใช้เมื่อมีนิ่วหรือ urate ในปัสสาวะสูง; การคุมอาหารอย่างเดียวลด urate ได้เพียงราว 1 mg/dL

HIGH-YIELD PEARL

ULT: เริ่มต่ำ ค่อยเพิ่ม + **colchicine** กัน flare 3-6 เดือน + คุม urate < 6 (มี tophus < 5) แล้วกินตลอด

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 โปย MCQ gout management
- ACR Gout Guideline 2020; EULAR 2016

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.5(1)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27
- **NL B5.4(4)** Drugs for treatment of gout and hyperuricemia — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28
- **NL B5.3(4)** Serum uric acid — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

19. ตอบ C Drug-induced hyperuricemia AIR-MCQ-19 · Lec 23

Pyrazinamide คือยาต้านวัณโรคที่ทำให้ **uric acid** สูงชัดเจนที่สุด กลไก: metabolite **pyrazinoic acid** ยับยั้งการขับ urate ที่ท่อไตส่วนต้น (URAT1) → urate คั่ง → เกิดกำเริบหรือปวดข้อแบบ non-gouty arthralgia

Ethambutol กีดกันการขับ **urate** ได้เช่นกันแต่รุนแรงน้อยกว่า — โปยเก่าจึงมีทั้งตัวเลือก "pyrazinamide" และ "pyrazinamide + ethambutol" ถ้าโจทย์ให้เลือก ยาตัวเดียวที่รับผิดชอบมากที่สุด ตอบ **pyrazinamide**

การจัดการ — ถ้าเป็นเพียง **hyperuricemia** ที่ไม่มีอาการ ไม่ต้องหยุดยาและไม่ต้องรักษา; ถ้ามี flare ให้รักษาอาการด้วย NSAID/colchicine/สเตียรอยด์ตามโรคร่วม และมักหายเองหลังจบ intensive phase; หยุด pyrazinamide เฉพาะเมื่อข้ออักเสบรุนแรงคุมไม่ได้

ทำไมข้ออื่นผิด — isoniazid ทำให้เกิด peripheral neuropathy (ป้องกันด้วย pyridoxine), drug-induced lupus และตับอักเสบ; rifampicin ทำให้สารคัดหลั่งสีส้ม, ตับอักเสบ และเป็นตัวเหนียวนาเอนไซม์; streptomycin เป็นพิษต่อหูและไต; fluoroquinolone ทำให้เอ็นอักเสบหรือขาด

HIGH-YIELD PEARL

ยาวัณโรคทำให้ **uric acid** สูง = **pyrazinamide** (ethambutol เสริมได้) — ถ้าไม่มีอาการ ไม่ต้องรักษาและไม่ต้องหยุดยา

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โปย MCQ ข้อ 5 และข้อ 72 'ยา TB ปวดข้อเป็น gout > pyrazinamide (+ethambutol)'
- WHO TB treatment guideline 2022

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.5(1)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.3(4)** Serum uric acid — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28

20. ตอบ B Septic arthritis — organism and initial therapy AIR-MCQ-20 · Lec 23

Gram-positive cocci เป็นกลุ่ม (cluster) = **Staphylococcus aureus** ซึ่งเป็นเชื้อก่อ **septic arthritis** ที่พบบ่อยที่สุดในผู้ใหญ่ (ในผู้ป่วยหนุ่มสาวที่มีเพศสัมพันธ์หลายคู่ ให้นึกถึง **Neisseria gonorrhoeae** ซึ่งมีกมา triad: tenosynovitis + ผื่นตุ่มหนอง + migratory polyarthralgia และตอบสนองต่อ ceftriaxone)

การรักษา มี 2 ขาเสมอ: ระบายหนอง + ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ

- ระบายหนอง ด้วยการเจาะซ้ำทุกวัน, arthroscopic lavage หรือผ่าตัด — เพราะหนองในข้อทำลายกระดูกอ่อนด้วยเอนไซม์และยาปฏิชีวนะเข้าไม่ถึงเพียงพอ
- ยา เริ่ม cloxacillin (หรือ cefazolin) สำหรับ MSSA; ถ้าเสี่ยง MRSA ให้ vancomycin ก่อน แล้วปรับตามผลเพาะเชื้อ ให้ IV ประมาณ 2 สัปดาห์แล้วต่อด้วยยากิน รวม 3-4 สัปดาห์

ทำไมข้ออื่นผิด — ยาวางเดียวโดยไม่ระบายหนองทำให้ข้อพัง; สเตียรอยด์ฉีดเข้าข้อที่ติดเชื้อเป็นข้อห้ามเด็ดขาด; ยากินผู้ป่วยนอกในข้อติดเชื้อไม่เพียงพอ; colchicine รักษาฟลิคซิงเกสส์ไม่มี

HIGH-YIELD PEARL

Septic arthritis = ระบายหนอง + ยาฉีด เสมอ; GPC cluster = *S. aureus* → cloxacillin, หนุ่มสาวเพศสัมพันธ์เสี่ยง = gonococcus → ceftriaxone

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โปย MCQ ข้อ 8 'Knee pain c/s gram positive cocci in cluster' ให้ IV cloxacillin'
- IDSA/BSR septic arthritis guidance

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(6)** Infective arthritis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.2.2-3(1)** Infective arthritis (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 26
- **NL B5.3(3)** Synovial fluid analysis — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL 2.1.1** ไข้ (fever) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

21. ตอบ A Beta-lactam induced neutropenia AIR-MCQ-21 • Lec 23

Beta-lactam ขนาดสูงนานเกิน **10-14 วัน** ทำให้เกิด **neutropenia** ได้บ่อย (cloxacillin, piperacillin, nafcillin เป็นตัวที่รายงานมากที่สุด) กลไกเป็น immune-mediated หรือกดไขกระดูกโดยตรง ลักษณะสำคัญคือ เกิดช่วงสัปดาห์ที่ **2-3** ของการรักษา และกลับเป็นปกติภายใน **1-2** สัปดาห์หลังหยุดยา

แนวทาง — ANC 500–1,000 และผู้ป่วยดีขึ้นแล้ว ให้ เปลี่ยนไปกลุ่มยาอื่นที่ครอบคลุมเชื้อเดิม (เช่น cefazolin หรือ clindamycin ตามผลความไว) แล้วติดตาม CBC ซ้ำ 2–3 วัน ไม่ต้อง G-CSF ในผู้ป่วยที่ไม่มีไข้และ ANC ไม่ต่ำมาก

ทำไมข้ออื่นผิด

- ใหยาเดิมต่อแล้วตรวจอีกเดือนหน้า เสี่ยง agranulocytosis (ANC < 500) และ febrile neutropenia
- **G-CSF** พร้อมยาเดิม ไม่แก้ต้นเหตุและไม่ใช่อุปสรรคมาตรฐาน
- **Bone marrow biopsy** ไม่จำเป็นเมื่อสาเหตุจากยาชัดเจนและซีรีส์อื่นปกติ ให้ทำเมื่อค่าไม่ฟื้นหลังหยุดยา
- หยุดยาทั้งหมดทันที ในข้อติดเชื้อมีการรักษาไม่ครบ course เสี่ยงกำเริบ

HIGH-YIELD PEARL

Neutropenia สัปดาห์ที่ 2 ของ beta-lactam ขนาดสูง = **drug-induced** — เปลี่ยนกลุ่มยา ไม่ใช่หยุดยาทั้งหมดหรือเจาะไขกระดูก

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โปย MCQ ข้อ 8 (ต่อ) 'ให้ IV cloxacillin 5 วัน มาตรวจติดตาม neutrophil ลด ทำไรต่อ'
- Harrison 21st ed., Drug-induced agranulocytosis

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3-3(5)** Immune deficiency states (neutropenia, asplenia/splenic dysfunction, post-chemotherapy) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61
- **NL 2.3.13-3(6)** Infective arthritis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

22. ตอบ E Osteoarthritis of the knee — first-line management AIR-MCQ-22 · Lec 23

Osteoarthritis คือความล้มเหลวของทั้งข้อ (กระดูกอ่อน กระดูกใต้ผิวข้อ เยื่อหุ้มข้อ กล้ามเนื้อ) จากการเสียดสีกันของกระดูก ไม่ใช่วิธีการอักเสบเป็นหลัก จึงอธิบายอาการได้ครบ: ปวดเมื่อใช้งาน ดีขึ้นเมื่อพัก ข้อฝืดตอนเช้าไม่เกิน 30 นาที และไม่มีอาการทั่วร่างกาย

ลำดับการรักษาที่มีหลักฐานดีที่สุดคือสิ่งที่ไม่ใช่ยา — การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของ quadriceps และการลดน้ำหนัก (ลด 5-10% ลดปวดชัดเจน เพราะแรงที่ผ่านเข้าเท่ากับ 3-6 เท่าของน้ำหนักตัว) ตามด้วย **topical NSAID** ซึ่งแนะนำก่อนยา NSAID ชนิดกินในผู้สูงอายุเพราะผลข้างเคียงระบบย่อยกว่ามาก

ทำไมข้ออื่นผิด

- สเตียรอยด์กินระยะยาว ไม่มีบทบาทใน OA และทำให้กระดูกพรุน (ฉีดเข้าข้อได้เป็นครั้งคราวเมื่อปวดมาก แต่ไม่เกิน 3-4 ครั้ง/ปี)
- **Hyaluronic acid** หลักฐานประโยชน์น้อย ไม่ใช่ first line
- ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ สงวนไว้เมื่อการรักษาแบบประคับประคองเต็มที่แล้วยังปวดจนกระทบคุณภาพชีวิต
- **Opioid** ระยะยาว ไม่แนะนำใน OA เพราะประโยชน์น้อยและเสี่ยงติด

HIGH-YIELD PEARL

OA = ออกกำลังกาย + ลดน้ำหนัก + **topical NSAID** มาก่อนเสมอ; ข้อฝืดเช้า < 30 นาทีและไม่มีอาการอักเสบทั่วร่างกาย

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 โปย MCQ OA เข้า
- ACR/AF Osteoarthritis Guideline 2019

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.7(1)** Osteoarthritis (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.7 Degenerative disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13(5)** Osteoarthritis (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.1.27** ปวดข้อ ข้อฝืด ข้อติด (joint pain, stiff joint, frozen joint) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL B5.4(1)** Non-steroidal anti-inflammatory drugs — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28
- **NL B5.3(1)** Plain film of bones and joints — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 27

23. ตอบ D Osteoarthritis versus rheumatoid arthritis AIR-MCQ-23 · Lec 23

จุดแยกที่แม่นที่สุดคือ 'ข้อไหน' และ 'ข้อฝืดตอนเช้านานเท่าไร'

	Rheumatoid arthritis	Osteoarthritis
ข้อที่เป็น	MCP, PIP , ข้อมือ (สองข้างสมมาตร) เจ็บ DIP	DIP (Heberden), PIP (Bouchard) , CMC นิ้วโป้ง, เข่า สะโพก
ข้อฝืดตอนเช้า	> 1 ชั่วโมง	< 30 นาที
ปวดสัมพันธ์กับ	พักแล้วแย่ลง ใช้งานแล้วดีขึ้น	ใช้งานแล้วแย่ลง พักแล้วดีขึ้น
บวม	นุ่ม อุ่น (synovitis)	แข็งเป็นปุ่มกระดูก
อาการทั่วร่างกาย	อ่อนเพลีย ไข้ต่ำ น้ำหนักลด	ไม่มี
ภาพรังสี	periarticular osteopenia, marginal erosion , ช่องข้อแคบสม่ำเสมอ	osteophyte, subchondral sclerosis/cyst , ช่องข้อแคบไม่สม่ำเสมอ
Lab	RF/anti-CCP บวกได้, ESR/CRP สูง	ปกติ

ทำไมข้ออื่นผิด — DIP บวมเป็นปุ่มกระดูกคือ **Heberden node** ของ **OA** (RA แทบไม่เป็น DIP), ปวดเมื่อใช้งานคือลักษณะ OA, ส่วนช่องข้อแคบและ crepitus พบได้ทั้งสองโรคจึงแยกไม่ได้

ข้อควรระวังจากโจทย์ — มีข้อที่ให้ 'periarticular osteopenia' ที่ PIP/MCP, ช่องข้อแคบเล็กน้อย ไม่มี erosion, ANA และ RF ลบ' แล้วให้เลือกระหว่าง OA กับ RA: ตำแหน่ง MCP/PIP + osteopenia รอบข้อเข้าได้กับ **seronegative RA** ระยะแรก มากกว่า OA เพราะ OA ไม่ทำให้เกิด periarticular osteopenia และไม่ค่อยเป็น MCP — RF ลบพบได้ถึง 20-30% ของ RA

HIGH-YIELD PEARL

MCP/PIP + ฝืดเช้า > 1 ชม. = RA · DIP เป็นปุ่มกระดูก + ฝืด < 30 นาที = OA; RF ลบไม่ตัด RA ออก

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โจทย์ Joint ข้อ 2 'ปวดข้อนิ้วมือ MCP/PIP สองข้างเท่ากัน ปวดมากขึ้นตอนเช้า → RA'
- MED33 โจทย์ MCQ ข้อ 4 'Morning stiffness more than 30 minutes'
- MED34 โจทย์ 'Osteopenia at PIP, MCP; ANA negative RF negative'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(12)** Rheumatoid arthritis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.3.13(5)** Osteoarthritis (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.2.7(1)** Osteoarthritis (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.7 Degenerative disorders หน้า 27
- **NL B5.3(5)** Serologic studies: antinuclear antibody (ANA), rheumatoid factor — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL 2.1.27** ปวดข้อ ข้อฝืด ข้อติด (joint pain, stiff joint, frozen joint) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

24. ตอบ A Soft-tissue rheumatism AIR-MCQ-24 · Lec 23

Finkelstein test บวก = **de Quervain tenosynovitis** คือการอักเสบของปลอกหุ้มเอ็น **abductor pollicis longus** และ **extensor pollicis brevis** ที่ first dorsal compartment จากการใช้งานซ้ำ ๆ (อุ้มเด็ก ยกของด้วยนิ้วโป้ง พิมพ์มือถือ) พบบ่อยในหญิงหลังคลอดและผู้ดูแลทารก

การรักษา — พัก ใส่ thumb spica splint, topical/oral NSAID, ถ้าไม่ดีขึ้นฉีดสเตียรอยด์เข้าปลอกเอ็น (ได้ผลดีมาก) ผ่าตัดเมื่อล้มเหลว

ทำไมข้ออื่นผิด

- **RA** ต้องมี synovitis บวมหลายข้อสมมาตรและข้อผิดตอนเช้านาน — เคสนี้ไม่มี
- **First CMC OA** เจ็บที่ฐานนิ้วโป้งและ **grind test** บวก (กดหมุนข้อ) ไม่ใช่ Finkelstein
- **Carpal tunnel syndrome** เป็นอาการชาตามแนว median nerve (นิ้วโป้ง ชี้ กลาง) แยกตอนกลางคืน ตรวจ Tinel/Phalen บวก ไม่ใช่ปวดเฉพาะที่เอ็น
- **Gout** ที่ข้อมือ จะบวมแดงร้อนเจ็บพอง มีน้ำในข้อและพบผลึกได้

ภาพรวมของกลุ่ม **soft-tissue rheumatism** ที่เกณฑ์แพทยสภากำหนดให้วินิจฉัยและรักษาเบื้องต้นได้เอง ได้แก่ tendinitis, tenosynovitis, bursitis, fasciitis (เช่น plantar fasciitis) และ myofascial pain syndrome — ทั้งหมดเป็น **periarticular** จึงเจ็บเฉพาะจุด กดเจ็บตามแนวเอ็น และเจ็บเมื่อขยับแบบต้านแรง แต่ ขยับข้อแบบ **passive** ได้เกือบเต็มพิสัย ต่างจากโรคในข้อจริง

HIGH-YIELD PEARL

เจ็บเฉพาะจุด + ขยับ **passive** ได้เกือบเต็ม = **periarticular (soft-tissue rheumatism)** ไม่ใช่โรคข้อ; Finkelstein บวก = de Quervain

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 โปย MCQ soft tissue rheumatism
- ACR primer on regional musculoskeletal pain

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.3(1)** Soft-tissue rheumatism (tendinitis, tenosynovitis, bursitis, fasciitis, myofascial pain syndrome) (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.3 Traumatic and mechanical disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13(7)** Soft-tissue rheumatism (tendinitis, tenosynovitis, bursitis, fasciitis, myofascial pain syndrome) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.1.26** ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก (musculoskeletal pain) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

25. ตอบ D Reactive arthritis AIR-MCQ-25 · Lec 23

Oligoarthritis ของข้อใหญ่ขาส่วนล่าง แบบไม่สมมาตร เกิด **1-4** สัปดาห์หลังติดเชื้อทางเดินอาหาร (**Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia**) หรือทางเพศสัมพันธ์ (**Chlamydia**) = **reactive arthritis** ซึ่งอยู่ในกลุ่ม **spondyloarthropathy** (สัมพันธ์กับ HLA-B27)

Triad คลาสสิก — ข้ออักเสบ + เยื่อตาอักเสบ + ท่อปัสสาวะอักเสบ ("can't see, can't pee, can't climb a tree") พบครบไม่ถึงหนึ่งในสาม ลักษณะอื่นที่ช่วย: **enthesitis** (เจ็บที่เอ็นร้อยหวายเกาะกระดูก), dactylitis (นิ้ววมทั้งนิ้ว), keratoderma blennorrhagicum, ปวดหลังส่วนล่างแบบอักเสบ

หัวใจคือ 'ข้อปลอดเชื้อ' — เพาะเชื้อจากน้ำไขข้อไม่ขึ้น เพราะเป็นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันหลังติดเชื้อ ไม่ใช่เชื้ออยู่ในข้อ ต่างจาก septic arthritis ที่ WBC มักเกิน 50,000 และเพาะขึ้น

การรักษา — NSAID เป็นหลัก, ฉีดสเตียรอยด์เข้าข้อได้, ใหยาปฏิชีวนะเฉพาะเมื่อยังมีการติดเชื้อ Chlamydia อยู่ (ไม่ได้รักษาตัวข้ออักเสบ), ถ้าเรื้อรังเกิน 3-6 เดือนใช้ sulfasalazine

ทำไมข้ออื่นผิด — gout ไม่มีเยื่อตาอักเสบและพบผลึก; SLE เป็น polyarthritis สมมาตรพร้อมอาการหลายระบบและ ANA บวก; RA เป็นข้อเล็กสมมาตรและไม่สัมพันธ์กับการติดเชื้อนำมาก่อน

HIGH-YIELD PEARL

ท้องเสีย/ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ → 1-4 สัปดาห์ → ข้ออักเสบไม่สมมาตรขาส่วนล่าง + ตาแดง + แสบขัด = **reactive arthritis** ข้อปลอดเชื้อ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 โปย MCQ arthritis หลังท้องเสีย
- Harrison 21st ed., Reactive Arthritis

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.2-3(3)** Spondyloarthropathies (e.g., ankylosing spondylitis, reactive arthritis) (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 26
- **NL 2.3.13-3(13)** Spondyloarthropathies (ankylosing spondylitis, reactive arthritis) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.1.27** ปวดข้อ ข้อฝืด ข้อติด (joint pain, stiff joint, frozen joint) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL B5.3(3)** Synovial fluid analysis — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28

26. ตอบ C Asymptomatic hyperuricemia AIR-MCQ-26 · Lec 23

Hyperuricemia ที่ไม่มีอาการ ไม่ใช่โรค — คนที่ urate สูงส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นเก๊าท์เลยตลอดชีวิต (อุบัติการณ์เกิด flare ราว 1-5% ต่อปีแม้ urate > 9)

ACR 2020 แนะนำ 'ไม่ให้' **ULT** ในผู้ที่ไม่มีอาการ ไม่ว่าค่าจะสูงเท่าไร (conditional recommendation) เพราะประโยชน์ไม่ชัดเจนที่มีความเสี่ยง SCAR โดยเฉพาะในคนเอเชียที่มี HLA-B*58:01

สิ่งที่ควรทำแทน — หาสาเหตุที่แก้ได้: ยาขับปัสสาวะกลุ่ม thiazide/loop, low-dose aspirin, ciclosporin, pyrazinamide, แอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์, เครื่องดื่มฟรุคโตสสูง, อ้วน, metabolic syndrome และคัดกรองโรคหัวใจและไต

ทำไมข้ออื่นผิด — การให้ ULT หรือ colchicine ป้องกันในคนไม่มีอาการเป็นการรักษาตัวเลขไม่ใช่รักษาคน; probenecid ยังไม่เหมาะเพราะเสี่ยงนิ่วไต; การอัลตราซาวด์ทุกข้อทุกปีไม่มีข้อบ่งชี้ (ultrasound มีประโยชน์เมื่อสงสัยเก๊าท์แต่เจาะข้อไม่ได้ — จะเห็น double contour sign)

HIGH-YIELD PEARL

urate สูงแต่ไม่มีอาการ = ไม่ต้องให้ยา — ไปแก้ยาและพฤติกรรมที่ทำให้สูงแทน

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- ACR Gout Guideline 2020
- MED31 โปย MCQ asymptomatic hyperuricemia

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.3(4)** Serum uric acid — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL B5.4(4)** Drugs for treatment of gout and hyperuricemia — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28
- **NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

27. ตอบ B Chronic tophaceous gout AIR-MCQ-27 • Lec 23

Tophus คือก้อนของผลึก **monosodium urate** ที่มี **granulomatous reaction** ล้อมรอบ เมื่อสะสมข้างกระดูกจะกดและกัดกร่อนกระดูกจากนอกเข้าไป ได้ภาพ **punched-out (rat-bite) erosion** ขอบชัด มี **sclerotic margin** และ **overhanging edge** ในขณะที่ ช่องข้อยังกว้างปกติจนระยะท้าย เพราะกระดูกอ่อนถูกทำลายช้ากว่า

เทียบกับโรคอื่นบนฟิล์ม

โรค	ลักษณะเด่น	ข้อข้อ
Chronic gout	punched-out erosion, overhanging edge, tophus เนื้อเยื่ออ่อน	กว้างปกติจนระยะท้าย
RA	marginal erosion + periarticular osteopenia	แคบสม่ำเสมอเร็ว
OA	osteophyte, subchondral sclerosis/cyst	แคบเฉพาะด้านที่รับน้ำหนัก
Septic arthritis	ทำลายกระดูกทั้งสองด้านเร็วมากในไม่กี่สัปดาห์	แคบเร็ว

การรักษา **tophaceous gout** — ULT เป้าหมาย **urate < 5 mg/dL** เพื่อละลาย tophus (ยิ่งต่ำยิ่งละลายเร็ว) ใช้เวลาหลายเดือนถึงปี ร่วมกับ prophylaxis กัน flare ระหว่างลดค่า

HIGH-YIELD PEARL

Tophaceous gout บนฟิล์ม = **punched-out erosion + overhanging edge + ช่องข้อยังกว้าง**; รักษาโดยคุม urate < 5 เพื่อละลาย tophus

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 โปย MCQ chronic gout
- ACR Gout Guideline 2020

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.5(1)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.3(1)** Plain film of bones and joints — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 27
- **NL B5.4(4)** Drugs for treatment of gout and hyperuricemia — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28

28. ตอบ B Polyarticular gout in the elderly AIR-MCQ-28 · Lec 23

เก๊าท์ในผู้สูงอายุหญิงมักไม่มาแบบ **podagra** คลาสสิก แต่มาเป็น **polyarticular** ที่มี **DIP** และมี **tophus** บนปุ่มนิ้วซึ่งดูคล้าย **Heberden node** หรือ **rheumatoid nodule** ปัจจัยเสี่ยงเด่นคือ ยาขับปัสสาวะ **thiazide** (ลดการขับ urate) ร่วมกับไตเสื่อมตามวัยและภาวะหลังหมดประจำเดือน (estrogen ช่วยขับ urate จึงมาเป็นหลังวัยทอง)

สิ่งที่ตัดสินคือการเจาะพบผลึก — ผลึกเข็ม **negatively birefringent** ยืนยันเก๊าท์โดยไม่ต้องเดาจากภาพรวม และ RF/anti-CCP ที่ลบยิ่งลดน้ำหนักของ RA

ทำไมข้ออื่นผิด — seronegative RA และ psoriatic arthritis ไม่ทำให้พบผลึก urate; erosive OA เป็น DIP/PIP แต่ไม่มีผลึกและไม่มี tophus; CPPD ให้ผลึก rhomboid positive birefringent

บทเรียนการรักษา — เปลี่ยน thiazide เป็นยาลดความดันที่เป็นกลางหรือช่วยขับ urate เช่น **losartan** หรือ amlodipine แล้วเริ่ม ULT พร้อม prophylaxis

HIGH-YIELD PEARL

หญิงสูงอายุกิน thiazide + ปุ่มที่นิ้วคล้าย RA/OA — เจาะดูผลึกก่อนสรุป; losartan เป็นยาลดความดันที่ช่วยลด urate

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 โปย MCQ gout ในผู้สูงอายุ
- ACR Gout Guideline 2020

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.5(1)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.3(3)** Synovial fluid analysis — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL B5.3(4)** Serum uric acid — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28

29. ตอบ E Gout with chronic kidney disease AIR-MCQ-29 · Lec 23

CKD ไม่ใช่ข้อห้ามของ allopurinol — เป็นเหตุผลให้เริ่มขนาดต่ำและปรับขึ้นช้า ๆ

- ขนาดเริ่ม 50 mg/วันเมื่อ eGFR < 30 (100 mg/วันเมื่อไตปกติ) แล้วเพิ่มทีละ 50 mg ทุก 2-5 สัปดาห์ จนถึงเป้าหมาย **urate** ไม่ใช่จนถึงขนาดตายตัว — ACR 2020 อนุญาตให้เพิ่มเกินขนาดที่ปรับตาม creatinine clearance ได้ถ้าค่อย ๆ เพิ่มและติดตาม เพราะการจำกัดขนาดตาม eGFR อย่างเดียวทำให้คุม urate ไม่ได้
- **ทำไมต้องช้า** — oxypurinol ค้างใน CKD และการเพิ่มขนาดเร็วคือปัจจัยเสี่ยงหลักของ allopurinol hypersensitivity syndrome
- **Febuxostat** เป็นทางเลือกเมื่อ allopurinol ใช้ไม่ได้ ไม่ต้องปรับขนาดมากใน CKD แต่มีค่าเตือนเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด

ทำไมข้ออื่นผิด

- **ไม่ให้ ULT** เลย ปล่อยให้ข้อถูกทำลายและ flare บ่อยขึ้น ทั้งที่ CKD คือกลุ่มที่ควรได้ ULT มากขึ้นด้วยซ้ำ
- **300 mg** ทันที เสี่ยง SCAR สูงสุด
- **Probenecid** ไม่ได้ผลเมื่อ eGFR < 30 เพราะออกฤทธิ์ที่ท่อไต และเพิ่มความเสี่ยงน้ำ
- **NSAID** ซ้ำ ๆ ใน **CKD stage 4** ทำให้ไตแย่ลงและเลือดออกในทางเดินอาหาร

HIGH-YIELD PEARL

CKD: allopurinol เริ่ม 50 mg เพิ่มช้า ๆ จนได้ urate < 6 — ไม่ใช่ห้ามใช้ และไม่ใช่มิถึงขนาดมาตรฐานทันที

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- ACR Gout Guideline 2020
- MED34 โปย MCQ gout with CKD

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.4(4)** Drugs for treatment of gout and hyperuricemia — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28
- **NL B5.3(4)** Serum uric acid — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

30. ตอบ B Osteoporosis after fragility fracture AIR-MCQ-30 • Lec 23

กระดูกหักจากแรงกระทบต่ำ (fragility fracture) ในผู้สูงอายุ = osteoporosis ทางคลินิก ต้องรักษาทันที ไม่ว่าค่า BMD จะเป็นเท่าไร และเคสนี้ยังมี glucocorticoid-induced osteoporosis ซ่อนอยู่ (prednisolone ตั้งแต่ 2.5–7.5 mg/วันนานเกิน 3 เดือน เพิ่มความเสี่ยงกระดูกหักชัดเจน โดยเสี่ยงเพิ่มตั้งแต่ก่อน BMD จะลด เพราะสเตียรอยด์ลด bone formation และเพิ่ม apoptosis ของ osteocyte)

การรักษา — bisphosphonate เป็นยาหลัก (alendronate/risedronate สัปดาห์ละครั้ง หรือ zoledronate ปีละครั้ง) ร่วมกับแคลเซียม 1,000–1,200 mg และวิตามินดี และต้องพยายามลดขนาดสเตียรอยด์ให้ต่ำที่สุดเท่าที่คุมโรคได้

ทำไมข้ออื่นผิด

- แคลเซียมและวิตามินดีอย่างเดียว ไม่ลดการหักซ้ำในผู้ที่มี fracture แล้ว เป็นเพียงยาเสริมพื้นฐาน
- รอวัด BMD ซ้ำอีก 2 ปี เสียเวลาในผู้ที่หักแล้วซึ่งเสี่ยงหักซ้ำสูงสุดในปีแรก
- รอให้หักอีก 2 ครั้ง ไม่มีแนวทางใดแนะนำ
- Calcitonin ประสิทธิภาพต่ำและมีข้อกังวลเรื่องมะเร็ง ไม่ใช่ first line

HIGH-YIELD PEARL

หักจากล้มระดับพื้น = รักษา osteoporosis ทันที; ได้สเตียรอยด์ ≥ 2.5 –7.5 mg นานกว่า 3 เดือน ต้องประเมินกระดูกทุกราย

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 โปย MCQ osteoporosis
- ACR Glucocorticoid-Induced Osteoporosis Guideline 2022

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL B5.2.5(2) Osteoporosis (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27
- NL 2.3.13(6) Osteoporosis (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- NL B5.4(5) Drugs affecting bone metabolism — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28

31. ตอบ B Diagnosis of systemic lupus erythematosus AIR-MCQ-31 · Lec 33

SLE = โรคภูมิคุ้มกันตนเองที่มี **immune complex** ไปสะสมหลายอวัยวะ เคสนี้มีครบทั้งผิวหนัง เยื่อข้อ เลือด และไต ซึ่งเป็นภาพคลาสสิก

การตรวจตามลำดับ

1. **ANA** เป็นการตรวจคัดกรอง ความไวสูงมาก (> 95%) — **ANA** ลบแทบตัด **SLE** ออกได้ แต่ความจำเพาะต่ำ (พบบวกได้ในคนปกติ ผู้สูงอายุ ไทรอยด์อักเสบ ตับอักเสบเรื้อรัง)
2. **Anti-dsDNA** และ **anti-Smith** จำเพาะสูงต่อ SLE; anti-dsDNA ยัง สัมพันธ์กับความรุนแรงของ **lupus nephritis** และใช้ติดตามโรค
3. **C3/C4** ต่ำ สะท้อนการใช้ complement ไปกับ immune complex = โรคกำลัง active

เบาะแสที่สำคัญที่สุดในเคสนี้คือ **RBC cast + โปรตีนในปัสสาวะ = glomerulonephritis** ต้องประเมินเพื่อทำ renal biopsy ต่อ

ทำไมข้ออื่นผิด — RF/anti-CCP ใช้กับ RA (RF บวกได้ใน SLE แต่ไม่ช่วยวินิจฉัย), ANCA/anti-GBM ใช้กับ pulmonary-renal syndrome จาก vasculitis, uric acid/ผลึกใช้กับเก๊าท์, anti-Jo-1/CK ใช้กับ inflammatory myopathy

HIGH-YIELD PEARL

ANA = คัดกรอง (ลบแทบตัดออก) · **anti-dsDNA + anti-Sm =** ยืนยัน · **C3/C4 ต่ำ = active** — และ RBC cast แปลว่าไตอักเสบจนกว่าจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 โปย MCQ SLE
- EULAR/ACR SLE Classification Criteria 2019

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.2.2-3(5)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 26
- **NL B5.3(5)** Serologic studies: antinuclear antibody (ANA), rheumatoid factor — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

32. ตอบ A Lupus nephritis — indication for renal biopsy AIR-MCQ-32 • Lec 33

Lupus nephritis แบ่งเป็น class I-VI ตาม ISN/RPS และ 'class เป็นตัวกำหนดการรักษา' ซึ่งดูจากเลือดหรือปัสสาวะไม่ได้

- **Class I-II (mesangial)** — ให้การรักษาประคับประคอง คุมความดัน ให้ ACEI/ARB ไม่ต้องกดภูมิแรง
- **Class III/IV (focal/diffuse proliferative)** — รุนแรงที่สุด ต้อง induction ด้วย สเตียรอยด์ขนาดสูง + mycophenolate หรือ cyclophosphamide (พิจารณาเพิ่ม belimumab/voclosporin)
- **Class V (membranous)** — โปรตีนรั่วมาก เสี่ยง thrombosis แนวทางต่างจาก proliferative
- **Class VI (sclerotic)** — เนื้อไตพังแล้ว การกดภูมิไม่ช่วย

ข้อบ่งชี้ **biopsy** — proteinuria ≥ 0.5 g/วัน (หรือ UPCR ≥ 0.5 g/g) โดยเฉพาะเมื่อมี **active sediment** หรือ creatinine สูงขึ้นโดยไม่มีสาเหตุอื่น — เคสนี้เข้าครบ

ทำไมข้ออื่นผิด — การให้ cyclophosphamide ทุกรายโดยไม่รู้ class ทำให้ผู้ป่วย class II หรือ VI ได้รับพิษยาโดยไม่จำเป็น (มีบุตรยาก ติดเชื้อ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ); การให้ ACEI แล้วรอ 6 เดือนปล่อยให้ไตเสียถาวร; anti-dsDNA ใช้ติดตามไม่ใช่ตัดสินการรักษา; ยังไม่มีข้อบ่งชี้ฟอกไต

HIGH-YIELD PEARL

SLE + โปรตีนรั่ว ≥ 0.5 g/วัน หรือ active sediment → **biopsy** ก่อนเสมอ เพราะ **class** เป็นตัวเลือกยา

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 โปย MCQ lupus nephritis
- KDIGO Glomerular Diseases Guideline 2021

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.2.2-3(5)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 26

33. ตอบ D Drug-induced lupus AIR-MCQ-33 · Lec 33

Drug-induced lupus (DIL) ต่างจาก SLE อย่างชัดเจน และการรักษาคือ 'หยุดยา'

	Drug-induced lupus	Idiopathic SLE
ยาดันเหตุ	hydralazine, procainamide, isoniazid, minocycline, anti-TNF, quinidine	—
อายุ/เพศ	สูงอายุ ชาย:หญิง ใกล้เคียงกัน	หญิงวัยเจริญพันธุ์เป็นหลัก
อาการ	ไข้ ปวดข้อ serositis	หลายระบบ
ไตและสมอง	แทบไม่เป็น	เป็นได้บ่อยและรุนแรง
Anti-histone	บวก > 95%	บวกได้ ~50%
Anti-dsDNA / Sm	ลบ	บวก
Complement	ปกติ	ต่ำเมื่อ active
การรักษา	หยุดยา	กดภูมิระยยาว

อาการมักดีขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์หลังหยุดยา แม้ ANA อาจบวกอยู่ได้เป็นเดือนถึงปี ให้ NSAID หรือสเตียรอยด์สั้น ๆ ถ้าอาการมาก
ห้ามใช้อินทิด — การใช้ยากดภูมิแรงหรือ cyclophosphamide ในภาวะที่หายเองเมื่อหยุดยาคือการทำร้ายผู้ป่วย; การใช้ยาดันเหตุต่อไม่ว่าขนาดใดทำให้โรคคงอยู่; renal biopsy ไม่มีข้อบ่งชี้เมื่อปัสสาวะและการทำงานของไตปกติ

HIGH-YIELD PEARL

Anti-histone บวก + anti-dsDNA ลบ + complement ปกติ + ไม่เข้าไตเข้าสมอง = drug-induced lupus → หยุดยา

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โปย MCQ ข้อ 7 'SLE ยา hydralazine'
- Harrison 21st ed., Drug-induced lupus

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.13-3(15) Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- NL B5.3(5) Serologic studies: antinuclear antibody (ANA), rheumatoid factor — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- NL 2.1.1 ไข้ (fever) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

34. ตอบ D Antiphospholipid syndrome — investigation AIR-MCQ-34 · Lec 33

Antiphospholipid syndrome (APS) = การเกิดลิ่มเลือด (หลอดเลือดดำแดง หรือหลอดเลือดขนาดเล็ก) และ/หรือภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม ร่วมกับ **antiphospholipid antibody** ที่บวกซ้ำ

ต้องครบทั้งเกณฑ์คลินิกและเกณฑ์แล็บ

- **คลินิกทางสูติกรรม:** แท้งก่อน 10 สัปดาห์ ≥ 3 ครั้งติดต่อกัน หรือ ทารกตายในครรภ์ ≥ 10 สัปดาห์ ≥ 1 ครั้ง หรือ คลอดก่อนกำหนดจาก preeclampsia/placental insufficiency
- **แล็บ:** LA, anticardiolipin (IgG/IgM titer กลาง-สูง), anti- β 2GPI ข้อใดข้อหนึ่ง และ ต้องบวกซ้ำอีกครั้งห่างกันอย่างน้อย **12** สัปดาห์ เพื่อตัด antibody ชั่วคราวหลังติดเชื้อออก

ทำไมข้ออื่นผิด

- **Anti-SSA/SSB** สัมพันธ์กับ Sjogren และ **neonatal lupus/congenital heart block** ไม่ใช่สาเหตุของลิ่มเลือดและแท้งซ้ำ (เป็นตัวลวงที่โพลยเก๋ใส่ไว้)
- **Anti-histone** ใช้กับ drug-induced lupus
- **ANCA** ใช้กับ small-vessel vasculitis
- **Factor V Leiden** อธิบาย venous thrombosis ได้แต่ไม่อธิบายการแท้งซ้ำ และพบน้อยมากในคนไทย

HIGH-YIELD PEARL

แท้งซ้ำ + ลิ่มเลือด = **APS** → ส่ง **LA, anticardiolipin, anti- β 2GPI** และต้องยืนยันซ้ำที่ **12** สัปดาห์

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โพลย Rheumato ข้อ 3 'หญิงตั้งครรภ์ ประวัติแท้ง 4 ครั้ง แบบ antiphospholipid syndrome ตรวจอะไร — a. Anti SSA (Ro) b. Anti-cardiolipin'
- Sydney/2023 ACR-EULAR APS criteria

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.3(5)** Serologic studies: antinuclear antibody (ANA), rheumatoid factor — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28

35. ตอบ E Obstetric antiphospholipid syndrome — management AIR-MCQ-35 · Lec 33

Obstetric APS รักษาด้วย **low-dose aspirin + heparin** — aspirin เริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์หรือทันทีที่ทราบ และเติม LMWH เมื่อยืนยันการตั้งครรภ์ กลไก: ลดการเกิดลิ่มเลือดที่รก และ heparin ยังยับยั้งการจับของ antibody กับ trophoblast และลด complement activation → เพิ่มอัตราการรอดมีชีพจากราว 50% เป็น 70-80%

ผู้ป่วยรายนี้เคยมี **thrombosis** มาก่อน จึงต้องใช้ **heparin** ขนาดรักษาและให้ต่อหลังคลอดอย่างน้อย **6 สัปดาห์** ซึ่งเป็นช่วงที่เสี่ยงลิ่มเลือดสูงที่สุด

ทำไมข้ออื่นผิด

- **Warfarin** ในไตรมาสแรกเป็นสารก่อวิรูป (warfarin embryopathy: nasal hypoplasia, stippled epiphyses) และข้ามรกทำให้ทารกเลือดออก — heparin ไม่ข้ามรกจึงปลอดภัย
- **Aspirin** อย่างเดียว ไม่พอเมื่อเข้าเกณฑ์ APS โดยเฉพาะรายที่มีประวัติ thrombosis
- **Prednisolone** ขนาดสูง ไม่ช่วยผลลัพธ์การตั้งครรภ์ใน APS และเพิ่ม GDM, ความดันสูง, คลอดก่อนกำหนด
- ไม่ทำอะไรเลย ปล่อยให้แท้งซ้ำทั้งที่ป้องกันได้

HIGH-YIELD PEARL

Obstetric APS = **aspirin** ขนาดต่ำ + **heparin** (ห้าม warfarin ในไตรมาสแรก) และให้ต่อหลังคลอด 6 สัปดาห์

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โปย Rheumato ข้อ 3 (ต่อ)
- EULAR recommendations for APS in adults 2019

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

36. ตอบ E Fever in a lupus patient on immunosuppression AIR-MCQ-36 · Lec 33

ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันตนเองที่ได้ยากดภูมิแล้วมาด้วยไข้ ต้องคิด 'ติดเชื้อ' ก่อน 'โรคกำเริบ' เสมอ เพราะทั้งสองภาวะหน้าตาเหมือนกัน แต่การเดาผิดทางแล้วเพิ่มยากดภูมิอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

ภาพในเคสนี้เข้าได้กับ **PCP** อย่างยิ่ง — ไอแห้ง ขาดออกซิเจนมากกว่าที่ฟังปอดได้ (ฟังปอดมักปกติ) ฝ้าแบบ interstitial สองข้าง LDH สูง และ **lymphopenia** ในผู้ที่ได้ **prednisolone ≥ 20 mg/วัน** นานเกิน **1 เดือน** ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรได้ **TMP-SMX** ป้องกัน อยู่แล้ว

การรักษา — เริ่ม TMP-SMX ขนาดรักษาทันที และเพิ่ม **corticosteroid** เสริมเมื่อ **PaO₂ < 70 mmHg** หรือ **A-a gradient > 35** (ป้องกันการแย่งจากการอักเสบเมื่อเชื้อถูกทำลาย) ระหว่างนั้นส่ง induced sputum หรือ BAL เพื่อยืนยัน และคัดกรอง HIV เสมอ

ทำไมข้ออื่นผิด — การเพิ่มสเตียรอยด์หรือให้ cyclophosphamide โดยยังไม่ตัดการติดเชื้อออกคือความผิดพลาดที่อันตรายที่สุด; amoxicillin ไม่ครอบคลุมเชื้อฉวยโอกาสและอาการหนักเกินกว่าจะรักษาแบบผู้ป่วยนอก; การรอ bronchoscopy โดยไม่ให้นยาในผู้ที่ SpO₂ 88% ทำให้ผู้ป่วยแยลงระหว่างรอ

HIGH-YIELD PEARL

ผู้ป่วยกดภูมิ + ไข้ + ฝ้า interstitial + LDH สูง + ฟังปอดปกติ = **PCP** จนกว่าจะพิสูจน์เป็นอื่น — รักษาก่อน ยืนยันคู่กันไป

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 โปย MCQ 'ช. 30 ปี SLE, lupus nephritis on prednisolone มาด้วยไอ...'
- IDSA/ATS opportunistic infection guidance

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3-3(5)** Immune deficiency states (neutropenia, asplenia/splenic dysfunction, post-chemotherapy) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61
- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.1.1** ไข้ (fever) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

37. ตอบ D Hydroxychloroquine retinopathy AIR-MCQ-37 · Lec 33

Hydroxychloroquine เป็นยาหลักของ **SLE** ที่ควรให้ทุกรายถ้าไม่มีข้อห้าม (ลด flare ลดการเกิด lupus nephritis ลดลิ้มเลือด และเพิ่มอัตราการรอด) แลกกับพิษที่สำคัญที่สุดคือ **retinopathy** แบบ **bull's-eye maculopathy** ซึ่งเมื่อเกิดแล้ว แก้ไม่ได้ จึงต้องคัดกรองก่อนสูญเสียการมองเห็น

แนวทาง **American Academy of Ophthalmology**

- ตรวจตาพื้นฐานภายในปีแรก แล้ว เริ่มคัดกรองทุกปีหลังใช้ยาครบ 5 ปี (เร็วกว่านั้นถ้ามีปัจจัยเสี่ยง: ขนาด > 5 mg/kg/วันของน้ำหนักรจริง, CKD, ใช้ tamoxifen, มีโรคจอตาเดิม)
- เครื่องมือ: **automated visual field 10-2 (หรือ 24-2 ในคนเอเชียเพราะรอยโรคมักอยู่นอกกว่า)** ร่วมกับ **spectral-domain OCT**

หมายเหตุจากโพยเก่า — ข้อเดิมเขียนว่า "maculopathy ห้ามให้ **hydroxyurea**" ซึ่งสับสนชื่อยา; ยาที่ทำให้เกิด maculopathy คือ **hydroxychloroquine** ส่วน hydroxyurea ใช้ในโรคเลือดและมีพิษหลักคือกดไขกระดูกและแผลที่ขา

ทำไมข้ออื่นผิด — การตรวจตับ การไตยีน หรือ CBC ี่ ๆ ไม่ใช้ในการติดตามหลักของยานี้ (LFT/CBC เป็นการติดตามของ methotrexate และ azathioprine)

HIGH-YIELD PEARL

Hydroxychloroquine = ยาหลักของ SLE ที่ต้อง คัดกรองจอตาปีละครั้งหลังใช้ครบ 5 ปี และคุมขนาดไม่เกิน 5 mg/kg/วัน

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โพย Rheumato ข้อ 2 'Maculopathy ห้ามให้ยา (โพยเขียน hydroxyurea)'
- AAO Hydroxychloroquine Screening Recommendations 2016

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.4(3)** Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28

38. ตอบ E Systemic sclerosis — autoantibody testing AIR-MCQ-38 · Lec 33

อาการทางคลินิกมาก่อนแอนติบอดีเสมอ — Raynaud + skin thickening ที่ลามเหนือข้อมือ + crackles ที่ฐานปอด = **diffuse cutaneous systemic sclerosis** ที่มี **interstitial lung disease** ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคนี้

ANA ที่รายงานว่า 'ลบ' ไม่ตัดโรคออก เพราะบางห้องปฏิบัติการใช้วิธีหรือ dilution ที่ไวไม่พอ และ nucleolar/centromere pattern อาจถูกอ่านพลาด จึงต้องส่ง **antibody** จำเพาะ ต่อ

Antibody	สัมพันธ์กับ
Anti-Scl-70 (topoisomerase I)	diffuse cutaneous SSc + interstitial lung disease
Anticentromere	limited cutaneous SSc (CREST) + pulmonary arterial hypertension
Anti-RNA polymerase III	ผิวหนังหนาเร็ว + scleroderma renal crisis + มะเร็งร่วม

และต้องประเมินอวัยวะเสมอ: **HRCT + PFT (FVC, DLCO)** สำหรับปอด, **echocardiography** สำหรับ pulmonary hypertension, วัดความดันโลหิตเองที่บ้านเพื่อจับ renal crisis

ทำไมข้ออื่นผิด — anti-dsDNA สำหรับ SLE, RF สำหรับ RA (บวกได้หลายโรคจึงไม่ช่วย), anti-histone สำหรับ drug-induced lupus, ESR อย่างเดียวไม่จำเพาะและไม่บอกอวัยวะที่ถูกทำลาย

HIGH-YIELD PEARL

Scleroderma: **Scl-70** → ปอด (ILD) · **centromere** → ความดันปอดสูง · **RNA pol III** → renal crisis; ANA ลบไม่ตัดโรคออกเมื่อคลินิกชัด

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โปย Rheumato ข้อ 1 'Systemic sclerosis ฟังปอดได้บางอย่าง ANA negative ตรวจอะไรเพิ่ม'
- EULAR SSc recommendations 2017

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B4.2.2-3(9)** Scleroderma (กลุ่มที่ 3) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24
- **NL B5.3(5)** Serologic studies: antinuclear antibody (ANA), rheumatoid factor — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

39. ตอบ C Scleroderma renal crisis AIR-MCQ-39 · Lec 33

Scleroderma renal crisis (SRC) = ความดันสูงวิกฤต + ไตวายเฉียบพลัน + microangiopathic hemolytic anemia ในผู้ป่วย diffuse SSc ระยะแรก ปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญที่สุดคือ **corticosteroid** ตั้งแต่ **15 mg/วัน** ขึ้นไป (จึงต้องเลี่ยงสเตียรอยด์ขนาดสูงใน SSc)

กลไก — intimal proliferation ของหลอดเลือดแดงเล็กในไต → ไตขาดเลือด → **renin** หลั่งพุ่ง → angiotensin II สูงมาก → ความดันพุ่งและหลอดเลือดฝอยถูกทำลายจนเม็ดเลือดแดงแตก

การรักษา — **ACE inhibitor** ออกฤทธิ์สั้น (**captopril**) คือยาที่เปลี่ยนโรคนี้จากอัตราตายเกือบ **100%** ให้รอดได้ ปรับขนาดขึ้นเร็วทุก 4-8 ชั่วโมงจนคุมความดัน ห้ามหยุดยาเพียงเพราะ **creatinine** สูงขึ้นในช่วงแรก ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดไว้อยู่แล้ว ผู้ป่วยบางรายต้องฟอกไตชั่วคราวแล้วไตฟื้นภายหลัง

ทำไมข้ออื่นผิด — ยาลดความดันกลุ่มอื่นไม่แก้กลไก renin-angiotensin; สเตียรอยด์/cyclophosphamide ยิ่งกระตุ้นหรือไม่ช่วย; ภาพ MAHA ที่นี้มาจาก SRC ไม่ใช่ TTP (TTP จะไม่มีความดันสูงวิกฤตนำและ ADAMTS13 ต่ำมาก); การนัดผู้ป่วยนอกในภาวะ hypertensive emergency คือความผิดพลาดร้ายแรง

HIGH-YIELD PEARL

SSc + ความดันพุ่ง + Cr ขึ้น + schistocyte = **scleroderma renal crisis** → **captopril** ทันที และห้ามหยุดแม้ Cr จะขึ้น

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 โปย MCQ systemic sclerosis
- EULAR SSc recommendations 2017

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B4.2.2-3(9)** Scleroderma (กลุ่มที่ 3) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24
- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

40. ตอบ D Raynaud phenomenon — primary versus secondary AIR-MCQ-40 · Lec 33

แยก **primary** จาก **secondary Raynaud** คือคำถามหลักเสมอ เพราะ **secondary** แปลว่ามีโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซ่อนอยู่และเสี่ยงนิ้วขาดเลือด

	Primary	Secondary
อายุที่เริ่ม	< 30 ปี	> 30 ปี
ความสมมาตร	สองข้างเท่ากัน	ไม่สมมาตรได้
แผล/รอยปุ่มปลายนิ้ว	ไม่มี	มี
ANA	ลบ	บวก (Scl-70, centromere)
Nailfold capillaroscopy	ปกติ	หลอดเลือดโป่ง/หาย (megacapillary, dropout)
อาการอื่น	ไม่มี	ผิวหนังหนา ข้ออักเสบ กลืนติด

เคสนี้เข้าเกณฑ์ primary ทุกข้อ → รักษาแบบไม่ใช้ยา: หลีกเลี่ยงความเย็น ใส่ถุงมือ เลิกบุหรี่ เลี่ยงยาหดหลอดเลือด (เช่น beta-blocker, ยาแก้หวัดที่มี pseudoephedrine, ergotamine) และจัดการความเครียด ถ้าอาการรบกวนชีวิตจึงให้ **dihydropyridine calcium channel blocker (nifedipine)** เป็นยาตัวแรก

ทำไมข้ออื่นผิด — iloprost ทางหลอดเลือดดำสงวนไว้สำหรับ **digital ulcer** หรือ **critical ischemia** ใน secondary Raynaud; สเตียรอยด์ไม่ป้องกันการเกิด SSc และมีโทษ; sympathectomy เป็นทางเลือกท้าย ๆ ของรายที่ดื้อการรักษา; warfarin ไม่มีบทบาทเพราะพยาธิกำเนิดคือ vasospasm ไม่ใช่ลิ่มเลือด

HIGH-YIELD PEARL

Primary Raynaud: อายุน้อย สองข้างเท่ากัน ไม่มีแผลปลายนิ้ว **ANA** ลบ **capillaroscopy** ปกติ → ไม่ต้องใช้ยา

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 โปย MCQ Raynaud
- EULAR/ACR SSc-related vasculopathy guidance

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B4.2.2-3(9)** Scleroderma (กลุ่มที่ 3) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

41. ตอบ C Inflammatory myopathy AIR-MCQ-41 · Lec 33

กล้ามเนื้ออ่อนแรงส่วนต้นทั้งสองข้างแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ปวด + CK สูงมาก + ผื่น heliotrope (เปลือกตาสีม่วง) และ Gottron papules (ที่ข้อนิ้ว) = dermatomyositis

จุดที่ต้องทำเสมอคือค้นหามะเร็งแฝง — dermatomyositis ในผู้ใหญ่สัมพันธ์กับมะเร็งอย่างมีนัยสำคัญ (ราว 15-25% โดยเฉพาะ 1-3 ปีแรกหลังวินิจฉัย): รังไข่ ปอด ตับอ่อน กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ และ nasopharyngeal carcinoma ซึ่งพบมากในคนไทย จึงต้องตรวจตามอายุและเพศ + CT ทรวงอกและช่องท้อง + ตรวจโพรงหลังจมูก

จุดที่พลาดบ่อย — AST/ALT ที่สูงในเคสนี้ มาจากกล้ามเนื้อ ไม่ใช่ตับ (transaminase อยู่ในกล้ามเนื้อละลายด้วย) ให้ยืนยันด้วย CK, aldolase และ GGT ที่ปกติ ก่อนจะไปเจาะตับโดยไม่จำเป็น

การประเมินอื่น — myositis-specific antibody (anti-Jo-1 = antisynthetase syndrome ที่มี ILD, mechanic's hands, ข้ออักเสบ; anti-MDA5 = ผื่นหนังเด่นแต่ ILD รุนแรง), EMG, MRI กล้ามเนื้อหรือชิ้นเนื้อ และประเมินการกลืนกับปอด

ทำไมข้ออื่นผิด — nerve conduction study ใช้แยกโรคเส้นประสาทซึ่งจะอ่อนแรงส่วนปลายและมีอาการชา; uric acid/เจาะข้อไม่เกี่ยว; BMD สำคัญเมื่อเริ่มสเตียรอยด์แต่ไม่ใช่ลำดับแรก

HIGH-YIELD PEARL

อ่อนแรงส่วนต้น + CK สูง + heliotrope/Gottron = dermatomyositis → ต้องคัดกรองมะเร็ง; AST/ALT ที่สูงอาจมาจากกล้ามเนื้อ ไม่ใช่ตับ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โปย MCQ 'Myalgia AST สูงเป็น 1000 ALT ปกติ investigation: CPK'
- Harrison 21st ed., Inflammatory Myopathies

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.2-3(2)** Polymyositis, dermatomyositis (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 26
- **NL 2.3.13-3(10)** Polymyositis, dermatomyositis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.1.22** กล้ามเนื้ออ่อนแรง (muscle weakness) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL 2.1.26** ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก (musculoskeletal pain) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

42. ตอบ D Statin-associated muscle symptoms AIR-MCQ-42 · Lec 33

ปวดกล้ามเนื้อในผู้ที่กิน **statin** ต้องวัด **CK** ก่อนเสมอ เพราะ CK เป็นตัวแยกกลุ่มอาการและกำหนดการจัดการทั้งหมด

ภาวะ	CK	การจัดการ
Myalgia (พบบ่อยที่สุด)	ปกติหรือสูงเล็กน้อย	หยุด statin ชั่วคราว 2-4 สัปดาห์ ดูว่าอาการหายไหม แล้วลองยาตัวอื่น/ขนาดต่ำ/วันเว้นวัน
Myopathy	สูง > 10 เท่า ULN	หยุดยา หาสาเหตุร่วม
Rhabdomyolysis	> 40 เท่า ULN + ปัสสาวะสีเข้ม + ไตวาย	หยุดทันที ให้สารน้ำเข้มข้น
Immune-mediated necrotizing myopathy	สูงมากและ ไม่ดีขึ้นหลังหยุดยา	anti-HMGCR antibody บวก ต้องใช้ยากดภูมิ

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยง — อายุมาก ตัวเล็ก ไตหรือตับบกพร่อง ไทรอยด์ต่ำ (ต้องตรวจ TSH เสมอ) วิตามินดีต่ำ ออกกำลังกายหนัก และยาที่ยับยั้ง CYP3A4 เช่น **clarithromycin, itraconazole, ciclosporin, gemfibrozil**, น้ำเกรปฟรุต โดย simvastatin ไวต่อปฏิกิริยาเหล่านี้มากเป็นพิเศษ

ทำไมข้ออื่นผิด — EMG และชิ้นเนื้อกล้ามเนื้อสงวนไว้เมื่อ CK สูงต่อเนื่องหรือมีอ่อนแรงจริงหลังหยุดยา; anti-HMGCR ตรวจเมื่ออาการไม่หายหลังหยุดยา; myoglobin ไม่ไวและไม่จำเพาะเท่า CK

HIGH-YIELD PEARL

ปวดกล้ามเนื้อ + กิน statin = ส่ง **CK** ก่อน และมองหาสิ่งที่ยับยั้ง CYP3A4 ร่วมด้วยเสมอ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โพลี Rheumato ข้อ 5 'ปวดกล้ามเนื้อ มี dyslipidemia กินยา statin ควรส่งตรวจอะไร — CPK level'
- ACC/AHA statin safety statement

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.1.26** ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก (musculoskeletal pain) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL 2.3.13-3(7)** Myopathy (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.2.5-3(1)** Myopathy (inflammatory myopathy, metabolic myopathy) (กลุ่มที่ 3) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27

43. ตอบ D Polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis AIR-MCQ-43 · Lec 33

Jaw claudication + ปวดศีรษะขมับใหม่ + หนังศีรษะกดเจ็บ + **ESR** สูงมาก ในผู้สูงอายุ = **giant cell arteritis (GCA)** ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินทางตา — หลอดเลือด ophthalmic/posterior ciliary อุดตันทำให้ ตามองถาวรภายในไม่กี่ชั่วโมงถึงวัน และเมื่อ บอดแล้วแก้ไขไม่ได้

หลักการที่ต้องจำ: ให้สเตียรอยด์ก่อน ตรวจยืนยันตามหลัง — prednisolone 40-60 mg/วัน (หรือ pulse methylprednisolone ถ้ามีอาการทางตาแล้ว) แล้วค่อยทำ **temporal artery biopsy** ภายใน **1-2 สัปดาห์** ซึ่งยังให้ผลบวกได้ แม้เริ่มสเตียรอยด์ไปแล้ว (skip lesion ทำให้ผลลบไม่ตัดโรค จึงตัดชิ้นยาว ≥ 1 ซม.) หรือใช้ **ultrasound** หา **halo sign**

ความสัมพันธ์กับ **PMR** — ผู้ป่วย PMR (ปวดเมื่อยไหล่และสะโพกสองข้าง ผิดเข้านาน ESR สูง ตอบสนองดีมากต่อ prednisolone 12.5-25 mg/วัน) ประมาณ 15% มี GCA ร่วม และผู้ป่วย GCA ราวครึ่งหนึ่งมีอาการ PMR — ต้องถามอาการทางตาและ **jaw claudication** ทุกครั้งที่เจอ **PMR**

ทำไมข้ออื่นผิด — การรอผลชิ้นเนื้อคือเหตุผลอันดับหนึ่งของผู้ป่วยตาบอด; ขนาด 15 mg เหมาะกับ PMR เพียงอย่างเดียวและไม่พอ สำหรับ GCA; NSAID ไม่ป้องกันตาบอด; methotrexate/tocilizumab เป็นยาช่วยลดสเตียรอยด์ ไม่ใช่ยาเริ่มต้น

HIGH-YIELD PEARL

ผู้สูงอายุ + ปวดขมับ + **jaw claudication** + ESR สูง = GCA → ให้สเตียรอยด์ทันที อย่ารอ **biopsy**

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 โปย MCQ temporal arteritis
- EULAR large vessel vasculitis recommendations 2018

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.2-3(2b)** Vasculitis syndrome (e.g., Kawasaki disease, polyarteritis nodosa, drug induced) (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13-3(16)** Vasculitis syndrome (Kawasaki disease, polyarteritis nodosa, drug-induced) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.1.26** ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก (musculoskeletal pain) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL 2.1.1** ไข้ (fever) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

44. ตอบ C ANCA-associated vasculitis AIR-MCQ-44 • Lec 33

Pulmonary-renal syndrome = เลือดออกในปอด + **glomerulonephritis** พร้อมกัน วินิจฉัยแยกโรคหลักมี 3 กลุ่ม: ANCA-associated vasculitis, anti-GBM disease (Goodpasture) และ SLE

สิ่งที่ชี้ไปที่ **granulomatosis with polyangiitis (GPA)** ในเคสนี้คือ 'ทางเดินหายใจส่วนบน' — ไซนัสอักเสบเรื้อรัง เลือดออกทางจมูก แผลในจมูก จมูกยุบ (saddle nose) ร่วมกับ **nodule** ที่ปอดซึ่งเป็นโพรงได้ ซึ่ง anti-GBM และ SLE ไม่ทำ

	GPA	Anti-GBM	SLE
ทางเดินหายใจส่วนบน	เป็นเด่น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
ปอด	nodule/cavity, DAH	DAH	pleuritis
แอนติบอดี	c-ANCA (anti-PR3)	anti-GBM	ANA, anti-dsDNA, C3/C4 ต่ำ
ชั้นเนื้อไต	pauci-immune crescentic GN	linear IgG	full-house immune complex

การรักษา — เป็นภาวะคุกคามอวัยวะ ต้อง induction ด้วย สเตียรอยด์ขนาดสูง + **rituximab** หรือ **cyclophosphamide** และพิจารณา plasma exchange ในรายที่ creatinine สูงมากหรือมี DAH รุนแรง — ยิ่งเริ่มช้า ยิ่งเสียไตถาวร

ทำไมข้ออื่นผิด — วัณโรคมีโพรงที่ปอดได้แต่ไม่ทำให้เกิด RBC cast และ AFB จะช่วยแยก; Goodpasture ไม่เข้าไซนัส; SLE มักมี complement ต่ำและอาการหลายระบบอื่น; ปอดบวมธรรมดาไม่ทำให้เกิด glomerulonephritis

HIGH-YIELD PEARL

ไซนัสเรื้อรัง + ปอดเป็นโพรง + ไตอักเสบ = **GPA (c-ANCA/PR3)** — pulmonary-renal syndrome ต้องรีบให้ยากดภูมิ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 โปย MCQ vasculitis
- EULAR/ERA-EDTA ANCA-associated vasculitis recommendations 2022

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.2-3(2b)** Vasculitis syndrome (e.g., Kawasaki disease, polyarteritis nodosa, drug induced) (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13-3(16)** Vasculitis syndrome (Kawasaki disease, polyarteritis nodosa, drug-induced) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.1.1** ไข้ (fever) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

45. ตอบ E IgA vasculitis (Henoch-Schonlein purpura) AIR-MCQ-45 · Lec 33

Tetrad ของ IgA vasculitis: palpable purpura ที่ขาและก้น (บริเวณที่แรงดันน้ำหนักรุนแรง) + ปวดข้อ + ปวดท้อง + ไตอักเสบ หลังติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน — เป็น small-vessel vasculitis จากการสะสม **IgA immune complex**

จุดตัดสินที่โจทย์ให้มาคือ 'purpura ที่คลำได้นูน ร่วมกับเกล็ดเลือดปกติ'

- คลำได้นูน = มีการอักเสบของผนังหลอดเลือด (**vasculitis**)
- เกล็ดเลือดปกติและการแข็งตัวปกติ = ไม่ใช่ ITP หรือ DIC ซึ่งจำจะราบ

สิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง — ภาวะแทรกซ้อนที่กำหนดพยากรณ์โรคคือ ไต (IgA nephropathy แบบเดียวกัน) ต้องตรวจปัสสาวะและความดันเป็นระยะหลายเดือน และในเด็กต้องระวัง **intussusception** จากผนังลำไส้บวม

การรักษา — ส่วนใหญ่หายเอง ให้ประคับประคองและ NSAID สำหรับปวดข้อ (ระวังเมื่อมีไตอักเสบ); สเตียรอยด์ใช้เมื่อปวดท้องรุนแรงหรือมีไตอักเสบมาก

ทำไมข้ออื่นผิด — meningococcemia ปวดหนักและ purpura ลามเร็วพร้อม shock; acute rheumatic fever ให้ข้ออักเสบย้ายที่ + หัวใจอักเสบ + erythema marginatum ไม่ใช่ purpura นูน

HIGH-YIELD PEARL

Palpable purpura + เกล็ดเลือดปกติ = vasculitis; ที่ขา/ก้น + ปวดท้อง + ปัสสาวะมีเลือด หลังเป็นหวัด = IgA vasculitis

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 โปย MCQ purpura
- Harrison 21st ed., The Vasculitis Syndromes

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(2)** Allergic purpura (Henoch-Schonlein purpura) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.2.2-3(2b)** Vasculitis syndrome (e.g., Kawasaki disease, polyarteritis nodosa, drug induced) (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 27
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

46. ตอบ C Early rheumatoid arthritis — treatment AIR-MCQ-46 · Lec 33

RA ทำลายข้ออย่างถาวรเร็วที่สุดใน 2 ปีแรก จึงมีแนวคิด '**window of opportunity**' — ต้องเริ่ม **DMARD** ภายใน 3 เดือนแรกของการ ไม่ใช้รอให้เห็น **erosion**

Methotrexate คือ **anchor drug** เริ่ม 7.5–15 mg สัปดาห์ละครึ่ง (ห้ามให้ทุกวัน — เป็นความผิดพลาดที่ทำให้เสียชีวิตได้) ร่วมกับ **folic acid** เพื่อลดแผลในปาก คลื่นไส้ และพิษต่อดับ ติดตาม CBC, LFT, creatinine ทุก 2–4 สัปดาห์ในช่วงแรก ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือวางแผนมีบุตร (**teratogen**) และเสี่ยงเมื่อดื่มสุรานักหรือมีโรคตับ

Corticosteroid ใช้เป็น 'สะพาน' ขนาดต่ำระยะสั้นระหว่างรอ methotrexate ออกฤทธิ์ (6–12 สัปดาห์) แล้วลดลงจนหยุด ไม่ใช้ยาหลักระยะยาว

ก่อนให้ **biologic (anti-TNF)** ต้องคัดกรอง **latent TB (IGRA/TST + CXR)** และไวรัสตับอักเสบบีเสมอ เพราะเสี่ยง reactivation

ทำไมข้ออื่นผิด — NSAID ลดปวดแต่ไม่หยุดการทำลายข้อ; biologic ไม่ใช่ first line ตามแนวทางเมื่อยังไม่ได้ลอง conventional DMARD (และราคาสูง); การรอ erosion คือการรอให้เกิดความพิการถาวร; สเตียรอยด์เดี่ยวระยะยาวทำให้กระดูกพรุน เบาหวาน ติดเชื้อ

HIGH-YIELD PEARL

RA: เริ่ม **methotrexate** สัปดาห์ละครึ่ง + **folic acid** ให้เร็วที่สุด ใช้สเตียรอยด์เป็นสะพาน และคัดกรอง TB/HBV ก่อน biologic

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 โปย MCQ RA treatment
- ACR RA Treatment Guideline 2021; EULAR 2022

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(12)** Rheumatoid arthritis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.2.2-3(4)** Rheumatoid arthritis (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 26
- **NL B5.4(3)** Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28
- **NL B5.3(5)** Serologic studies: antinuclear antibody (ANA), rheumatoid factor — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28

47. ตอบ E Methotrexate toxicity AIR-MCQ-47 • Lec 33

ผู้ป่วย RA ที่ใช้ methotrexate แล้วมีไข้ + ฝ้าในปอด ต้องแยกสองภาวะที่ต้องหยุดยาทั้งคู่

1. **Methotrexate pneumonitis** — hypersensitivity ต่อยา เกิดได้ทุกช่วงเวลา มาด้วยไอแห้ง เหนื่อย ไข้ ฝ้า interstitial
2. การติดเชื้อฉวยโอกาส — PCP, วัณโรค, เชื้อรา จากภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ (ยิ่งถ้าใช้สเตียรอยด์ร่วม)

ทั้งสองอย่างจัดการเริ่มต้นเหมือนกันคือ หยุด **methotrexate** ทันที ให้ออกซิเจน สังเกตตรวจหาเชื้อ (**sputum, BAL**) และให้ยาปฏิชีวนะครอบคลุมจนกว่าจะตัดการติดเชื้อออก

พิษอื่นของ **methotrexate** — กดไขกระดูก (เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ำอย่างในเคสนี้ ให้ **folinic acid/leucovorin** ช่วย), ตับอักเสบและพังผืด, แผลในปาก, คลื่นไส้ ความเสี่ยงสูงขึ้นเมื่อไตเสื่อม ใช้ร่วมกับ **trimethoprim-sulfamethoxazole** (เสริมฤทธิ์ต้าน folate จนเกิด pancytopenia ได้), NSAID ขนาดสูง หรือสลิมนิกินโพลิก

ห้ามข้ออื่นผิด — การใช้ยาต่อหรือเพิ่มขนาดในภาวะนี้อันตรายถึงชีวิต; ให้โพลิกแล้วรออีกเดือนซ้ำกินไปเมื่อมีทั้งฝ้าปอดและเม็ดเลือดต่ำ; การเริ่ม anti-TNF ขณะสงสัยติดเชื้อเป็นข้อห้าม

HIGH-YIELD PEARL

Methotrexate: ไข้ + ฝ้าปอด = หยุดยา แล้วแยก **pneumonitis** กับการติดเชื้อฉวยโอกาสเสมอ; ระวังคู่กับ TMP-SMX เพราะเสี่ยง pancytopenia

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 โปย MCQ methotrexate toxicity
- ACR RA Guideline 2021

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.4(3)** Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28
- **NL 2.3.3-3(5)** Immune deficiency states (neutropenia, asplenia/splenic dysfunction, post-chemotherapy) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61
- **NL 2.3.13-3(12)** Rheumatoid arthritis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

48. ตอบ A Glucocorticoid complications — osteonecrosis AIR-MCQ-48 • Lec 33

ปวดขาหนีบเมื่อลงน้ำหนัก ในผู้ที่ได้สเตียรอยด์ขนาดสูงนาน = **osteonecrosis (avascular necrosis)** ของหัวกระดูกต้นขา จนกว่าจะพิสูจน์เป็นอื่น — สเตียรอยด์และแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในผู้ใหญ่ (กลไก: ไขมันในไขกระดูกโตขึ้นและ microthrombosis ทำให้ความดันในกระดูกสูงและเลือดไปเลี้ยงลดลง) และ SLE เองก็เพิ่มความเสี่ยง โดยเฉพาะเมื่อมี antiphospholipid antibody

ฟิล์มธรรมดাপกติในระยะแรกเสมอ (กว่าจะเห็น crescent sign หรือหัวกระดูกยุบคือสายแล้ว) — **MRI** คือการตรวจที่ไวและจำเพาะที่สุด และต้องถ่าย ทั้งสองข้าง เพราะเป็นสองข้างได้ถึง 50-80% แม้อีกข้างยังไม่ปวด

เหตุผลที่ต้องรีบ — ถ้าจับได้ก่อนหัวกระดูกยุบ (pre-collapse) ยังมีทางเลือกรักษาข้อไว้ได้ เช่น ลดการลงน้ำหนัก ลดสเตียรอยด์ให้ต่ำที่สุด core decompression; เมื่อยุบแล้วมักจบที่การเปลี่ยนข้อสะโพก

ทำไมข้ออื่นผิด — การรอถ่ายฟิล์มซ้ำอีก 3 เดือนปล่อยให้โรคเข้าสู่ระยะยุบ; bone scan ไว้น้อยกว่า MRI ในระยะแรก; การเจาะข้อเหมาะกับข้อติดแข็งซึ่งจะมีไข้ ข้อบวมร้อน; DXA ประเมินกระดูกพรุนซึ่งเป็นคนละภาวะ (แม้ผู้ป่วยรายนี้ควรได้รับการประเมินด้วยก็ตาม)

HIGH-YIELD PEARL

ปวดสะโพกในคนกินสเตียรอยด์นาน + ฟิล์มปกติ = ส่ง **MRI** สองข้างหา **osteonecrosis** อย่ารอฟิล์มซ้ำ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 โปย MCQ ภาวะแทรกซ้อนของสเตียรอยด์
- Harrison 21st ed., Osteonecrosis

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(8)** Osteonecrosis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.2.5(2)** Osteoporosis (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27

49. ตอบ D Axial spondyloarthritis AIR-MCQ-49 · Lec 33

Inflammatory back pain แยกจาก **mechanical back pain** ด้วย 5 ข้อ: เริ่มก่อนอายุ 45, ค่อยเป็นค่อยไป, ดีขึ้นเมื่อขยับ แยกเมื่อพัก, ตื่นกลางดึกช่วงครึ่งหลัง, ข้อฝืดเช้านานเกิน 30 นาที — เคสนี้เข้าทุกข้อ และมี **acute anterior uveitis** ซึ่งเป็นอาการนอกข้อที่พบบ่อยที่สุดของ spondyloarthritis (สัมพันธ์กับ HLA-B27)

การรักษา

1. ออกกำลังกายและกายภาพบำบัดสม่ำเสมอ เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุด เพื่อรักษาพิสัยการเคลื่อนไหวและป้องกันหลังยึดติด
2. **NSAID** ขนาดเต็ม เป็นยาตัวแรก (ตอบสนองดีมากจนใช้ช่วยวินิจฉัยได้) ลองอย่างน้อย 2 ตัว ตัวละ 2-4 สัปดาห์
3. ถ้ายังคุมไม่ได้ → **anti-TNF** หรือ **anti-IL-17** (คัดกรอง TB/HBV ก่อน)

ข้อที่ออกสอบบ่อย — **conventional DMARD** เช่น **methotrexate** และ **sulfasalazine** ไม่ได้ผลกับโรคแกนกลาง (**axial**) ใช้ได้เฉพาะเมื่อมีข้อส่วนปลายอักเสบร่วม

ทำไมข้ออื่นผิด — การนอนพักทำให้อาการแย่ลงและเร่งการยึดติด; สเตียรอยด์ระยะยาวไม่มีประโยชน์ในโรคแกนกลางและมีโทษ; การผ่าตัดสกร่อนไว้สำหรับความผิดปกติรุนแรงหรือกระดูกหัก

HIGH-YIELD PEARL

Inflammatory back pain (ดีขึ้นเมื่อขยับ ตื่นกลางดึก ฝืดเช้านาน) + uveitis = axial SpA → ออกกำลังกาย + **NSAID** เต็มขนาด; **methotrexate** ไม่ช่วยโรคแกนกลาง

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 โปย MCQ ankylosing spondylitis
- ASAS-EULAR axial SpA recommendations 2022

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.2-3(3)** Spondyloarthropathies (e.g., ankylosing spondylitis, reactive arthritis) (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 26
- **NL 2.3.13-3(13)** Spondyloarthropathies (ankylosing spondylitis, reactive arthritis) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.1.26** ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก (musculoskeletal pain) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

50. ตอบ A Adult-onset Still disease versus infection AIR-MCQ-50 · Lec 33

ไข้สูงเป็นเวลาเดิมทุกวัน + ผื่นสีปลาแซลมอนที่โผล่พร้อมไข้แล้วหายไป + เจ็บคอ + ปวดข้อ + เม็ดเลือดขาวสูงชนิด **neutrophil** + **ferritin** สูงลิ่ว + **ANA/RF** ลบ = **adult-onset Still disease (AOSD)**

Ferritin ที่สูงเกิน 5 เท่าของค่าปกติ มีความไวสูงมากสำหรับ **AOSD** (ยิ่งจำเพาะขึ้นเมื่อ glycosylated ferritin ต่ำกว่า 20%) เพราะเป็น autoinflammatory ที่ IL-1, IL-6 และ IL-18 สูง

AOSD เป็นการวินิจฉัยแบบตัดโรคอื่นออกก่อน (**Yamaguchi criteria**) — ต้องตัดการติดเชื้อ (โดยเฉพาะ **infective endocarditis**, วัณโรค, ไวรัส), มะเร็ง (ليمโฟมาและมะเร็งเม็ดเลือดขาว) และโรคภูมิคุ้มกันตนเองอื่นออกให้หมดก่อน ซึ่งโจทย์ทำให้แล้วด้วยการเพาะเชื้อและ echocardiography

ภาวะแทรกซ้อนที่ต้องระวังคือ **macrophage activation syndrome** — ไข้ไม่ลด เม็ดเลือดต่ำลงทุกซีรีส์ ferritin พุ่งสูงขึ้นอีก ไตรกลีเซอไรด์สูง fibrinogen ต่ำ ดับวาย ต้องรีบให้สเตียรอยด์ขนาดสูง

การรักษา — NSAID ในรายที่ไม่รุนแรง, สเตียรอยด์เป็นหลัก, ตามด้วย methotrexate หรือยาต้าน IL-1/IL-6 ในรายที่ต้องพึ่งสเตียรอยด์

HIGH-YIELD PEARL

ไข้รายวัน + ผื่นแซลมอนตามไข้ + เจ็บคอ + **ferritin** สูงมาก + **ANA/RF** ลบ = **AOSD** แต่ต้องตัดติดเชื้อและมะเร็งออกก่อนเสมอ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 โปย MCQ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
- Yamaguchi criteria; Harrison 21st ed.

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.1.1** ไข้ (fever) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL 2.1.27** ปวดข้อ ข้อฝืด ข้อติด (joint pain, stiff joint, frozen joint) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56
- **NL 2.3.13-3(12)** Rheumatoid arthritis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

Part 2 · MEQ — แนวคำตอบ

MEQ 1 Acute monoarthritis — gout versus septic arthritis AIR-MEQ-01 · Lec 23

1. จงให้การวินิจฉัยแยกโรคที่เป็นไปได้มากที่สุด 4 โรค พร้อมเหตุผลสั้น ๆ

1. **Acute gouty arthritis** — ประวัติปวดข้อเฉียบพลันเป็นซ้ำที่ MTP ที่ 1 หายเองได้, ต้มเปียร์, ใช้ thiazide, อ้วน, มีก้อนที่ใบหู ซึ่งอาจเป็น tophus
2. **Septic arthritis** — ข้อเดียวบวมแดงร้อน มีไข้ WBC และ CRP สูง ต้องตัดออกก่อนเสมอ แม้ประวัติจะเข้าได้กับเก๊าท์
3. **Pseudogout (CPPD)** — ข้อเข้าเป็นตำแหน่งที่พบบ่อยที่สุด อาการเลียนแบบเก๊าท์ได้ทุกอย่าง
4. **Trauma / hemarthrosis หรือ reactive arthritis** — พิจารณาเมื่อมีประวัติบาดเจ็บหรือการติดเชื้อนำมาก่อน

(หมายเหตุ: **uric acid 6.8 mg/dL** ที่ดู 'ปกติ' ไม่ตัดเก๊าท์ออก เพราะช่วง flare ค่าจะลดลงได้จากการตกตะกอนลงข้อและการขับออกเพิ่มขึ้น)

2. ท่านจะทำหัตถการใดเป็นอันดับแรก และจะส่งตรวจน้ำไขข้ออะไรบ้าง

Arthrocentesis (เจาะข้อเข้าขวา) ภายใต้เทคนิคปลอดเชื้อ ก่อนให้ยาปฏิชีวนะ
ส่งตรวจ 4 อย่างเสมอ

1. **Cell count and differential**
2. **Crystal examination** ด้วย **polarized light microscopy**
3. **Gram stain**
4. **Culture and sensitivity** (พิจารณาเพาะเชื้อวัณโรคหรือเชื้อราเมื่อเรื้อรัง)

เพิ่มเติม: glucose/protein ไม่จำเป็นและไม่ช่วยตัดสินใจ; ส่ง **hemoculture 2 ชุด** คู่กันเมื่อมีไข้

3. ผลน้ำไขข้อ: ชุ่น สีเหลือง ความหนืดลดลง **WBC 32,000 /uL (PMN 88%) Gram stain** ไม่พบเชื้อ และพบผลึกรูปเข็ม **negatively birefringent** อยู่ในเซลล์ จงแปลผลให้ครบและให้การวินิจฉัยที่แน่นอน

แปลผล: เป็นน้ำไขข้อแบบ **inflammatory** (WBC 2,000–50,000, PMN > 50%, ความหนืดลดลง) ยังไม่เข้าเกณฑ์ septic ซึ่งมักเกิน 50,000 และ PMN > 90%

ผลึกรูปเข็ม **negatively birefringent** (เหลืองเมื่อชานแกน **compensator**) ที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดขาว = **monosodium urate**

Definite diagnosis: acute gouty arthritis

ข้อควรระวัง: การพบผลึกไม่ตัด **septic arthritis** ออก เพราะเกิดพร้อมกันได้ จึงต้องรอผลเพาะเชื้อและติดตามอาการ ถ้าไข้ไม่ลดหรือผลเพาะขึ้นต้องรักษาเป็นข้อติดเชื้อทันที

4. จงวางแผนการรักษาระยะเฉียบพลันในผู้ป่วยรายนี้ พร้อมเหตุผลของการเลือกยา

เป้าหมายคือลดการอักเสบให้เร็วที่สุด เลือกยาตามโรคร่วม — ผู้ป่วยมี **eGFR 66** และความดันโลหิตสูง

- ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด: **colchicine** ขนาดต่ำ (1.2 mg แล้วตามด้วย 0.6 mg ใน 1 ชั่วโมง จากนั้น 0.6 mg วันละ 1-2 ครั้ง) หรือ **prednisolone 30-35 mg/วัน 5 วัน** หรือ **ฉีดสเตียรอยด์เข้าข้อ** (ทำได้เมื่อผลเพาะเชื้อไม่ขึ้นและมั่นใจว่าไม่ติดเชื้อ)
- **NSAID** ใช้ได้แต่ต้องระวังไตและความดัน ถ้าใช้ให้ระยะสั้นที่สุดพร้อมยาป้องกันกระเพาะ
- ประคบเย็น พักข้อ ยกสูง
- ห้าม เริ่ม allopurinol เดียว ๆ ระหว่าง flare และ ห้าม หยุด ULT ที่กินอยู่เดิม (รายนี้ยังไม่เคยได้)

5. หลังอาการสงบ 3 สัปดาห์ ผู้ป่วยกลับมาตรวจ จงวางแผนการรักษาระยะยาวและคำแนะนำ

ข้อบ่งชี้ **ULT**: flare ≥ 2 ครั้ง/ปี และมี tophus ที่ใบหู → เริ่ม **urate-lowering therapy**

1. *คัดกรอง **HLA-B*58:01*** ก่อนเริ่ม allopurinol (คนไทย)
2. **Allopurinol** เริ่ม **100 mg/วัน** ปรับขึ้นทุก 2-5 สัปดาห์ จน **urate < 6 mg/dL** (มี tophus ให้ < 5) แล้วกินต่อเนื่องตลอด
3. **Prophylaxis** ด้วย colchicine 0.6 mg วันละครึ่ง ต่ออีก 3-6 เดือน
4. เปลี่ยน **hydrochlorothiazide** เป็น **losartan** หรือ amlodipine ซึ่งไม่เพิ่ม (losartan ช่วยลด) urate

5. คำแนะนำ: ลดน้ำหนัก, งด/ลดเบียร์และสุรา, ลดเครื่องดื่มน้ำตาลฟรุกโตสสูง เครื่องในสัตว์ อาหารทะเลบางชนิด, ดื่มน้ำให้พอ, ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
6. ติดตาม uric acid, ไต และตับเป็นระยะ และอธิบายว่า ห้ามหยุดยาเมื่อ flare และหากมีผื่นหลังเริ่ม allopurinol ต้องหยุดยาและมาพบแพทย์ทันที (เสี่ยง SCAR)

REF

- MED35 MEQ 'ผช. ปวดเข่ามากจนเดินไม่ได้ + ไข้ — ddx 4 โรค, วิดีอุหน้าที่เจาะ, definite dx acute gouty attack, รักษาระยะแรกและต่อไป'
- ACR Gout Guideline 2020

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.1.27** ปวดข้อ ข้อฝืด ข้อติด (joint pain, stiff joint, frozen joint) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL B5.2.5(1)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.3(3)** Synovial fluid analysis — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL B5.3(4)** Serum uric acid — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL B5.4(4)** Drugs for treatment of gout and hyperuricemia — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28
- **NL 3.1.7** Body fluid analysis (e.g., CSF, pleural, synovial) — 3.1 ตรวจและแปลผลได้ด้วยตนเอง หน้า 71

1. จงให้การวินิจฉัยที่น่าจะเป็นมากที่สุด พร้อมข้อมูลสนับสนุนจากประวัติ ตรวจร่างกาย และแล็บ

Systemic lupus erythematosus ที่มี lupus nephritis (nephritic-nephrotic picture)

ข้อมูลสนับสนุน

- ผิวหนัง/เยื่อ: malar rash ที่เว้นร่อง nasolabial, photosensitivity, ผื่นรัง, แผลในปากที่ไม่เจ็บ
- ข้อ: polyarthritis สมมาตรที่ข้อเล็ก ฝืดเช้า 1 ชั่วโมง ไม่มี deformity
- เลือด: leukopenia + lymphopenia + thrombocytopenia + anemia (cytopenia หลายซีรีส์)
- ไต: ความดันสูง, บวม, โปรตีนรั่วระดับ nephrotic (UPCR 3.8 g/g), **active sediment** ที่มี **dysmorphic RBC** และ **RBC cast** = glomerulonephritis, Cr สูงขึ้น
- อายุและเพศเข้าได้ (หญิงวัยเจริญพันธุ์)

2. จงส่งการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรง พร้อมเหตุผล อย่างน้อย 5 อย่าง

1. **ANA** — คัดกรอง ความไวสูงมาก ถ้าลบแทบตัด SLE ออก
2. **Anti-dsDNA** และ **anti-Smith** — จำเพาะต่อ SLE; anti-dsDNA สัมพันธ์กับไตอักเสบและใช้ติดตามโรค
3. **Complement C3, C4** — ต่ำเมื่อโรค active จากการใช้ complement ไปกับ immune complex
4. **Direct Coombs test, LDH, haptoglobin, blood smear** — ประเมิน autoimmune hemolytic anemia และแยก microangiopathy
5. **Antiphospholipid antibodies (LA, anticardiolipin, anti-β2GPI)** — มีผลต่อความเสี่ยงลิ่มเลือดและการตั้งครรภ์
6. **24-hour urine protein** หรือ **UPCR (มีแล้ว), urine microscopy** ซ้ำ, **ultrasound** ไต — ประเมินไตก่อน biopsy
7. **Renal biopsy** — เพื่อจัดชั้น ISN/RPS ซึ่งกำหนดแผนการรักษา
8. ตรวจพื้นฐานก่อนให้ยากดภูมิ: **CXR, anti-HIV, HBsAg/anti-HBc, anti-HCV**, ตรวจวัณโรคแฝง, **urine pregnancy test**

3. ผล **ANA 1:1280 speckled, anti-dsDNA** บวกสูง, **C3 46 mg/dL (ต่ำ), C4 8 mg/dL (ต่ำ)** — ผล **renal biopsy: diffuse proliferative glomerulonephritis (class IV) with activity index** สูง จงวางแผนการรักษา

Induction therapy (เป้าหมาย: หยุดการอักเสบของไตให้เร็วที่สุด)

- **Corticosteroid:** pulse methylprednisolone 500 mg IV วันละครั้ง 3 วัน แล้วตามด้วย prednisolone 0.5–1 mg/kg/วัน ค่อย ๆ ลดขนาด
- ร่วมกับยากดภูมิ: **mycophenolate mofetil 2-3 g/วัน** หรือ **cyclophosphamide (Euro-Lupus low dose 500 mg IV ทุก 2 สัปดาห์ 6 ครั้ง)** — เลือก MMF ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ยังต้องการมีบุตร เพราะ cyclophosphamide ทำให้รังไข่เสื่อม (ถ้าจำเป็นต้องใช้ให้พิจารณา GnRH agonist บ้าง)
- พิจารณาเพิ่ม **belimumab** หรือ **voclosporin** ตามแนวทางปัจจุบัน

การรักษาเสริมที่ต้องมีทุกราย

- **Hydroxychloroquine 5 mg/kg/วัน** — ลด flare, ลดการเกิดลิ่มเลือด, เพิ่มอัตราการรอด (ตรวจตามแนวทาง)
- **ACEI หรือ ARB** ลดโปรตีนรั่วและคุมความดัน เป้าหมาย < 130/80
- ควบคุมไขมัน, งดบุหรี่, กันแดด (ครีมกันแดด SPF สูง เสื้อแขนยาว)
- ป้องกัน **PCP** ด้วย **TMP-SMX** เมื่อได้สเตียรอยด์ขนาดสูงร่วมกับยากดภูมิ, ประเมินกระดูกและให้แคลเซียม/วิตามินดี
- คุมกำเนิดที่เหมาะสมระหว่างโรค active และระหว่างได้ยาที่เป็น teratogen

4. หลังได้สเตียรอยด์ขนาดสูงและ **MMF 6 สัปดาห์** ผู้ป่วยกลับมาด้วยไข้ **38.5 C** ไอแห้ง เหนื่อย **SpO2 89% room air, CXR** มีฝ้า **interstitial** สองข้าง จงให้การวินิจฉัยแยกโรคและการจัดการเบื้องต้น

ต้องคิดถึง การติดเชื้อฉวยโอกาสก่อนโรคกำเริบเสมอ

วินิจฉัยแยกโรค: **Pneumocystis jirovecii pneumonia** (เข้าได้มากที่สุด: ไอแห้ง ขาดออกซิเจนมากกว่าที่ฟังปอดได้ ฝ้า interstitial LDH สูง), วัณโรคปอด, การติดเชื้อไวรัส/CMV, **lupus pneumonitis** หรือ **diffuse alveolar hemorrhage** (แต่ต้องตัดการติดเชื้อออกก่อน), ปอดบวมจากแบคทีเรียทั่วไป

การจัดการ: ให้ออกซิเจน, ส่ง induced sputum/BAL หา PCP และ AFB, เพาะเชื้อ, ส่ง LDH, เริ่ม **TMP-SMX** ขนาดรักษาทันที โดยไม่รอผล และเพิ่มสเตียรอยด์เสริมเมื่อ PaO₂ < 70 mmHg, ทบทวน/ชะลอยากดภูมิ, ตรวจ HIV ห้ามเพิ่มยากดภูมิเพราะคิดว่าเป็น **flare** จนกว่าจะตัดการติดเชื้อออก

5. ผู้ป่วยถามว่าจะตั้งครรภ์ได้หรือไม่ ท่านจะให้คำแนะนำอย่างไร

- ไม่ควรตั้งครรภ์ขณะโรค **active** โดยเฉพาะไตอักเสบ เพราะเสี่ยง preeclampsia, แท้ง, ทารกโตช้า, คลอดก่อนกำหนด และ SLE กำเริบ
- แนะนำให้ โรคสงบอย่างน้อย **6 เดือน** และไตทำงานคงที่ก่อนวางแผนตั้งครรภ์
- ต้อง เปลี่ยนยาที่เป็น **teratogen** ก่อนตั้งครรภ์: หยุด MMF (เปลี่ยนเป็น **azathioprine**), หยุด cyclophosphamide, methotrexate, ACEI/ARB
- ยาที่ใช้ต่อได้และควรใช้ ระหว่างตั้งครรภ์: **hydroxychloroquine** (ลด flare และลดความเสี่ยง congenital heart block), prednisolone ขนาดต่ำ, azathioprine, และ **low-dose aspirin** ตั้งแต่ไตรมาสแรกเพื่อลด **preeclampsia**
- ตรวจ **anti-SSA/SSB** เพราะสัมพันธ์กับ neonatal lupus และ congenital heart block ต้องเฝ้าติดตามการเต้นหัวใจทารก และตรวจ antiphospholipid antibody เพื่อวางแผนป้องกันลิ่มเลือด
- ระหว่างยังไม่พร้อม ให้คุมกำเนิดที่เหมาะสม (หลีกเลี่ยงฮอร์โมนเอสโตรเจนเมื่อมี antiphospholipid antibody บวกหรือโรค active)

REF

- MED34 โปย MCQ/MEQ SLE with lupus nephritis
- EULAR/ACR SLE 2019; KDIGO Glomerular Diseases 2021

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.2.2-3(5)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 26
- **NL B5.3(5)** Serologic studies: antinuclear antibody (ANA), rheumatoid factor — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL 2.3.3-3(5)** Immune deficiency states (neutropenia, asplenia/splenic dysfunction, post-chemotherapy) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

1. จงให้การวินิจฉัยและระบุเกณฑ์ที่ใช้

Anaphylaxis (anaphylactic shock) จาก diclofenac

เข้าเกณฑ์ข้อที่ 1 ของ WAO/NIAID: เกิดเฉียบพลันภายในไม่กี่นาทีถึงชั่วโมง โดยมีอาการทางผิวหนัง/เยื่อ (ลมพิษทั่วตัว + angioedema) ร่วมกับอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้

- ระบบหายใจ: หายใจลำบาก wheeze เสียงแหบ SpO2 91%
- ระบบไหลเวียนโลหิต: BP 80/48 mmHg ปลายมือเย็น
- และยังมีอาการทางเดินอาหารร่วม (อาเจียน)

2. จงเรียงลำดับการรักษาที่ต้องทำทันที 5 ขั้นตอนแรก

1. **Adrenaline (1:1,000) 0.3-0.5 mg IM ที่ anterolateral thigh** ทันที ซ้ำได้ทุก 5-15 นาที (รายนี้ควรได้ซ้ำถ้าความดันยังต่ำ)
2. จัดทำนอนราบยกขาสูง (ห้ามให้ลูกนั่งหรือยืนทันที เพราะ empty ventricle syndrome ทำให้หัวใจหยุดเต้นได้) และ ให้ออกซิเจน **high flow**
3. เปิดเส้นเลือดใหญ่ 2 เส้น ให้ **NSS 1-2 ลิตร bolus** อย่างรวดเร็ว (20 mL/kg) เพราะมีการรั่วของสารน้ำออกนอกหลอดเลือดมาก
4. เผื่อระวังทางเดินหายใจ — เสียงแหบและปากบวมคือสัญญาณเตือน เตรียมอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจและทีมที่มีประสบการณ์ (ถ้าบวมมากอาจต้องใส่ท่อเร็วก่อนบวมจนใส่ไม่ได้)
5. ยาเสริม: nebulized salbutamol สำหรับ wheeze, antihistamine (chlorpheniramine IV) สำหรับผื่นและคัน, corticosteroid (hydrocortisone IV); ถ้าความดันยังต่ำหลังให้ adrenaline IM ซ้ำและสารน้ำเต็มที่แล้ว → **adrenaline infusion** ทางหลอดเลือดดำ ในที่ที่มี monitor

(หมายเหตุ: ถ้าผู้ป่วยกิน beta-blocker อยู่และไม่ตอบสนอง adrenaline ให้พิจารณา **glucagon**)

3. ผู้ป่วยอาการดีขึ้นใน 1 ชั่วโมง ญาติขอกลับบ้านทันที ท่านจะอธิบายอย่างไร และจะสังเกตอาการนานเท่าใด

อธิบายว่า **anaphylaxis** มีโอกาสกลับเป็นซ้ำแบบ **biphasic reaction** ได้ประมาณ **1-20%** โดยมักเกิดภายใน **1-12 ชั่วโมง** หลังอาการแรกสงบ แม้จะดูดีแล้วก็ตาม

ระยะเวลาสังเกตอาการ — อย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง และ ควรสังเกตนานถึง **12-24 ชั่วโมง**หรือรับไว้ในโรงพยาบาล เมื่อมีปัจจัยเสี่ยง: มีความดันตก (รายนี้มี), ต้องให้ adrenaline มากกว่า 1 ครั้ง, มี laryngeal edema, มีโรคหืดร่วม, มาจากบ้านที่ห่างไกลจากโรงพยาบาล

4. จงวางแผนการดูแลก่อนจำหน่ายและการส่งต่อ

1. จ่าย **adrenaline auto-injector 2 เข็ม** + สอนวิธีใช้จนผู้ป่วยและญาติสาธิตได้ (ถ้าไม่มีในระบบ ให้วางแผนเข้าถึงบริการฉุกเฉินและบัตรแพทย์)
2. เขียน **anaphylaxis action plan** และสอนให้ฉีดทันทีเมื่อมีอาการ แล้วโทร 1669 ทุกครั้ง
3. ออกบัตรแพ้ยา (**drug allergy card**) ระบุ diclofenac และ **NSAID** กลุ่ม **COX-1 inhibitor** ทั้งหมด พร้อมบันทึกในเวชระเบียนและระบบโรงพยาบาล
4. สอนชื่อยาที่ต้องเลี่ยง — NSAID ทุกชนิด (ibuprofen, naproxen, aspirin, ยาชุด ยาแก้ปวดข้อที่ไม่ทราบส่วนประกอบ) และให้ใช้ **paracetamol** เป็นยาแก้ปวดแทน
5. ส่งต่อ **allergist** เพื่อยืนยันชนิดของปฏิกิริยา (NSAID hypersensitivity แบ่งได้หลายแบบ) และประเมินว่าจะใช้ **selective COX-2 inhibitor** ได้หรือไม่ภายใต้การดูแล
6. นัดติดตามและย้ำว่า ห้ามทดลองกินยาเดิมซ้ำเองเด็ดขาด

REF

- MED33 โปษ MCQ 'กินยา → ผื่นขึ้น → Anaphylaxis → Adrenaline IM' และข้อ 45 การดูแลหลังจำหน่าย
- WAO Anaphylaxis Guidance 2020

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.2.7 Shock:** hypovolemic, anaphylactic, septic, cardiogenic — 2.2 โรคภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน หน้า 60
- **NL B4.2.2(12) Urticaria** (กลุ่มที่ 1-2) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24

- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56
- **NL 2.1.51** คัน (pruritus) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

1. จงอธิบายลักษณะของข้ออักเสบรายนี้ (จำนวนข้อ ความสมมาตร ชนิดของอาการ) และให้การวินิจฉัยแยกโรค 4 โรค

ลักษณะ: chronic **symmetric polyarthritis** ของข้อเล็กที่มือ (MCP, PIP) และข้อมือ นานเกิน 6 สัปดาห์ ร่วมกับ **inflammatory pattern** (ไข้ > 1 ชั่วโมง ตื่นเมื่อขยับ แผลงเมื่อพัก) และมี systemic inflammation (ESR/CRP สูง, anemia of chronic disease, thrombocytosis)

วินิจฉัยแยกโรค

1. **Rheumatoid arthritis** — เข้าได้มากที่สุด: ตำแหน่ง MCP/PIP/ข้อมือ สมมาตร เว้น DIP, ฝ่าเท้า, ปลายนิ้ว, ประวัติครอบครัว, สูบบุหรี่ (ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ)
2. **SLE** — ให้ polyarthritis สมมาตรได้เช่นกัน ต้องหาอาการระบบอื่น (ผื่น แผลในปาก ไต เม็ดเลือดต่ำ)
3. **Psoriatic arthritis** — มองหาผื่นสะเก็ดเงิน เล็บผิดปกติ dactylitis และการเป็นที่ DIP
4. **Viral arthritis (chikungunya, parvovirus B19, hepatitis B/C) หรือ polyarticular gout/CPPD** — ไวรัสมักหายใน 6 สัปดาห์; เก้าอี้หลายข้อพบในผู้สูงอายุที่เป็นมานาน

2. จงส่งตรวจเพิ่มเติมพร้อมเหตุผล

1. **RF และ anti-CCP** — anti-CCP จำเพาะต่อ RA สูง (> 95%) และทำนายโรครุนแรง/erosion
2. **ANA (และ anti-dsDNA ถ้า ANA บวก)** — แยก SLE
3. **Plain film** มือและเท้าสองข้าง — หา periarticular osteopenia, marginal erosion, ช่องข้อแคบ (เท้ามัก erode ก่อนมือ) ใช้เป็นภาพพื้นฐานเปรียบเทียบ
4. **Ultrasound หรือ MRI** ข้อ เมื่อภาพรังสียังไม่ชัด เพื่อยืนยัน synovitis/erosion ระยะแรก
5. **พื้นฐานก่อนเริ่ม DMARD**: CBC, LFT, creatinine, **HBsAg/anti-HBc, anti-HCV, anti-HIV, CXR** และคัดกรองวัณโรคแฝง, urine pregnancy test
6. ตรวจไวรัสตามบริบท (chikungunya/dengue) ถ้าประวัติเข้าได้

3. ผล anti-CCP บวกสูง RF บวก ANA ลบ ภาพรังสีพบ periarticular osteopenia ที่ MCP ยังไม่มี erosion จงวางแผนการรักษาและอธิบายแนวคิด treat-to-target

วินิจฉัย: **rheumatoid arthritis (seropositive)** ระยะแรก ยังไม่มี erosion — อยู่ใน **window of opportunity** แผนการรักษา

1. เริ่ม **methotrexate 10-15 mg** สัปดาห์ละครั้ง (ย้ำว่า สัปดาห์ละครั้ง ไม่ใช่ทุกวัน) ปรับขึ้นตามการตอบสนองถึง 20-25 mg/สัปดาห์ ร่วมกับ **folic acid 5 mg/สัปดาห์** (คนละวันกับ methotrexate)
2. **Bridging corticosteroid** — prednisolone ขนาดต่ำระยะสั้น หรือฉีดเข้าข้อ แล้วลดจนหยุดภายใน 3 เดือน
3. NSAID ตามอาการปวด (ไม่ใช่ยาปรับโรค)
4. แนะนำเลิกบุหรี่ — บุหรี่ทำให้โรครุนแรงขึ้นและลดการตอบสนองต่อยา
5. ภาวะสุขภาพ บำบัด ออกกำลังกาย ป้องกันข้อผิดรูป และประเมินความเสี่ยงหัวใจและหลอดเลือด (RA เพิ่มความเสี่ยงชัดเจน)

Treat-to-target: ตั้งเป้าให้โรค **remission หรือ low disease activity** วัดด้วยดัชนีเช่น DAS28/CDAI ประเมินทุก **1-3 เดือน** ถ้ายังไม่ถึงเป้าให้ปรับการรักษาทันที (เพิ่มขนาด, เปลี่ยน/เพิ่ม conventional DMARD, หรือเพิ่ม biologic/JAK inhibitor) ไม่ปล่อยให้โรค active ลอยไปเป็นปี

4. ผู้ป่วยกลับมาหลังใช้ methotrexate 8 สัปดาห์ ด้วยแผลในปากหลายแผล คลื่นไส้ และ WBC 2,900 /uL จงอธิบายกลไกและการจัดการ

กลไก: methotrexate เป็น folate antagonist — พิษต่อเยื่อ (mucositis) และไขกระดูกเกิดจากการขาด folate ในเซลล์ที่แบ่งตัวเร็ว ปัจจัยส่งเสริมคือ สัมกับ **folic acid**, ไตเสื่อม, ขนาดยาสูงเกินไป, กินยาผิดเป็นทุกวันแทนสัปดาห์ละครั้ง และยาที่เสริมฤทธิ์ เช่น **trimethoprim-sulfamethoxazole** หรือ NSAID ขนาดสูง

การจัดการ

1. หยุด **methotrexate** ทันที และทบทวนว่าผู้ป่วยกินยาถูกวิธีหรือไม่ (ถามให้ชัดว่ากินสัปดาห์ละกี่เม็ด วันไหน)
2. ให้ **folinic acid (leucovorin)** เมื่อ cytopenia ชัดเจน; ดูแลแผลในปาก ให้สารน้ำและอาหารอ่อน
3. ตรวจ CBC, LFT, creatinine ชั่ว และเฝ้าระวังการติดเชื้อ (ถ้าใช้ร่วมกับ neutropenia ให้ยาปฏิชีวนะทันที)

4. เมื่อค่าเลือดกลับปกติ พิจารณาเริ่มใหม่ในขนาดต่ำลง **พร้อม folic acid ที่ถูกต้อง** หรือเปลี่ยนเป็น DMARD ตัวอื่น (sulfasalazine, leflunomide) และหลีกเลี่ยงยาที่เสริมฤทธิ์

REF

- MED33 โปย Joint ข้อ 2 'ปวดข้อนิ้วมือ MCP, PIP สองข้างเท่ากัน ปวดมากขึ้นตอนเช้า'
- ACR RA Treatment Guideline 2021

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(12)** Rheumatoid arthritis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.2.2-3(4)** Rheumatoid arthritis (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 26
- **NL B5.3(5)** Serologic studies: antinuclear antibody (ANA), rheumatoid factor — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL B5.4(3)** Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28
- **NL 2.1.27** ปวดข้อ ข้อฝืด ข้อติด (joint pain, stiff joint, frozen joint) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

Part 3 · OSCE / SAQ — แนวคำตอบและเกณฑ์การให้คะแนน

สถานที่ 1 SAQ - Synovial fluid crystal under polarized light AIR-OSCE-01 · Lec 23

2.1 บรรยายผลึก (2 คะแนน)

- ผลึก รูปเข็มยาวปลายแหลม (**needle-shaped**) ยาวประมาณ 5-20 ไมครอน
- **negatively birefringent** อย่างแรง — เรือง สีเหลือง เมื่อวางขนานกับแกนของ compensator และเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อวางตั้งฉาก
- พบผลึก อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดขาว (**intracellular**) ซึ่งยืนยันว่าเป็นสาเหตุของการอักเสบขณะนี้ ไม่ใช่ผลึกที่ค้างอยู่เฉย ๆ

2.2 (2 คะแนน) สารคือ **monosodium urate (MSU)** → วินิจฉัย **acute gouty arthritis** (โรคเก๊าท์กำเริบเฉียบพลัน) ตำแหน่งที่โคนนิ้วหัวแม่เท้าเรียกว่า **podagra**

2.3 (2 คะแนน) ผลึกรูป **rhomboid** ที่ **weakly positively birefringent** (น้ำเงินเมื่อขนานแกน) คือ **calcium pyrophosphate dihydrate (CPPD)** → โรค **pseudogout (calcium pyrophosphate deposition disease)** มักพบที่เข่าและข้อมือ และเห็น **chondrocalcinosis** บนภาพรังสี

2.4 (2 คะแนน) คิดถึง septic arthritis เมื่อ

- น้ำไขข้อ ขุ่นข้นคล้ายหนอง ความหนืดลดลงมาก
- **WBC > 50,000 /uL** (โดยเฉพาะเมื่อ > 100,000)
- **PMN > 90%**
- Gram stain หรือ culture พบเชื้อ (ส่งเสมอแม้พบผลึก เพราะเกิดร่วมกันได้)

2.5 (2 คะแนน) มี **CKD stage 3 +** ประวัติแพ้ในกระเพาะอาหาร จึง หลีกเลี่ยง **NSAID** → เลือก **colchicine** ขนาดต่ำ (**1.2 mg** แล้วตาม **0.6 mg** ใน **1 ชั่วโมง** ปรับตามการทำงานของไต) หรือ **prednisolone 30-35 mg/วัน 5 วัน** หรือ คีดสเตียรอยด์เข้าข้อ เมื่อมั่นใจว่าไม่ใช่ข้อติดเชื้อ

เกณฑ์ให้คะแนนรวม **10 คะแนน** — ตอบชื่อผลึกและโรคถูกแต่ไม่บรรยาย birefringence ได้ครึ่งคะแนนของข้อนั้น

REF

- MED35 OSCE/SAQ ข้อ 7 'ให้ประวัติชายอายุ 50 ปวดข้อ ให้บรรยายภาพสไลด์ uric acid crystal needle shape และวินิจฉัย ตอบ gout'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.3(3)** Synovial fluid analysis — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL 3.1.7** Body fluid analysis (e.g., CSF, pleural, synovial) — 3.1 ตรวจและแปลผลได้ด้วยตนเอง หน้า 71
- **NL B5.2.5(1)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

สถานที่ 2 SAQ - Palpable purpura AIR-OSCE-02 · Lec 33

3.1 บรรยายสั้น (2 คะแนน) — palpable purpura: จุดเลือดออกสีแดงคล้ำถึงม่วง ขนาด 2-5 มม. กดไม่จาง (**non-blanching**) คลำได้บนเนื้อผิวหนัง กระจายแบบสมมาตรบริเวณ **dependent area** (หน้าแข้ง ก้น) บางจุดรวมกันเป็นปื้น

3.2 กลไก (2 คะแนน)

- กดไม่จาง = เลือดออกนอกหลอดเลือดแล้ว (extravasated RBC) ไม่ใช่หลอดเลือดขยาย
- คลำได้บน = มีการอักเสบและเซลล์อักเสบแทรกในผนังหลอดเลือด (**leukocytoclastic vasculitis**) ทำให้ผนังบวมหนา
- เกิดเลือดและการแข็งตัวปกติ = ไม่ใช่ ITP, DIC หรือความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (ซึ่งจำจะ ราบ ไม่นูน)

3.3 การวินิจฉัย (2 คะแนน) — IgA vasculitis (Henoch-Schonlein purpura) จาก tetrad: palpable purpura ที่ขาและก้น + ปวดข้อ + ปวดท้องบิด + ไตอักเสบ (โปรตีนและเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ) เกิดตามหลังการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน

3.4 การติดตาม (2 คะแนน) — ไตคือตัวกำหนดพยากรณ์โรค ต้องตรวจ **urinalysis** และวัดความดันโลหิตเป็นระยะ (ทุก 1-2 สัปดาห์ในเดือนแรก แล้วต่อเนื่องนาน 6-12 เดือน) เพราะ nephritis อาจปรากฏภายหลังผื่นหาย; ภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ต้องระวังคือเลือดออกในทางเดินอาหารและลำไส้กลืนกัน (**intussusception**) โดยเฉพาะในเด็ก

3.5 วินิจฉัยแยกโรคของ palpable purpura (2 คะแนน) ตอบ 3 ใน

- **ANCA-associated vasculitis** (GPA, MPA, EGPA)
- **Cryoglobulinemic vasculitis** (สัมพันธ์กับไวรัสตับอักเสบซี)
- **Hypersensitivity/drug-induced (leukocytoclastic) vasculitis**
- **Meningococcemia หรือ infective endocarditis** (ติดเชื้อ ต้องแยกก่อนเสมอเพราะรักษาต่างกันสิ้นเชิง)
- **SLE-associated vasculitis**

REF

- MED32 โปย SAQ ผื่น purpura
- Harrison 21st ed., The Vasculitis Syndromes

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(2)** Allergic purpura (Henoch-Schonlein purpura) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.2.2-3(2b)** Vasculitis syndrome (e.g., Kawasaki disease, polyarteritis nodosa, drug induced) (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 27
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

4.1 บรรยายภาพรังสี (2 คะแนน)

1. soft tissue swelling รอบข้อ MCP ทั้งสองข้าง (สะท้อน synovitis)
2. **periarticular osteopenia** — กระดูกบางเฉพาะรอบข้อที่อักเสบ
3. ช่องข้อแคบลงอย่างสม่ำเสมอ (**uniform/concentric joint space narrowing**) ที่ MCP และข้อมือ
4. **marginal erosion** ที่ขอบข้อ MCP ที่ 2 และ 3 บริเวณ bare area
5. ไม่พบ **osteophyte** หรือ **subchondral sclerosis**

4.2 การวินิจฉัยและการแยกโรค (3 คะแนน) — Rheumatoid arthritis

	RA	OA
ข้อที่เป็น	MCP, PIP, ข้อมือ เว้น DIP	DIP, PIP, CMC นิ้วโป้ง
ความหนาแน่นกระดูก	periarticular osteopenia	ปกติหรือหนาขึ้น
ช่องข้อ	แคบสม่ำเสมอทั้งข้อ	แคบเฉพาะด้านที่รับน้ำหนัก
รอยกร่อน	marginal erosion	ไม่มี (ยกเว้น erosive OA ที่ DIP แบบ gull-wing)
Osteophyte / subchondral sclerosis	ไม่มี	มีเด่น

4.3 การตรวจยืนยัน (2 คะแนน) — Rheumatoid factor และ anti-cyclic citrullinated peptide (anti-CCP) antibody (anti-CCP จำเพาะสูงกว่าและทำนายโรครุนแรง) เสริมด้วย ESR/CRP เพื่อประเมินความ active

4.4 การคัดกรองก่อนให้ biologic (3 คะแนน)

1. วัณโรคแฝง — ชักประวัติสัมผัส, **CXR** และ **tuberculin skin test** หรือ **IGRA** เพราะยาด้าน TNF ทำให้ latent TB กำเริบเป็นวัณโรคแพร่กระจายได้ ถ้าพบต้องรักษา latent TB ก่อนหรือพร้อมกันตามแนวทาง
2. ไวรัสตับอักเสบบีและซี — HBsAg, anti-HBc, anti-HCV เพราะเสี่ยง HBV reactivation ที่รุนแรงถึงตับวาย
3. การติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับการรักษา, **anti-HIV**, ประวัติมะเร็ง และภาวะหัวใจล้มเหลว (anti-TNF ทำให้ HF แย่ลง) รวมถึงจัดวัคซีนเชื้อตายให้ครบก่อนเริ่มยา และหลีกเลี่ยงวัคซีนเชื้อเป็นระหว่างใช้ยา

REF

- MED34 โปย 'Osteopenia at PIP, MCP, mild joint space narrowing, no erosion — Diag? A. Osteoarthritis B. RA'
- ACR RA Guideline 2021

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.3(1)** Plain film of bones and joints — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 27
- **NL 3.2.5** Plain film: bones and joints — 3.2 การตรวจทางรังสีที่ต้องแปลผลได้ หน้า 72
- **NL 2.3.13-3(12)** Rheumatoid arthritis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.3(5)** Serologic studies: antinuclear antibody (ANA), rheumatoid factor — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL B5.4(3)** Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28

สิ่งที่ต้องซักให้ได้ (คะแนนเต็ม 20)

1. ลักษณะของปฏิกิริยา (6 คะแนน)

- อาการคืออะไรบ้าง: ผื่นแบบไหน (ราบ/นูน/ตุ่มน้ำ/ลอก), คันหรือเจ็บ, มีไข้ไหม
- เยื่อบุมีแผลหรือไม่ (ปาก ตา อวัยวะเพศ) — จุดชี้ขาดของ SJS/TEN
- ผิวหนังลอกหรือไม่ และประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ผิว
- มีอาการระบบอื่นไหม: บวมปาก/หน้า เสียงแหบ แขนหน้าอก หายใจลำบาก เป็นลม (บ่งชี้ anaphylaxis)

2. เวลา (4 คะแนน)

- เริ่มอาการวันที่เท่าไรของการกินยา (รายนี้วันที่ 8 = delayed) — ทันที/ภายในชั่วโมง = IgE-mediated, หลายวัน-สัปดาห์ = T-cell mediated
- เคยได้ยานี้มาก่อนหรือไม่ และครั้งนั้นเป็นอย่างไร
- อาการดีขึ้นเมื่อไรหลังหยุดยา

3. ยาและสิ่งที่ได้รับรวม (4 คะแนน)

- ชื่อยาทุกตัวที่ได้ในช่วงนั้น ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาซื้อเอง สมุนไพร อาหารเสริม และวันที่เริ่มแต่ละตัว
- ถ้าไม่ทราบชื่อ ให้บอกดูของยา ใบสั่งยา หรือประวัติจากโรงพยาบาลเดิม

4. ความรุนแรงและการรักษาที่ได้รับ (3 คะแนน) — ต้องนอนโรงพยาบาลไหม กี่วัน ได้สเตียรอยด์หรือสารน้ำหรือไม่ มีผลกระทบบต่อดวงตาหลงเหลือไหม

5. ประวัติอื่นที่เกี่ยวข้อง (3 คะแนน) — โรคประจำตัว (ไต ตับ HIV ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงแพ้ cotrimoxazole), ประวัติแพ้ยาอื่นในอดีต, ประวัติแพ้ยาในครอบครัว

สรุปที่ควรบอกผู้ป่วย

- ปฏิกิริยานี้เข้าได้กับ **Stevens-Johnson syndrome** จาก **cotrimoxazole** ซึ่งเป็นการแพ้ยาชนิดรุนแรง ห้ามใช้ยานี้และยากลุ่ม **sulfonamide** อีกตลอดชีวิต และ ห้ามทดสอบหรือ **desensitize**
- ออก บัตรแพ้ยา ระบุชื่อยาและอาการ พกติดตัวตลอด แจ้งทุกครั้งที่พบแพทย์ ทันตแพทย์ หรือซื้อยา
- บันทึกในเวชระเบียนและระบบแพ้ยาของโรงพยาบาล
- ให้รายชื่อยาทางเลือกสำหรับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะครั้งต่อไป และแนะนำให้มาพบแพทย์ทันทีถ้ามีผื่นร่วมกับไข้หรือแผลในปากหลังเริ่มยาใหม่

REF

- MED34 โปย OSCE สถานที่ซักประวัติแพ้ยา
- Harrison 21st ed., Cutaneous Drug Reactions

เกณฑ์แพทย์สภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B4.2.2(13)** Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis (กลุ่มที่ 1-2) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24
- **NL 2.3.12(13)** Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis (กลุ่มที่ 2) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 66
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

5.1 (3 คะแนน) — Acute hemolytic transfusion reaction (AHTR) จากการให้เลือดผิดหมู่ ABO

กลไก: แอนติบอดีของผู้รับ (anti-A/anti-B ชนิด IgM) จับกับแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงของผู้ให้ → กระตุ้น **complement** ครบวงจนเกิด **intravascular hemolysis** → hemoglobinemia/hemoglobinuria (ปัสสาวะสีแดงเข้ม), การหลั่ง cytokine ทำให้ไข้และความดันตก, เกิด **DIC** และ **acute kidney injury** ตามมา — เป็น **type II hypersensitivity**

5.2 สิ่งที่ต้องทำทันที (4 คะแนน)

1. หยุดให้เลือดทันที และคาสายไว้ เปลี่ยนชุดให้สารน้ำใหม่ ให้ **0.9% NSS**
2. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้ป่วย และฉลากถุงเลือดซ้ำทันที (ความผิดพลาดของการระบุตัวผู้ป่วยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง)
3. ประคับประคองระบบไหลเวียนและไต — ให้สารน้ำอย่างเพียงพอให้ปัสสาวะออก $\geq 1 \text{ mL/kg/ชม.}$, ฝ้าระวังความดัน ใส่สายสวนปัสสาวะเพื่อวัดปริมาณ, พิจารณายากระตุ้นความดันถ้าจำเป็น
4. แจ้งธนาคารเลือดทันที ส่งถุงเลือดและตัวอย่างเลือดกลับ พร้อมฝ้าระวัง DIC และภาวะไตวาย

5.3 สิ่งส่งตรวจ (3 คะแนน)

- ส่งกลับธนาคารเลือด: ถุงเลือดที่เหลือพร้อมชุดให้เลือด และตัวอย่างเลือดผู้ป่วยหลังเกิดเหตุ เพื่อ **ตรวจหมู่เลือดซ้ำและ cross-match** ใหม่ทั้งก่อนและหลัง
- จากผู้ป่วย: **direct antiglobulin (Coombs) test**, CBC และ blood smear (หา schistocyte), **plasma free hemoglobin, LDH, haptoglobin, bilirubin**, BUN/creatinine, **coagulogram + fibrinogen + D-dimer** (ประเมิน DIC) และ **urinalysis** หา **hemoglobinuria**, เพาะเชื้อจากเลือดผู้ป่วยและถุงเลือดถ้าสงสัยการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย

5.4 (2 คะแนน) — ผื่นลมพิษอย่างเดียวคือ **allergic (urticarial) transfusion reaction** ซึ่งเป็น ชนิดเดียวที่ให้เลือดต่อได้: หยุดชั่วคราว ให้ **antihistamine** รอจนผื่นยุบ แล้วเริ่มให้เลือดใหม่ช้า ๆ พร้อมฝ้าสังเกต; ถ้าเป็นซ้ำบ่อยครั้งต่อไปพิจารณา **washed red cells**

REF

- MED33 โปย Hemato ข้อ 3 และ MCQ ข้อ 41 เรื่องปฏิกิริยาจากการให้เลือด
- AABB Technical Manual 20th ed.

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.2.21** Incompatible blood transfusion — 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน หน้า 60
- **NL 2.3.3(4)** Immune hemolytic anemia (autoimmune, drug-induced) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61
- **NL B4.2.2(12)** Urticaria (กลุ่มที่ 1-2) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24

6.1 (2 คะแนน)

- ผื่นสีม่วงแดงที่เปลือกตาบนสองข้าง (อาจมีบวมร่วม) = **heliotrope rash**
- ผื่นแดงนูนเป็นขุยบน ข้อนิ้วมือด้านหลัง (**MCP, PIP**) = **Gotttron papules** (ถ้าเป็นปื้นราบเรียกว่า Gottron sign)

6.2 (2 คะแนน) — Dermatomyositis (idiopathic inflammatory myopathy) จากกล้ามเนื้ออ่อนแรงส่วนต้นสองข้างแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ปวดเด่น + CK สูงมาก + ผื่นจำเพาะสองอย่าง

6.3 (2 คะแนน) — ไม่เห็นด้วย เพราะ AST และ ALT ไม่ได้จำเพาะต่อดับ — พบในกล้ามเนื้อลายด้วย ในเคสนี้ ALP และ GGT ปกติ ซึ่งบ่งว่าไม่มีพยาธิสภาพที่ตับหรือทางเดินน้ำดีจริง ค่าที่สูงจึงอธิบายได้ด้วยการสลายของกล้ามเนื้อ (สอดคล้องกับ CK 4,200) ควรยืนยันด้วย aldolase และประเมินกล้ามเนื้อต่อ แทนการเจาะตับ

6.4 การตรวจเพิ่มเติม (4 คะแนน) — ตอบ 4 ใน

1. **Myositis-specific/associated antibodies** (ANA, **anti-Jo-1** และ antisynthetase อื่น, anti-Mi-2, **anti-MDA5**, anti-TIF1-γ ซึ่งสัมพันธ์กับมะเร็ง) — ช่วยจัดกลุ่มและทำนายภาวะแทรกซ้อน
2. **EMG** — ดู myopathic pattern และเลือกตำแหน่งตัดชิ้นเนื้อ
3. **MRI** กล้ามเนื้อต้นขา — หาบริเวณอักเสบ (edema) เพื่อชี้ตำแหน่ง biopsy
4. **Muscle biopsy** — ยืนยันการวินิจฉัยและแยกจาก necrotizing myopathy/inclusion body myositis
5. ประเมินปอด: **CXR, HRCT และ pulmonary function test** — interstitial lung disease พบบ่อยโดยเฉพาะกลุ่ม anti-Jo-1/anti-MDA5 และเป็นสาเหตุการตายสำคัญ
6. ประเมินการกลืนและเสียง — dysphagia จากกล้ามเนื้อคอหอย เสี่ยงสำลัก
7. คัดกรองมะเร็งตามอายุและเพศ — mammogram, Pap smear, CT ทรวงอก/ช่องท้อง/อุ้งเชิงกราน, ตรวจโพรงหลังจมูก (nasopharyngeal carcinoma พบบ่อยในคนไทย), ส่องกล้องทางเดินอาหารตามข้อบ่งชี้ เพราะ **dermatomyositis** ในผู้ใหญ่สัมพันธ์กับมะเร็งแพร่ราว **15-25%**

REF

- MED33 โปย MCQ 'Myalgia AST สูงเป็น 1000 ALT ปกติ investigation: CPK'
- MED33 โปย Rheumato ข้อ 5 (statin myopathy)

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.2-3(2)** Polymyositis, dermatomyositis (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 26
- **NL 2.3.13-3(10)** Polymyositis, dermatomyositis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.1.22** กล้ามเนื้ออ่อนแรง (muscle weakness) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL 2.1.26** ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก (musculoskeletal pain) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

ส่วนที่ 3 • คลังข้อสอบเก่า MED28 - MED35

50 ข้อ จัดกลุ่มตาม lecture พร้อมระบุรุ่น ครั้งที่สอบ loop และเลขข้อ

Lec 08 • Allergy and clinical immunology — TBD — แก้ใน config.lectures (18 ข้อ)

เรียบเรียงจากโพย MED28-MED35 เป็นตัวเลือก 5 ข้อพร้อมเฉลย — 18 ข้อ

AIR-OLD-01 • Lec 08

A 32-year-old man develops generalized itchy wheals within 30 minutes of taking an oral antibiotic. The lesions blanch on pressure and each individual wheal disappears within a few hours. Which type of hypersensitivity reaction is this?

- A. Type IV (delayed, T-cell mediated)
- B. Type I (IgE-mediated immediate hypersensitivity)**
- C. Type II (antibody-dependent cytotoxic)
- D. Type III (immune complex)
- E. Non-immunologic idiosyncratic reaction

ตอบ B

Urticaria ที่เกิดภายในนาที่-ชั่วโมง = **type I** IgE จับ mast cell แล้วปล่อย histamine ทำให้หลอดเลือดขยายและรั่ว เกิด wheal ที่ กดจางและย้ายที่ภายในวันเดียว — ถ้าตุ่มเดิมอยู่นานเกิน 24 ชั่วโมงและทิ้งรอยจ้ำ ให้คิดถึง urticarial vasculitis แทน

MED33 โพย MCQ ข้อ 44 'Urticaria hypersensitivity type 1'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B4.2.2(12)** Urticaria (กลุ่มที่ 1-2) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24
- **NL 2.3.12(12)** Urticaria (กลุ่มที่ 2) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 66
- **NL 2.1.51** คัน (pruritus) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

A patient who survived anaphylactic shock from a bee sting is being discharged. Which of the following is the most appropriate advice?

- A. Return for skin testing before any further treatment is given
- B. Carry an adrenaline auto-injector at all times and use it immediately when symptoms begin**
- C. Avoid all outdoor activity permanently
- D. Take a daily low-dose corticosteroid to prevent further reactions
- E. Take a daily antihistamine for life to prevent further reactions

ตอบ B

โจทย์ทำให้ตัวเลือก 'พกปากกา' กับ 'ฉีด/กิน antihistamine ทุกวัน' — คำตอบคือพกปากกา (**adrenaline auto-injector**); ยาแก้แพ้กินทุกวันไม่ป้องกัน anaphylaxis และอาจกลบอาการเตือนจนฉีด adrenaline ช้า ควรให้ action plan และส่ง allergist เพื่อพิจารณา venom immunotherapy ซึ่งลดการเกิดซ้ำได้จริงในกรณีแพ้พิษผึ้ง/ต่อ

MED33 โจทย์ MCQ ข้อ 45 'Anaphylactic shock d/c แล้วทำไรต่อ > พกปากกา, ฉีด antihistamine ทุกวัน'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.2.7** Shock: hypovolemic, anaphylactic, septic, cardiogenic — 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน หน้า 60
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

A 28-year-old woman develops itching, generalized flushing, wheezing and hypotension 15 minutes after eating at a restaurant. Which is the most appropriate first drug and route?

- A. Adrenaline 0.3-0.5 mg intramuscularly**
- B. Hydrocortisone 200 mg intravenously
- C. Chlorpheniramine 10 mg intravenously
- D. Adrenaline 0.3 mg subcutaneously
- E. Salbutamol nebulization

ตอบ A

Adrenaline IM ที่ต้นขาด้านนอกคือคำตอบเสมอ ไม่ใช่ SC (ดูดซึมช้าและไม่แน่นอนโดยเฉพาะเมื่อ shock) ยาแก้แพ้และสเตียรอยด์เป็นยาเสริมที่ออกฤทธิ์ช้าเกินกว่าจะช่วยชีวิต

MED33 โจทย์ MCQ 'กินข้าว > ผื่นขึ้น > ให้รูบผื่น > โรค Anaphylaxis > treat โดย Adrenaline IM'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.2.7** Shock: hypovolemic, anaphylactic, septic, cardiogenic — 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน หน้า 60
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

A patient develops Stevens-Johnson syndrome after receiving allopurinol. Testing for which allele would have identified the risk before prescribing?

- A. HLA-B27
- B. HLA-DR4
- C. HLA-B*15:02
- D. HLA-B*57:01
- E. **HLA-B*58:01**

ตอบ E

โพลีเมอร์ให้ตัวเลือก 'HLA-B1502' กับ 'HLA-B5802' — ที่ถูกต้องคือ *HLA-B*58:01 สำหรับ allopurinol; B*15:02 คู่กับ carbamazepine, B*57:01 คู่กับ abacavir, HLA-DR4 สัมพันธ์กับ RA และ B27 กับ spondyloarthropathy

MED33 โพลี Skin ข้อ 2 'คนไข้มาด้วย SJS ก่อนหน้านี้มีประวัติให้ยา Allopurinol ซึ่งไม่ได้ส่งตรวจยีนอะไรก่อนให้'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B4.2.2(13)** Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis (กลุ่มที่ 1-2) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24
- **NL 2.3.12(13)** Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis (กลุ่มที่ 2) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 66
- **NL B5.4(4)** Drugs for treatment of gout and hyperuricemia — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28

A patient taking allopurinol develops a widespread painful rash with erosions of the lips, oral mucosa and conjunctivae, with skin detachment of about 8% of body surface area. What is the diagnosis?

- A. Staphylococcal scalded skin syndrome
- B. Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms
- C. Acute generalized exanthematous pustulosis
- D. Erythema multiforme minor
- E. **Stevens-Johnson syndrome**

ตอบ E

การมีเยื่อเมือกอย่างน้อย 2 ตำแหน่งเป็นแผลร่วมกับผิวหนังลอก = **SJS** (ลอก < 10% = SJS, 10-30% = overlap, > 30% = TEN) ต่างจาก erythema multiforme ที่เป็น target lesion ปลายแขนขาและมักจากภูมิ; การรักษาที่สำคัญที่สุดคือ หยุดยาต้นเหตุทันที แล้วดูแลแบบผู้ป่วยไฟไหม้ พร้อมปรึกษาจักษุแพทย์ตั้งแต่วันแรก

MED33 โพลี MCQ ข้อ 2 'Allopurinol แพ้ยาแบบ involve mucosa > SJS'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B4.2.2(13)** Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis (กลุ่มที่ 1-2) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24
- **NL 2.3.12(13)** Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis (กลุ่มที่ 2) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 66
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

Fifteen minutes after a packed red cell transfusion is started, a patient develops itchy urticarial wheals only, with no fever, no hypotension and normal urine colour. What is the most likely type of reaction?

- A. Febrile non-hemolytic transfusion reaction
- B. Delayed hemolytic transfusion reaction
- C. Allergic (urticarial) transfusion reaction**
- D. Post-transfusion purpura
- E. Acute hemolytic transfusion reaction

ตอบ C

โพลีเกาให้ตัวเลือก delayed / acute / allergy / purpura — **ตอบ allergic** เพราะมีแต่ผื่นลมพิษ ไม่มีไข้ ไม่มี hemolysis; เวลา **15 นาที** อย่างเดียวไม่ได้แปลว่าเป็น **acute hemolytic** ต้องดูอาการร่วม (ไข้ ปวดเอว ปัสสาวะดำ ความดันตก) เป็นชนิดเดียวที่ให้เลือดต่อได้หลังให้ antihistamine

MED33 โพลี MCQ ข้อ 41 'Blood transfusion ทำไป 15 นาทีเกิดผื่นขึ้น (delay, acute, allergy, purpura)'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.2.21** Incompatible blood transfusion — 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน หน้า 60
- **NL B4.2.2(12)** Urticaria (กลุ่มที่ 1-2) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24

A patient develops fever and chills 2 hours into a red cell transfusion. Urine colour is normal, blood pressure is stable and there is no flank pain. What is the most likely diagnosis and the measure to prevent recurrence?

- A. Transfusion-associated circulatory overload; give diuretics
- B. Febrile non-hemolytic transfusion reaction; use leukocyte-reduced blood components in future transfusions**
- C. Bacterial contamination; culture the unit and give antibiotics
- D. Transfusion-related acute lung injury; use plasma from male donors
- E. Acute hemolytic transfusion reaction; recheck ABO compatibility

ตอบ B

ไข้และหนาวสั่นโดยไม่มี **hemolysis** = **FNHTR** จาก cytokine ที่สะสมจากเม็ดเลือดขาวของผู้ให้ หรือแอนติบอดีของผู้รับต่อ HLA ของเม็ดเลือดขาว — ป้องกันด้วย **leukocyte-reduced (leukocyte-poor) blood** ไม่ใช้การให้ยาลดไข่วางหน้าเป็นประจำ; ที่สำคัญคือ **ต้องหยุดให้เลือดและตรวจแยก AHTR** กับการปนเปื้อนเชื้อก่อนเสมอ

MED33 โพลี Hemato ข้อ 3 'ให้เลือดแล้วมีไข้ ไม่มี dark urine > febrile non hemolytic transfusion reaction' และข้อ 'ให้ leukocyte poor RBC'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.2.21** Incompatible blood transfusion — 2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน หน้า 60
- **NL 2.1.1** ไข้ (fever) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

A 25-year-old woman has anemia and jaundice. Blood smear shows spherocytes and polychromasia; direct Coombs test is positive. Which additional investigation should be sent to look for an underlying cause?

- A. Anti-cyclic citrullinated peptide
- B. Antinuclear antibody**
- C. Serum uric acid
- D. Rheumatoid factor
- E. Serum ferritin

ตอบ B

Warm autoimmune hemolytic anemia (Coombs บวก) ต้องหาโรคที่ซ่อนอยู่เสมอ — โดยเฉพาะ SLE (ส่ง ANA), lymphoproliferative disorder, ยา และการติดเชื้อ; AIHA อาจเป็นอาการนำของ SLE ก่อนอาการอื่นหลายเดือนถึงปี

MED33 โฟย 'ข้อ AIHA > ANA' และโฟย OSCE 'Ddx WAIHA, HS – investigation: Coomb's test, ANA, CBC'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3(4)** Immune hemolytic anemia (autoimmune, drug-induced) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61
- **NL B5.3(5)** Serologic studies: antinuclear antibody (ANA), rheumatoid factor — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

A newly diagnosed HIV-positive man has isolated thrombocytopenia (platelet 80,000/mm³) with normal hemoglobin and white cell count, and no bleeding. What is the most appropriate management?

- A. Splenectomy
- B. Start antiretroviral therapy and monitor the platelet count**
- C. Bone marrow transplantation
- D. High-dose intravenous immunoglobulin as lifelong maintenance
- E. Immediate platelet transfusion

ตอบ B

HIV-associated immune thrombocytopenia มักดีขึ้นเมื่อได้ ART เพราะการติดเชื้อเองเป็นตัวขับเคลื่อนการภูมิคุ้มกัน; เกล็ดเลือด 80,000 โดยไม่มีเลือดออก **ไม่มีข้อบ่งชี้ให้เกล็ดเลือด**; IVIG หรือสเตียรอยด์สงวนไว้เมื่อเลือดออกหรือเกล็ดเลือดต่ำมาก (การเจาะไขกระดูกพิจารณาเมื่อภาพเลือดผิดปกติหลายซีรีส์)

MED34 โฟย MCQ 'First diag HIV Plt 80,000 invest thrombocytopenia?' และ 'Management ของคนแรก diagnosis HIV ที่ Plt ต่ำ'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3(5)** Immune thrombocytopenia (กลุ่มที่ 2) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61
- **NL 2.3.3-3(5)** Immune deficiency states (neutropenia, asplenia/splenic dysfunction, post-chemotherapy) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61

A young woman presents with easy bruising for 1 week. CBC shows isolated thrombocytopenia with giant platelets on smear; hemoglobin and white cells are normal. Besides a bone marrow study if indicated, which screening tests are most appropriate to look for secondary causes?

A. Antinuclear antibody, anti-HIV and anti-hepatitis C virus

- B. Serum uric acid and rheumatoid factor
- C. Coagulogram and fibrinogen only
- D. Direct Coombs test and haptoglobin only
- E. Serum protein electrophoresis

ตอบ A

Immune thrombocytopenia (ITP) เป็นการวินิจฉัยแบบตัดโรคอื่นออก — โรคที่ทำให้เกิด ITP พุติภูมิและต้องคัดกรองคือ **SLE (ANA)**, **HIV** และ **HCV** (บวก H. pylori ในบางแนวทาง); giant platelet สะท้อนว่าไขกระดูกสร้างชดเชยเต็มที่ ซึ่งเข้าได้กับการทำลายที่ม้าม

MED35 OSCE ข้อ 2 'ให้รูป PBS ... Plt decreased, giant platelet จะส่ง invest อะไร 2 อย่าง วินิจฉัยอะไร ตอบ ITP ส่ง ANA titer, anti HIV, HCV'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3(5)** Immune thrombocytopenia (กลุ่มที่ 2) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61
- **NL B5.3(5)** Serologic studies: antinuclear antibody (ANA), rheumatoid factor — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28

A patient on long-term prednisolone 30 mg daily for lupus nephritis asks about vaccination. Which vaccine is contraindicated?

A. Live attenuated varicella vaccine

- B. Inactivated influenza vaccine
- C. Hepatitis B vaccine
- D. Recombinant zoster vaccine
- E. Pneumococcal polysaccharide vaccine

ตอบ A

Prednisolone $\geq$ 20 mg/วันนานเกิน 2 สัปดาห์ = กดภูมิอย่างมีนัยสำคัญ → ห้ามวัคซีนเชื้อเป็น (varicella, MMR, LAIV, BCG, yellow fever); วัคซีนเชื้อตายและ recombinant ให้ได้และควรให้ เพราะกลุ่มนี้ติดเชื้อรุนแรงกว่าคนทั่วไป

MED34 โปย MCQ วัคซีนในผู้ป่วยที่ได้ยากดภูมิ

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3-3(5)** Immune deficiency states (neutropenia, asplenia/splenic dysfunction, post-chemotherapy) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61
- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

A woman with SLE has been on prednisolone for 3 years and now presents in pregnancy with fasting plasma glucose 138 mg/dL and HbA1c 7.2% at 8 weeks of gestation. How should her hyperglycemia be classified?

- A. Gestational diabetes mellitus
- B. Pre-existing (overt) diabetes mellitus detected in pregnancy, likely glucocorticoid-induced**
- C. Stress hyperglycemia from pregnancy
- D. Impaired fasting glucose
- E. Type 1 diabetes mellitus

ตอบ B

โพยเก่าตอบว่า ไม่ใช่ gestational DM แต่เป็นเบาหวานที่มีอยู่ก่อน — เพราะตรวจพบ ตั้งแต่ไตรมาสแรกและค่าถึงเกณฑ์เบาหวานทั่วไป (**FPG ≥ 126 หรือ HbA1c $\geq 6.5\%$**) GDM ตามนิยามคือความผิดปกติที่ตรวจพบครั้งแรกในไตรมาสที่ 2-3 และค่าต่ำกว่าเกณฑ์เบาหวานชัดเจน; สเตียรอยด์ระยะยาวทำให้ดื้ออินซูลินและเป็นสาเหตุที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันตนเอง

MED34 โพย MCQ 'ข้อคนท้อง gestational diabetes เป็น SLE ใช้ Prednisolone 3 ปี ตอบ DM type 2'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

A 20-year-old man presents with fever, arthralgia, a maculopapular rash over the trunk and extremities, and swelling with warmth and limited movement of both knees, ankles and elbows. Hct 40%, WBC 3,500/mm³ (N 45%, L 50%, atypical lymphocyte 5%), platelet 45,000/mm³. What is the most likely diagnosis?

- A. Acute gouty arthritis
- B. Septic arthritis
- C. Chikungunya virus infection**
- D. Systemic lupus erythematosus
- E. Rickettsial infection

ตอบ C

ไข้ + ผื่น + ปวดข้อหลายข้อสมมาตร + เม็ดเลือดขาวต่ำ + เกล็ดเลือดต่ำ + **atypical lymphocyte** = ไขรัส (**chikungunya หรือ dengue**) ไม่ใช่เก๊าท์ซึ่งไม่ทำให้เม็ดเลือดต่ำและมักเป็นข้อเดียวในชายที่มีปัจจัยเสี่ยง; chikungunya เด่นที่ ปวดข้อรุนแรงหลายข้อและอาจปวดต่อเนื่องเป็นเดือน ส่วน dengue เด่นที่ไข้สูง ปวดเมื่อย และเกล็ดเลือดต่ำมากกว่า

MED34 โพย MCQ '20 year old man fever, arthralgia, rash ... Diag? A. Chikungunya B. Acute gout C. Rickettsia'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.1.27** ปวดข้อ ข้อฝืด ข้อติด (joint pain, stiff joint, frozen joint) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL 2.1.1** ไข้ (fever) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

Which of the following is the best initial screening test in a patient with suspected systemic lupus erythematosus?

- A. Antinuclear antibody**
- B. Erythrocyte sedimentation rate
- C. Anti-Smith antibody
- D. Rheumatoid factor
- E. Anti-double-stranded DNA antibody

ตอบ A

ANA = การตรวจคัดกรอง ความไวสูงกว่า 95% — ลบแทบตัด **SLE** ออกได้ แต่จำเพาะต่ำ (บวกได้ในคนปกติ 5-15%, ผู้สูงอายุ, ไทรอยด์อักเสบ); **anti-dsDNA** และ **anti-Sm** คือการตรวจยืนยัน และ anti-dsDNA ยังใช้ติดตามความ active โดยเฉพาะโรคไต

MED34 โปย MCQ ข้อ 34 'ANA'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.3(5)** Serologic studies: antinuclear antibody (ANA), rheumatoid factor — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

A 45-year-old woman on hydralazine for 1 year develops arthralgia, fever and pleuritic chest pain. ANA is positive, anti-double-stranded DNA is negative, anti-histone antibody is positive and complement levels are normal. What is the diagnosis?

- A. Rheumatoid arthritis with serositis
- B. Systemic lupus erythematosus with renal involvement
- C. Drug-induced lupus erythematosus**
- D. Viral pleuritis
- E. Acute rheumatic fever

ตอบ C

Anti-histone บวก + **anti-dsDNA** ลบ + **complement** ปกติ + ไม่เข้าไตและสมอง = **drug-induced lupus** ยาคลาสสิกคือ **hydralazine, procainamide, isoniazid, minocycline, anti-TNF** — รักษาโดย หยุดยา อาการหายในไม่กี่สัปดาห์ (ANA อาจบวกอยู่ได้เป็นเดือนถึงปี)

MED33 โปย MCQ ข้อ 7 'SLE ยา hydralazine'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.3(5)** Serologic studies: antinuclear antibody (ANA), rheumatoid factor — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28

A patient with SLE on prednisolone and immunosuppressants presents with 1 week of dry cough, fever and dyspnea with bilateral interstitial infiltrates and marked hypoxemia but an unremarkable lung examination. What should be done first?

- A. Increase the corticosteroid dose for a presumed lupus flare
- B. Start cyclophosphamide for lupus pneumonitis
- C. Give oral amoxicillin and discharge
- D. Treat empirically for Pneumocystis pneumonia while investigating for infection**
- E. Observe and repeat the chest radiograph in 1 week

ตอบ D

ผู้ป่วยกดภูมิที่มีไข้ ต้องคิดถึงการติดเชื้อก่อนโรคกำเริบเสมอ — ภาพไอแห้ง ฆาตออกซิเจนมากกว่าที่ฟังปอดได้ + ฝ้า interstitial สองข้าง + LDH สูง = **PCP** ให้ TMP-SMX ทันทีและเพิ่มสเตียรอยด์เสริมเมื่อ $\text{PaO}_2 < 70 \text{ mmHg}$ พร้อมส่งตรวจยืนยัน; การเพิ่มยากดภูมิโดยยังไม่ตัดการติดเชื้ออาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

MED34 โปย MCQ 'ช. 30 ปี มีโรคประจำตัว SLE, Lupus nephritis on prednisolone มาด้วยไอ...'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3-3(5)** Immune deficiency states (neutropenia, asplenia/splenic dysfunction, post-chemotherapy) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61
- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.1.1** ไข้ (fever) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

Which drug used in systemic lupus erythematosus requires periodic ophthalmologic screening because of the risk of irreversible maculopathy?

- A. Azathioprine
- B. Prednisolone
- C. Hydroxyurea
- D. Hydroxychloroquine**
- E. Mycophenolate mofetil

ตอบ D

โปยเก่าเขียนชื่อยาเป็น 'hydroxyurea' ซึ่ง ผิด — ยาที่ทำให้เกิด **bull's-eye maculopathy** คือ **hydroxychloroquine** ต้องตรวจตาพื้นฐานในปีแรกและตรวจทุกปีหลังใช้ครบ 5 ปี (เร็วกว่านั้นถ้าขนาด $> 5 \text{ mg/kg/day}$ หรือมีโรคไต) ด้วย visual field และ OCT; ส่วนสเตียรอยด์ทำให้เกิดต่อกระจกและต้อหิน ซึ่งเป็นคนละภาวะ

MED33 โปย Rheumato ข้อ 2 'Maculopathy ห้ามให้ยา — a. Hydroxyurea'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.4(3)** Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28

A woman with four unexplained pregnancy losses and a past unprovoked deep vein thrombosis is suspected of having antiphospholipid syndrome. Which antibody should be tested?

- A. Anti-SSA (Ro) antibody
- B. Anti-topoisomerase I (Scl-70) antibody
- C. Anticardiolipin antibody (with lupus anticoagulant and anti-beta-2-glycoprotein I)**
- D. Anti-histone antibody
- E. Anti-mitochondrial antibody

ตอบ C

โพยเก่าให้ตัวเลือก 'Anti SSA (Ro)' กับ 'Anti-cardiolipin' — ตอบ **anticardiolipin** และต้องส่งครบสามตัว (LA, aCL, anti-β2GPI) พร้อม ยืนยันซ้ำทางกันอย่างน้อย **12** สัปดาห์; anti-SSA สัมพันธ์กับ Sjogren และ neonatal lupus/congenital heart block ไม่ใช้การแท้งซ้ำจากลิ้มเลือด

MED33 โพย Rheumato ข้อ 3 'ผู้หญิงตั้งครรภ์ มีประวัติแท้ง 4 ครั้ง ประวัติแบบ antiphospholipid syndrome ตรวจอะไร'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.3(5)** Serologic studies: antinuclear antibody (ANA), rheumatoid factor — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28

Lec 23 · Approach to arthritis / crystal and infective arthropathy — TBD — แก้วใน config.lectures (15 ข้อ)

เรียบเรียงจากโพย MED28-MED35 เป็นตัวเลือก 5 ข้อพร้อมเฉลย — 15 ข้อ

Synovial fluid from a painful knee contains rhomboid-shaped crystals that are weakly positively birefringent under polarized light. What is the diagnosis?

- A. Gout
- B. Hydroxyapatite deposition disease
- C. Calcium pyrophosphate deposition disease (pseudogout)**
- D. Rheumatoid arthritis
- E. Septic arthritis

ตอบ C

Rhomboid + weakly POSITIVE birefringent = calcium PYROPHOSPHATE dihydrate (CPPD) —

โพยเก่าบางฉบับเขียนชื่อผิดเป็น 'calcium phosphate dihydrate' ให้จำชื่อที่ถูก; เทียบกับเก๊าคือที่เป็น เข้ม **negative birefringent**; พิล์มมักเห็น **chondrocalcinosis** ที่หมอนรองกระดูกเข่าหรือข้อมือ

MED33 โพย Joint ข้อ 1 'ตะกอน rhomboid-shaped crystals weakly positively birefringent — a. Calcium phosphate dihydrate deposition (cppd)'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.5(1)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.3(3)** Synovial fluid analysis — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28

In the same patient with pseudogout of the knee, which additional synovial fluid profile is expected?

- A. Inflammatory fluid with WBC 2,000-50,000/mm³, predominantly neutrophils, and reduced viscosity**
- B. Clear fluid with normal viscosity and WBC below 200/mm³
- C. Purulent fluid with WBC above 100,000/mm³ and positive Gram stain
- D. Bloody fluid with fat globules
- E. Non-inflammatory fluid with WBC below 2,000/mm³ and high viscosity

ตอบ A

CPPD เป็น **crystal-induced inflammation** จึงให้ profile แบบ inflammatory: ชุ่น ความหนืดลดลง (เพราะ hyaluronate ถูกย่อย) WBC 2,000-50,000 โดย PMN เต็ม — ถ้า WBC > 50,000 และ PMN > 90% ต้องคิด septic arthritis และรักษาแบบติดเชื้อจนกว่าผลเพาะเชื้อจะออก แม้จะพบผลึกแล้วก็ตาม

MED33 โปย MCQ ข้อ 11 'Synovial fluid rhomboid shape > ถามว่าจะเจออะไรอีก viscosity, wbc อะไรที่ match cppd'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.3(3)** Synovial fluid analysis — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL 3.1.7** Body fluid analysis (e.g., CSF, pleural, synovial) — 3.1 ตรวจและแปลผลได้ด้วยตนเอง หน้า 71
- **NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

A 50-year-old man with acute pain of the first metatarsophalangeal joint has synovial fluid showing needle-shaped, strongly negatively birefringent crystals. What is the diagnosis?

- A. Osteoarthritis with effusion
- B. Pseudogout
- C. Reactive arthritis
- D. Acute gouty arthritis**
- E. Psoriatic arthritis

ตอบ D

เข็ม + **negative birefringent** (เหลือแสงเมื่อขนานแกน compensator) = **monosodium urate** → **gout**;

ตำแหน่งโคนนิ้วหัวแม่เท้าเรียก **podagra**; การพบผลึก ภายในเซลล์เม็ดเลือดขาว ยืนยันว่าเป็นสาเหตุของการอักเสบครั้งนี้จริง

MED35 OSCE/SAQ ข้อ 7 'ให้รูป uric acid crystal needle shape และวินิจฉัย ตอบ gout'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.5(1)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.3(3)** Synovial fluid analysis — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28

Which drug is the most appropriate first-line treatment for an acute gout flare in a patient with peptic ulcer disease?

- A. Allopurinol
- B. Naproxen
- C. **Colchicine**
- D. Aspirin
- E. Indomethacin

ตอบ C

โพยเก่าตอบ **colchicine** — เหมาะเมื่อใช้ NSAID ไม่ได้ (แผลในกระเพาะ ไตเสื่อม หัวใจล้มเหลว) ใช้ขนาดต่ำ 1.2 mg แล้วตาม 0.6 mg ใน 1 ชั่วโมง; สเตียรอยด์กินหรือฉีดเข้าข้อก็เป็นทางเลือกที่ดีเท่ากัน; **allopurinol** ไม่ใช่ยารักษา **flare** และ aspirin ขนาดต่ำ-กลางยิ่งทำให้ urate สูงขึ้น

MED33 โพย MCQ ข้อ 21 'Gout ให้ colchicine'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.5(1)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27
- **NL B5.4(4)** Drugs for treatment of gout and hyperuricemia — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28
- **NL B5.4(1)** Non-steroidal anti-inflammatory drugs — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28

A patient on anti-tuberculous therapy develops joint pain with a serum uric acid of 10 mg/dL. Which drug is responsible?

- A. **Pyrazinamide**
- B. Rifampicin
- C. Ethionamide
- D. Streptomycin
- E. Isoniazid

ตอบ A

Pyrazinamide — metabolite pyrazinoic acid ยับยั้งการขับ urate ที่ท่อไต (ethambutol เสริมฤทธิ์นี้ได้เล็กน้อย จึงมีตัวเลือก 'pyrazinamide + ethambutol' ในโพยบางปี ถ้าให้เลือกยาตัวเดียวให้ตอบ pyrazinamide); **hyperuricemia** ที่ไม่มีอาการไม่ต้องรักษาและไม่ต้องหยุดยา ถ้ามีข้ออักเสบให้รักษาตามอาการ

MED33 โพย MCQ ข้อ 5, 72 และ 82 'ยา TB ปวดข้อเป็น gout > pyrazinamide (+ ethambutol)'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.5(1)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.3(4)** Serum uric acid — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28

A patient with a hot swollen knee has synovial fluid Gram stain showing gram-positive cocci in clusters. What is the most appropriate antibiotic?

- A. Oral doxycycline
- B. Intravenous ceftriaxone
- C. Intravenous cloxacillin**
- D. Intravenous metronidazole
- E. Oral amoxicillin

ตอบ C

GPC in clusters = Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นเชื้อที่พบบ่อยที่สุดของ septic arthritis ในผู้ใหญ่ → **cloxacillin หรือ cefazolin** สำหรับ **MSSA** (ถ้าเสี่ยง MRSA ให้ vancomycin ไปก่อน) และต้อง ระบายหนองออกจากข้อควบคู่เสมอ มิฉะนั้นกระดูกอ่อนถูกทำลายถาวร

MED33 โปย MCQ ข้อ 8 'Knee pain c/s gram positive cocci in cluster ให้ iv cloxacillin'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(6)** Infective arthritis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.2.2-3(1)** Infective arthritis (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 26
- **NL B5.3(3)** Synovial fluid analysis — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28

A patient with septic arthritis on intravenous cloxacillin for 12 days is clinically well but the neutrophil count has fallen to 900/mm³. What is the most appropriate next step?

- A. Recognize drug-induced neutropenia and switch to another effective antibiotic class with monitoring**
- B. Continue the same antibiotic and repeat the count in 1 month
- C. Stop all antibiotics and observe
- D. Add granulocyte colony-stimulating factor and continue the same drug
- E. Perform bone marrow biopsy before any change

ตอบ A

โปยเก๋ตอบ 'ให้ cloxacillin ต่อ' ซึ่ง ไม่ปลอดภัยเมื่อ **ANC** ต่ำถึง **900** และยังต้องให้ยาต่ออีกหลายสัปดาห์ — beta-lactam ขนาดสูงนานเกิน 10-14 วันทำให้เกิด neutropenia ได้บ่อย และค่าจะฟื้นภายใน 1-2 สัปดาห์หลังเปลี่ยนยา แนวทางที่เหมาะสมคือ เปลี่ยนกลุ่มยาที่ยังครอบคลุมเชื้อเดิมแล้วติดตาม **CBC**; ถ้าค่าไม่ฟื้นหลังหยุดยาจึงพิจารณาเจาะไขกระดูก

MED33 โปย MCQ ข้อ 8 (ต่อ) 'ให้ iv cloxacillin ไป 5 วัน มาตรวจติดตาม neutrophil ลด ทำไรต่อ > ให้ iv cloxacillin ต่อ'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3-3(5)** Immune deficiency states (neutropenia, asplenia/splenic dysfunction, post-chemotherapy) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61
- **NL 2.3.13-3(6)** Infective arthritis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

A 45-year-old man presents with acute arthritis. Which of the following history items is most important to obtain?

- A. Only current occupation
- B. Sexual history, alcohol intake, recent infection and family history of arthritis**
- C. Only a history of previous trauma
- D. Only the response to paracetamol
- E. Only the duration of pain

ตอบ B

โพยเก่าตอบ '**sex, drinking, smoking, family**' — เหตุผลคือประวัติแต่ละข้อชี้โรคคนละโรค: เพศสัมพันธ์ → gonococcal arthritis และ reactive arthritis, สุรา → เก๊าท์และ osteonecrosis, การติดเชื้อทางเดินอาหาร/ปัสสาวะนำมาก่อน → reactive arthritis, ประวัติครอบครัว → RA, spondyloarthropathy, สะเก็ดเงิน; บวก ยาที่ใช้ (thiazide, pyrazinamide) และ ประวัติฉีดยาเข้าเส้น

MED33 โพย MCQ ข้อ 16 'Arthritis ถามว่าต้องถามประวัติอะไร > sex, drinking, smoking, fam'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.1.27** ปวดข้อ ข้อฝืด ข้อติด (joint pain, stiff joint, frozen joint) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.3.13-3(6)** Infective arthritis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

A 60-year-old woman has bilateral knee pain worse with walking, relieved by rest, with 10 minutes of morning stiffness and bony enlargement of the distal interphalangeal joints. ANA and rheumatoid factor are negative. Radiograph shows joint space narrowing with osteophytes. What is the diagnosis?

- A. Psoriatic arthritis
- B. Rheumatoid arthritis
- C. Osteoarthritis**
- D. Polymyalgia rheumatica
- E. Systemic lupus erythematosus

ตอบ C

ฝืดเช้าสั้น + ปวดเมื่อใช้งาน + ปุ่มกระดูกที่ DIP (Heberden node) + osteophyte บนฟิล์ม = OA; RA จะเป็น MCP/PIP/ข้อมือ ฝืดเช้า > 1 ชั่วโมง และฟิล์มเห็น periarticular osteopenia กับ marginal erosion ไม่ใช่ osteophyte

MED34 โพย MCQ 'Osteopenia at PIP, MCP, mild joint space narrowing no erosion, ANA negative RF negative – Diag? A. Osteoarthritis B. RA'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.7(1)** Osteoarthritis (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.7 Degenerative disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13(5)** Osteoarthritis (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.3(1)** Plain film of bones and joints — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 27

A 46-year-old woman has symmetric swelling of the MCP and PIP joints of both hands with morning stiffness of more than 30 minutes for 4 months. What is the most likely diagnosis?

- A. **Rheumatoid arthritis**
- B. Reactive arthritis
- C. Gouty arthritis
- D. Septic arthritis
- E. Osteoarthritis

ตอบ A

ข้อเล็กสองข้างสมมาตร + ผิดเข้านาน + เป็นเรื้อรังเกิน 6 สัปดาห์ = **RA**; โปยเก่าใช้เกณฑ์ 'morning stiffness > 30 นาที' แต่เกณฑ์ ACR/EULAR 2010 ให้น้ำหนักกับ จำนวนและขนาดของข้อที่บวม ระยะเวลา ≥ 6 สัปดาห์ **RF/anti-CCP** และ **ESR/CRP** — ผิดเข้าเป็นเพียงลักษณะประกอบที่บ่งว่าเป็น inflammatory

MED33 โปย MCQ ข้อ 4 'Morning stiffness more than 30 minutes – a. Rheumatoid arthritis b. Reactive arthritis' และ Joint ข้อ 2

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(12)** Rheumatoid arthritis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.2.2-3(4)** Rheumatoid arthritis (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 26
- **NL 2.1.27** ปวดข้อ ข้อฝืด ข้อติด (joint pain, stiff joint, frozen joint) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

Which radiographic finding is most characteristic of long-standing tophaceous gout?

- A. Bamboo spine
- B. **Punched-out erosion with sclerotic margin and overhanging edge, with preserved joint space**
- C. Marginal erosion with periarticular osteopenia and uniform joint space narrowing
- D. Chondrocalcinosis of the menisci
- E. Osteophyte with subchondral sclerosis

ตอบ B

Punched-out erosion + overhanging edge + ช่องข้อกว้างปกติ = chronic gout; marginal erosion + periarticular osteopenia = RA; osteophyte = OA; **chondrocalcinosis = CPPD**; bamboo spine = ankylosing spondylitis

ต่อยอดจาก MED32 โปย MCQ chronic gout (เขียนใหม่เป็นตัวเลือก)

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.3(1)** Plain film of bones and joints — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 27
- **NL 3.2.5** Plain film: bones and joints — 3.2 การตรวจทางรังสีที่ต้องแปลผลได้ หน้า 72
- **NL B5.2.5(1)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27

Which of the following is an indication to start urate-lowering therapy?

- A. Presence of tophi or two or more gout flares per year**
- B. A single gout flare in a young patient
- C. Family history of gout alone
- D. Dietary purine excess alone
- E. Asymptomatic hyperuricemia of 8 mg/dL

ตอบ A

ข้อบ่งชี้ **ULT**: tophus, flare ≥ 2 ครั้ง/ปี, กระจกถูกทำลายจากเก๊าท์, นิ่วไตจาก urate (พิจารณาเมื่อ CKD $\geq$ stage 3 หรือ urate > 9); **asymptomatic hyperuricemia** ไม่ต้องให้ยา; เริ่มขนาดต่ำ ปรับขึ้นช้า ๆ พร้อม colchicine prophylaxis 3-6 เดือน เป้าหมาย urate < 6 (มี tophus < 5)

ต่อยอดจากโพย MED32-MED34 เรื่อง gout management (เขียนใหม่เป็นตัวเลือก)

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.4(4)** Drugs for treatment of gout and hyperuricemia — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28
- **NL B5.3(4)** Serum uric acid — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL 2.3.13(2)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

A 70-year-old man on hemodialysis develops an acutely painful shoulder. Aspiration shows no crystals under polarized light but the fluid contains clumps that stain with alizarin red. What is the most likely diagnosis?

- A. Basic calcium phosphate (hydroxyapatite) associated arthritis**
- B. Rotator cuff tear
- C. Septic arthritis
- D. Pseudogout
- E. Gout

ตอบ A

Hydroxyapatite ไม่หักเหแสงใน **polarized light** จึง 'มองไม่เห็น' ต้องย้อม **alizarin red** — พบในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและกลุ่มอาการ **Milwaukee shoulder** (ข้อไหล่ถูกทำลายพร้อมน้ำในข้อปริมาณมาก); รักษาตามอาการด้วย NSAID/สเตียรอยด์และคุมสมดุลแคลเซียม-ฟอสเฟต

ต่อยอดจาก MED33 โพย Joint (crystal arthropathy) เขียนใหม่เป็นตัวเลือก

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.5(1)** Crystal arthropathy (gout, pseudogout) (กลุ่มที่ 1-2) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27
- **NL B5.3(3)** Synovial fluid analysis — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28

A 30-year-old sexually active man has migratory polyarthralgia, tenosynovitis of the wrist and a few pustular skin lesions, then develops a hot swollen knee. What is the most likely organism?

- A. Salmonella species
- B. Mycobacterium tuberculosis
- C. **Neisseria gonorrhoeae**
- D. Streptococcus pyogenes
- E. Staphylococcus aureus

ตอบ C

Disseminated gonococcal infection มาด้วย triad: **tenosynovitis + ผื่นตุ่มหนอง + migratory polyarthralgia** แล้วตามด้วยข้ออักเสบเป็นหนอง; ต้องเพาะเชื้อจากทุกตำแหน่ง (ข้อ เลือด ท่อปัสสาวะ คอ ทวาร) และรักษาด้วย **ceftriaxone** ร่วมกับการรักษา chlamydia และตามคู่มือ

ต่อยอดจาก MED33 โปย (arthritis + sexual history) เขียนใหม่เป็นตัวเลือก

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(6)** Infective arthritis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.2.2-3(1)** Infective arthritis (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 26
- **NL 2.1.27** ปวดข้อ ข้อฝืด ข้อติด (joint pain, stiff joint, frozen joint) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

A patient with acute pericarditis has pleuritic chest pain relieved by leaning forward. Which drug combination is first-line?

- A. Colchicine alone
- B. Anticoagulant plus an NSAID
- C. Antibiotics alone
- D. **Aspirin or an NSAID plus colchicine**
- E. Corticosteroid alone

ตอบ D

โปยเก่าให้ตัวเลือก 'colchicine alone' กับ 'ASA + colchicine' — คำตอบคือ **NSAID/aspirin** ร่วมกับ **colchicine** เพราะ colchicine ลดอาการและลดการเป็นซ้ำอย่างชัดเจน (ESC 2015) ส่วน สเตียรอยด์เพิ่มการกลับเป็นซ้ำ จึงสงวนไว้เมื่อมีข้อห้ามหรือเป็นจากโรคภูมิคุ้มกันตนเอง และ ห้ามให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดโดยไม่จำเป็น เพราะเสี่ยง hemopericardium

MED33 โปย MCQ ข้อ 7 'First line tx pericarditis (pleuritic chest pain, better when leaning forward) > colchicine alone, asa+colchicine'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13(1)** Costochondritis (กลุ่มที่ 2) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.4(1)** Non-steroidal anti-inflammatory drugs — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28

Lec 33 · Connective tissue diseases and vasculitis — TBD — แก้วใน config.lectures (17 ข้อ)

เรียบเรียงจากโปย MED28-MED35 เป็นตัวเลือก 5 ข้อพร้อมเฉลย — 17 ข้อ

A patient with features of systemic sclerosis has a negative ANA on the standard screening assay. Which test should be sent next?

- A. Anti-double-stranded DNA
- B. Erythrocyte sedimentation rate
- C. Anti-histone antibody
- D. Anti-topoisomerase I (anti-Scl-70) and anticentromere antibodies**
- E. Rheumatoid factor

ตอบ D

โพลีเมอร์ให้ตัวเลือก ESR / anti-dsDNA / RF — ทั้งสามไม่ช่วยวินิจฉัย systemic sclerosis; **ANA** ที่ลบไม่ตัดโรคออกเมื่อคลินิกชัด ต้องส่ง **antibody** จำเพาะ: anti-Scl-70 (สัมพันธ์กับ ILD), anticentromere (limited SSc, ความดันปอดสูง), anti-RNA polymerase III (renal crisis) และประเมินอวัยวะด้วย HRCT, PFT, echocardiography

MED33 โพลี Rheumato ข้อ 1 'อาการ Systemic sclerosis ฟังปอดได้อะไรซักอย่าง ANA negative ตรวจอะไรเพิ่ม — a. ESR b. Anti-dsDNA c. Anti-Rheumatoid factor'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B4.2.2-3(9)** Scleroderma (กลุ่มที่ 3) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24
- **NL B5.3(5)** Serologic studies: antinuclear antibody (ANA), rheumatoid factor — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

A patient with diffuse systemic sclerosis recently started on prednisolone develops blood pressure 210/120 mmHg, acute kidney injury and schistocytes on blood smear. Which drug should be started immediately?

- A. Captopril**
- B. Labetalol
- C. Nifedipine
- D. Hydralazine
- E. Furosemide

ตอบ A

Scleroderma renal crisis เกิดจาก renin-angiotensin ที่ถูกกระตุ้นอย่างรุนแรง — **ACE inhibitor** ออกฤทธิ์สั้น (**captopril**) คือยาที่ช่วยชีวิต ปรับขนาดขึ้นเร็วทุก 4-8 ชั่วโมง ห้ามหยุดแม้ **creatinine** จะสูงขึ้นในช่วงแรก; สเตียรอยด์ ตั้งแต่ **15 mg/วัน** ขึ้นไปเป็นตัวกระตุ้นสำคัญ จึงควรเลี่ยงใน SSc

ต่อยอดจาก MED32 โพลี systemic sclerosis (เขียนใหม่เป็นตัวเลือก)

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B4.2.2-3(9)** Scleroderma (กลุ่มที่ 3) — B4 Skin and related connective tissue หน้า 24
- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

AIR-OLD-36 · Lec 33

A 58-year-old man on simvastatin complains of symmetric proximal muscle aching. Which investigation should be ordered first?

- A. Electromyography
- B. Nerve conduction study
- C. Serum aldolase only
- D. Serum creatine kinase**
- E. Muscle biopsy

ตอบ D

โพยเก่าตอบ **CPK (creatin kinase)** — เป็นตัวแยกระหว่าง myalgia (CK ปกติ), myopathy (CK สูง > 10 เท่า), **rhabdomyolysis** (CK สูงมาก + ปัสสาวะสีเข้ม + ไตวาย) และ immune-mediated necrotizing myopathy (CK สูงและไม่ดีขึ้นหลังหยุดยา → สง anti-HMGCR); อย่าลืมตรวจ **TSH** และทบทวนยาที่ยับยั้ง CYP3A4 เช่น clarithromycin, itraconazole, gemfibrozil

MED33 โพย Rheumato ข้อ 5 'มาด้วยอาการปวดกล้ามเนื้อ มี dyslipidemia กินยา statin ควรส่งตรวจอะไร — a. CPK Level'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.1.26** ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก (musculoskeletal pain) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL 2.3.13-3(7)** Myopathy (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.2.5-3(1)** Myopathy (inflammatory myopathy, metabolic myopathy) (กลุ่มที่ 3) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27

AIR-OLD-37 · Lec 33

A patient has proximal muscle weakness with AST 1,000 U/L but normal ALT, ALP and GGT. What is the most appropriate next investigation?

- A. Serum ammonia
- B. Liver biopsy
- C. Creatine kinase**
- D. Hepatitis serology
- E. Abdominal ultrasound

ตอบ C

AST อยู่ในกล้ามเนื้อละลายด้วย จึงสูงได้จากโรคกล้ามเนื้อโดยที่ตับปกติ — เบาะแสคือ **ALP** และ **GGT** ปกติ และมีอาการอ่อนแรงส่วนต้น ให้ยืนยันด้วย **CK (และ aldolase)** ก่อนจะไปสืบค้นตับหรือเจาะตับโดยไม่จำเป็น

MED33 โพย MCQ 'Myalgia AST สูงเป็น 1000 ALT ปกติ investigation: CPK'

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.1.22** กล้ามเนื้ออ่อนแรง (muscle weakness) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL 2.1.26** ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก (musculoskeletal pain) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL B5.2.5-3(1)** Myopathy (inflammatory myopathy, metabolic myopathy) (กลุ่มที่ 3) — B5.2.5 Metabolic and regulatory disorders หน้า 27

A 55-year-old woman has proximal muscle weakness, a violaceous periorbital rash and scaly papules over the knuckles. Apart from treating the myositis, what must not be missed?

- A. **Screening for an underlying malignancy**
- B. Screening for iron deficiency
- C. Screening for hepatitis A
- D. Screening for diabetes mellitus
- E. Screening for osteoporosis before treatment

ตอบ A

Dermatomyositis ในผู้ใหญ่สัมพันธ์กับมะเร็งแฝงราว **15-25%** โดยเฉพาะ 1-3 ปีแรก — ไทย/เอเชียต้องระวัง **nasopharyngeal carcinoma** เป็นพิเศษ ร่วมกับรังไข่ ปอด กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ตับอ่อน; ประเมินตามอายุและเพศ + CT ทรวงอก-ช่องท้อง-อุ้งเชิงกราน + ตรวจโพรงหลังจมูก และอย่าลืมประเมิน **ILD** และการกลืน

ต่อยอดจากโพย MED33 (inflammatory myopathy) เขียนใหม่เป็นตัวเลือก

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.2-3(2)** Polymyositis, dermatomyositis (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 26
- **NL 2.3.13-3(10)** Polymyositis, dermatomyositis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.1.22** กล้ามเนื้ออ่อนแรง (muscle weakness) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

A 72-year-old woman has new temporal headache, scalp tenderness, jaw claudication and ESR 95 mm/hr. Vision is normal. What should be done first?

- A. Arrange temporal artery biopsy and wait for the result before treatment
- B. **Start high-dose corticosteroid immediately, then arrange temporal artery biopsy**
- C. Start an NSAID and review in 1 week
- D. Arrange CT brain and treat only if abnormal
- E. Start low-dose prednisolone 10 mg daily

ตอบ B

Giant cell arteritis เป็นภาวะฉุกเฉินทางตา — ตาบอดถาวรเกิดได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงถึงวัน จึง ให้สเตียรอยด์ก่อน แล้วค่อยตัดชิ้นเนื้อภายใน **1-2 สัปดาห์** ซึ่งยังให้ผลบวกได้; **jaw claudication** เป็นอาการที่มี **likelihood ratio** สูงที่สุด ของโรคนี้

ต่อยอดจาก MED32 โพย temporal arteritis (เขียนใหม่เป็นตัวเลือก)

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.2-3(2b)** Vasculitis syndrome (e.g., Kawasaki disease, polyarteritis nodosa, drug induced) (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13-3(16)** Vasculitis syndrome (Kawasaki disease, polyarteritis nodosa, drug-induced) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.1.1** ไข้ (fever) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

A 19-year-old man has palpable purpura over both legs and buttocks, colicky abdominal pain, arthralgia and hematuria one week after an upper respiratory infection. Platelet count and coagulation tests are normal. What is the diagnosis?

- A. Disseminated intravascular coagulation
- B. IgA vasculitis (Henoch-Schonlein purpura)**
- C. Acute rheumatic fever
- D. Meningococcemia
- E. Immune thrombocytopenia

ตอบ B

Palpable purpura + เก้เลือดปกติ = vasculitis ไม่ใช่ความผิดปกติของเก้เลือด; tetrad ของ IgA vasculitis คือ purpura ที่ขาและก้น + ปวดข้อ + ปวดท้อง + ไตอักเสบ — ไตเป็นตัวกำหนดพยากรณ์โรค ต้องตรวจปัสสาวะและความดันเป็นระยะหลายเดือน

ต่อยอดจาก MED32 โปย purpura (เขียนใหม่เป็นตัวเลือก)

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(2)** Allergic purpura (Henoch-Schonlein purpura) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.2.2-3(2b)** Vasculitis syndrome (e.g., Kawasaki disease, polyarteritis nodosa, drug induced) (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 27
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56

A 56-year-old man with chronic sinusitis and bloody nasal discharge develops hemoptysis, cavitating lung nodules and glomerulonephritis with red cell casts. Which antibody is most likely to be positive?

- A. Anti-glomerular basement membrane antibody
- B. Anti-proteinase 3 (c-ANCA)**
- C. Anti-centromere antibody
- D. Anti-double-stranded DNA
- E. Anti-mitochondrial antibody

ตอบ B

ทางเดินหายใจส่วนบน + ปอดเป็นโพรง + ไตอักเสบ = **granulomatosis with polyangiitis → c-ANCA (anti-PR3)**; anti-GBM (Goodpasture) ไม่เข้าไซนัสและไม่ทำให้เกิดโพรงในปอด; SLE จะมี complement ต่ำและอาการหลายระบบอื่น — เป็น **pulmonary-renal syndrome** ที่ต้องรีบให้สเตียรอยด์ขนาดสูงร่วมกับ rituximab หรือ cyclophosphamide

ต่อยอดจาก MED34 โปย vasculitis (เขียนใหม่เป็นตัวเลือก)

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.2-3(2b)** Vasculitis syndrome (e.g., Kawasaki disease, polyarteritis nodosa, drug induced) (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13-3(16)** Vasculitis syndrome (Kawasaki disease, polyarteritis nodosa, drug-induced) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

Which conventional DMARD is the anchor drug for newly diagnosed rheumatoid arthritis, and how is it given?

- A. Prednisolone 10 mg daily as monotherapy
- B. Methotrexate, given once weekly with folic acid supplementation**
- C. Allopurinol 100 mg daily
- D. Colchicine 0.6 mg twice daily
- E. Methotrexate, given once daily with folic acid

ตอบ B

Methotrexate สัปดาห์ละครั้ง (การสั่งเป็นทุกวันเป็นความผิดพลาดที่ทำให้เกิด pancytopenia และเสียชีวิตได้) ร่วมกับ **folic acid** เพื่อลดแผลในปากและพิษต่อดับ; ติดตาม CBC, LFT, creatinine; ห้ามในหญิงตั้งครรภ์; สเตียรอยด์ใช้เป็นสะพานระยะสั้นเท่านั้น

ต่อยอดจาก MED33 โปย RA treatment (เขียนใหม่เป็นตัวเลือก)

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.4(3)** Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28
- **NL 2.3.13-3(12)** Rheumatoid arthritis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

Before starting an anti-TNF biologic agent in rheumatoid arthritis, which screening is mandatory?

- A. Latent tuberculosis (chest radiograph plus tuberculin skin test or IGRA) and hepatitis B and C serology**
- B. Thyroid function test only
- C. Echocardiography in all patients only
- D. Serum uric acid and synovial fluid analysis
- E. Bone mineral density only

ตอบ A

Anti-TNF ทำให้ **latent TB** กำเริบเป็นวัณโรคแพร่กระจาย และทำให้ไวรัสตับอักเสบบี **reactivate** จนตับวาย จึงต้องคัดกรองก่อนเสมอ; นอกจากนี้ต้องประเมินการติดเชื้อที่ยังรักษาไม่หาย ประวัติมะเร็ง และภาวะหัวใจล้มเหลว (anti-TNF ทำให้แย่ลง) และควรฉีดวัคซีนเชื้อตายให้ครบก่อนเริ่มยา

ต่อยอดจาก MED34 โปย biologic therapy (เขียนใหม่เป็นตัวเลือก)

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.4(3)** Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28
- **NL 2.3.3-3(5)** Immune deficiency states (neutropenia, asplenia/splenic dysfunction, post-chemotherapy) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61
- **NL 2.3.13-3(12)** Rheumatoid arthritis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

A 34-year-old woman with SLE on long-term high-dose prednisolone develops progressive right groin pain on weight bearing. Hip radiograph is normal. What is the most appropriate next investigation?

- A. Hip joint aspiration
- B. Serum uric acid
- C. Repeat plain radiograph in 3 months
- D. MRI of both hips**
- E. Bone mineral density

ตอบ D

Osteonecrosis ของหัวกระดูกต้นขาจากสเตียรอยด์ — พัลส์ธรรมดาปกติในระยะแรกเสมอ **MRI** ไวที่สุดและต้องถ่ายทั้งสองข้าง เพราะเป็นสองข้างได้ 50-80%; ถ้าจับได้ก่อนหัวกระดูกยุบยังมีทางรักษาข้อไว้ได้

ต่อยอดจาก MED32 โปยภาวะแทรกซ้อนของสเตียรอยด์ (เขียนใหม่เป็นตัวเลือก)

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(8)** Osteonecrosis (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

A 27-year-old man has chronic low back pain that improves with exercise, wakes him in the early morning, with morning stiffness of 1 hour and a past episode of acute anterior uveitis. What is the most likely diagnosis?

- A. Mechanical low back pain
- B. Lumbar disc herniation
- C. Axial spondyloarthritis (ankylosing spondylitis)**
- D. Vertebral compression fracture
- E. Fibromyalgia

ตอบ C

Inflammatory back pain: อายุน้อยกว่า 45, ค่อยเป็นค่อยไป, ดีขึ้นเมื่อขยับ แย่ลงเมื่อพัก, ตื่นกลางดึกช่วงครึ่งหลัง, ฝืดเช้า > 30 นาที + **uveitis** ซึ่งเป็นอาการนอกข้อที่พบบ่อยที่สุด (สัมพันธ์กับ HLA-B27); รักษาด้วย ออกกำลังกาย + **NSAID** เต็มขนาด และ anti-TNF/anti-IL-17 เมื่อไม่ตอบสนอง — **methotrexate** ไม่ได้ผลกับโรคแกนกลาง

ต่อยอดจาก MED31 โปย ankylosing spondylitis (เขียนใหม่เป็นตัวเลือก)

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.2.2-3(3)** Spondyloarthropathies (e.g., ankylosing spondylitis, reactive arthritis) (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 26
- **NL 2.3.13-3(13)** Spondyloarthropathies (ankylosing spondylitis, reactive arthritis) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL 2.1.26** ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก (musculoskeletal pain) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55

A 68-year-old woman has 2 months of bilateral shoulder and hip girdle aching with prolonged morning stiffness, ESR 88 mm/hr, normal creatine kinase and no true weakness on testing. What is the most likely diagnosis and treatment?

- A. Polymyositis; high-dose prednisolone plus methotrexate
- B. Hypothyroid myopathy; levothyroxine
- C. Fibromyalgia; exercise and amitriptyline
- D. Osteoarthritis of both shoulders; NSAID
- E. **Polymyalgia rheumatica; low-dose prednisolone 12.5-25 mg daily with a dramatic response expected**

ตอบ E

PMR: ปวดเมื่อยไหล่และสะโพกสองข้าง ผิดเข้านาน **ESR** สูงมาก แต่ **CK** ปกติและไม่มีอ่อนแรงจริง (ขยับไม่ไหวเพราะเจ็บ ไม่ใช่แรงตก) — ตอบสนองต่อ prednisolone ขนาดต่ำอย่างรวดเร็วภายใน 24-72 ชั่วโมง (ถ้าไม่ตอบสนองให้ทบทวนการวินิจฉัย); ต้องถามอาการของ **giant cell arteritis** ทุกครั้ง เพราะพบร่วมกันได้ ~15%

ต่อยอดจาก MED32 โปย PMR/GCA (เขียนใหม่เป็นตัวเลือก)

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.1.26** ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก (musculoskeletal pain) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL B5.2.2-3(2b)** Vasculitis syndrome (e.g., Kawasaki disease, polyarteritis nodosa, drug induced) (กลุ่มที่ 3) — B5.2.2 Infectious/inflammatory/immunologic disorders หน้า 27
- **NL 2.3.13-3(16)** Vasculitis syndrome (Kawasaki disease, polyarteritis nodosa, drug-induced) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

A patient with rheumatoid arthritis on methotrexate develops fever, dry cough and diffuse interstitial infiltrates with leukopenia. What should be done first?

- A. **Stop methotrexate and evaluate for both opportunistic infection and drug-induced pneumonitis**
- B. Add an NSAID and observe
- C. Increase the methotrexate dose for a presumed flare
- D. Give folic acid and continue the same dose
- E. Start an anti-TNF agent immediately

ตอบ A

หยุด **methotrexate** ทันที แล้วแยกสองภาวะที่ต้องหยุดยาทั้งคู่: **methotrexate pneumonitis** กับ การติดเชื้อฉวยโอกาส (**PCP, TB, เชื้อรา**) ให้ยาปฏิชีวนะครอบคลุมจนกว่าจะตัดการติดเชื้อออก และให้ **folic acid** เมื่อมี cytopenia ชัดเจน — ห้ามเริ่ม **biologic** ขณะสงสัยติดเชื้อ

ต่อยอดจาก MED34 โปย methotrexate toxicity (เขียนใหม่เป็นตัวเลือก)

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.4(3)** Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28
- **NL 2.3.3-3(5)** Immune deficiency states (neutropenia, asplenia/splenic dysfunction, post-chemotherapy) (กลุ่มที่ 3) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 61

Which antibody pattern is most specific for systemic lupus erythematosus?

- A. Anti-Smith and anti-double-stranded DNA**
- B. Anti-Jo-1 and anti-Mi-2
- C. Anti-mitochondrial and anti-smooth muscle
- D. Rheumatoid factor and anti-CCP
- E. Anti-Scl-70 and anticentromere

ตอบ A

ANA คือการคัดกรอง (ไวแต่ไม่จำเพาะ) ส่วน **anti-Sm** และ **anti-dsDNA** คือการยืนยัน (จำเพาะสูง); anti-CCP สำหรับ RA, Scl-70/centromere สำหรับ systemic sclerosis, Jo-1/Mi-2 สำหรับ inflammatory myopathy, anti-mitochondrial สำหรับ primary biliary cholangitis

ต่อยอดจาก MED34 โปย MCQ ข้อ 34 (ANA) เขียนใหม่เป็นตัวเลือก

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL B5.3(5)** Serologic studies: antinuclear antibody (ANA), rheumatoid factor — B5.3 การสืบค้นโรคและการแปลผล หน้า 28
- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67

A woman with SLE and lupus nephritis wishes to become pregnant. Which drug must be stopped and replaced before conception?

- A. Calcium and vitamin D supplements
- B. Prednisolone, stopped completely
- C. Mycophenolate mofetil, replaced by azathioprine**
- D. Low-dose aspirin, stopped without replacement
- E. Hydroxychloroquine, replaced by no alternative

ตอบ C

Mycophenolate เป็น **teratogen** ต้องหยุดอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนตั้งครรภ์ และเปลี่ยนเป็น **azathioprine** (เช่นเดียวกับ cyclophosphamide, methotrexate, ACEI/ARB ที่ต้องหยุด); **hydroxychloroquine** ต้องใช้ต่อ เพราะลด flare และลดความเสี่ยง congenital heart block; **low-dose aspirin** ควรให้ เพื่อลด preeclampsia; และควรตั้งครรภ์เมื่อโรคสงบอย่างน้อย 6 เดือน

ต่อยอดจาก MED34 โปย SLE in pregnancy (เขียนใหม่เป็นตัวเลือก)

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13-3(15)** Systemic lupus erythematosus (กลุ่มที่ 3) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 67
- **NL B5.4(3)** Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) — B5.4 หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หน้า 28

A 28-year-old woman has daily evening fever for 3 weeks, an evanescent salmon-coloured rash, sore throat, arthralgia, neutrophilic leukocytosis and ferritin 8,000 ng/mL, with negative ANA, RF and blood cultures. What is the most likely diagnosis?

- A. **Adult-onset Still disease**
- B. Systemic lupus erythematosus
- C. Infective endocarditis
- D. Lymphoma
- E. Rheumatoid arthritis

ตอบ **A**

ไข้รายวัน + ผื่นสีปลาแซลมอนที่มาพร้อมไข้ + เจ็บคอ + เม็ดเลือดขาวสูงชนิด **neutrophil + ferritin** สูงมาก + **ANA/RF** ลบ = **adult-onset Still disease** ซึ่งเป็นการวินิจฉัยแบบตัดโรคอื่นออก (ต้องตัดการติดเชื้อ โดยเฉพาะ endocarditis และวัณโรค กับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองออกก่อน); ระวังภาวะแทรกซ้อน **macrophage activation syndrome** เมื่อเม็ดเลือดต่ำลงทุกซีรีส์และ ferritin พุ่งขึ้นอีก

ต่อยอดจาก MED34 โปทย์ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (เขียนใหม่เป็นตัวเลือก)

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.1.1** ไข้ (fever) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL 2.1.27** ปวดข้อ ข้อฝืด ข้อติด (joint pain, stiff joint, frozen joint) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 55
- **NL 2.1.50** ผื่นผิวหนัง (skin rash and lesions) — 2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ หน้า 56